

Buku Referensi

PERAN BIDAN DALAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Hilmi Yumni • Febrina Dwi Nurcahyanti • Asmaurika Pramuwidya
Dona Martilova • Siti Aminah • Diyah Sri Yuhandini
Norma Jeepi Margiyanti



BUKU REFERENSI PERAN BIDAN DALAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Dr. Hilmi Yumni, S.Kep.Ns.M.Kep.Sp.Mat.

Febrina Dwi Nurcahyanti, SST.,MPH

Asmaurika Pramuwidya, S.S.T., M.Kes.

Dr. Dona Martilova SST.M.Kes

Siti Aminah, SST., S.Pd., Bd., M.Kes

Diyah Sri Yuhandini, S.SiT, SKM, MPd

Bdn. Norma Jeepi Margiyanti, S.Si.T., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAN BIDAN DALAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Penulis: Dr. Hilmi Yumni, S.Kep.Ns.M.Kep.Sp.Mat.

Febrina Dwi Nurcahyanti, SST., MPH

Asmaurika Pramuwidya, S.S.T., M.Kes.

Dr. Dona Martilova SST.M.Kes

Siti Aminah, SST., S.Pd., Bd., M.Kes

Diyah Sri Yuhandini, S.SiT, SKM, MPd

Bdn. Norma Jeepi Margiyanti, S.SiT., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-96029-8-3

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi ini yang berjudul **“Peran Bidan dalam Kesehatan Reproduksi Remaja”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan dan pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya pada kelompok usia remaja yang merupakan masa transisi krusial dalam kehidupan manusia.

Kesehatan reproduksi remaja telah menjadi isu yang semakin penting di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi. Remaja sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya akses terhadap informasi yang benar dan terbuka mengenai kesehatan reproduksi, meningkatnya risiko perilaku seksual berisiko, serta kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat. Dalam konteks ini, peran bidan menjadi sangat vital, tidak hanya sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, dan agen perubahan di masyarakat.

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang membahas berbagai aspek penting dalam peran bidan terkait kesehatan reproduksi remaja. Bab pertama mengangkat pentingnya edukasi kepada remaja sebagai langkah awal membangun pemahaman yang benar mengenai tubuh dan hak-hak reproduksi. Bab kedua membahas pendekatan konseling yang tepat dan sensitif terhadap kebutuhan psikologis remaja. Bab ketiga dan keempat menyajikan strategi berbasis komunitas dan edukasi pencegahan penyakit menular seksual sebagai langkah konkret dalam membangun ketahanan remaja terhadap risiko kesehatan.

Selanjutnya, bab kelima menyoroti pentingnya dukungan keluarga yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan perilaku sehat remaja. Bab keenam mengeksplorasi pemanfaatan media digital yang kian relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Terakhir, bab ketujuh menyajikan program edukasi di lingkungan sekolah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan acuan yang bermanfaat bagi para bidan, mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, pendidik, serta semua pihak yang peduli terhadap kesehatan reproduksi remaja. Semoga karya ini juga dapat menginspirasi terciptanya intervensi yang lebih luas, inovatif, dan kolaboratif demi terwujudnya generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Penyusun menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI REMAJA TENTANG PENTINGNYA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA..	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perkembangan Fisik dan Psikologis Remaja	1
C. Sistem Reproduksi dan Fungsi Dasarnya.....	4
D. Penyakit Menular Seksual dan Dampaknya.....	6
E. Kehamilan Usia Remaja dan Konsekuensinya.....	8
F. Peran Pendidikan dan Kesadaran Diri dalam Kesehatan Reproduksi Remaja	10
G. Tantangan Utama yang Dihadapi Remaja.....	11
H. Penutup	12
Referensi	13
BAB II PENDEKATAN BIDAN DALAM KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI	16
A. Pendahuluan.....	16
B. Pendekatan Konseling Behavior.....	18
C. Pendekatan Konseling secara Holistik	19
D. Pendekatan Konseling secara Komprehensif	22
E. Pendekatan Konseling secara Online	25
F. Pendekatan Konseling secara Yuridis Sosiologis.....	26
G. Penutup	27
Referensi	29
BAB III STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Konsep Strategi Berbasis Komunitas dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi	34
C. Model-model Intervensi Komunitas untuk Kesadaran Kesehatan Reproduksi Remaja...	36
D. Peran Bidan dalam Mengembangkan Strategi Berbasis Komunitas	38
E. Pendekatan Peer Education dalam Komunitas.....	39
F. Pemanfaatan Media Sosial dan Digitalisasi dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi di Komunitas.....	41
G. Strategi Keterlibatan Keluarga dan Tokoh Masyarakat dalam Edukasi Remaja.....	43
H. Monitoring dan Evaluasi Program Edukasi Berbasis Komunitas.....	44
I. Studi Kasus Program Berbasis Komunitas di Indonesia dan Dunia	46
J. Penutup	48
Referensi	50
BAB IV EDUKASI TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL	52
A. Pendahuluan.....	52
B. Peran Bidan dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	53
C. Faktor Risiko dan Perilaku Berisiko PMS pada Remaja	55
D. Metode Pencegahan PMS pada Remaja.....	56
E. Media dan Alat Bantu Edukasi Pencegahan PMS bagi Remaja	58
F. Pendekatan Budaya dalam Edukasi Pencegahan PMS pada Remaja	60
G. Tantangan dan Hambatan dalam Edukasi Pencegahan PMS pada Remaja.....	61

H. Evaluasi Efektivitas Program Edukasi Pencegahan PMS oleh Bidan.....	63
I. Penutup.....	65
Referensi	67
BAB V DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Tujuan Kesehatan Reproduksi	69
C. Hak-hak Kesehatan Reproduksi	70
D. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	72
E. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	75
F. Definisi dan Fungsi Keluarga.....	76
G. Dukungan Keluarga dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja.....	81
H. Penutup.....	88
Referensi	89
BAB VI PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL UNTUK KAMPANYE KESEHATAN REPRODUKSI	91
A. Pendahuluan.....	91
B. Alasan Media Digital Efektif untuk Kampanye Kesehatan Reproduksi Remaja	92
C. Strategi Merancang Kampanye Kesehatan Reproduksi Digital yang Efektif.....	107
D. Memanfaatkan Fitur Interaktif Media Digital untuk Keterlibatan Remaja	122
E. Pertimbangan Etis dan Keamanan dalam Kampanye Digital untuk Remaja.....	130
F. Studi Kasus Kampanye Kesehatan Reproduksi Digital ("Aku Bertanya")	136
G. Penutup.....	137
Referensi	139
BAB VII PROGRAM SEKOLAH DALAM MENDUKUNG EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI	151
A. Pendahuluan	151
B. Kesehatan Reproduksi Remaja	151
C. Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja	153
D. Program Edukasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah	156
E. Penutup.....	159
Referensi	160
Profil Penulis	161
Sinopsis Buku	165

BAB I

EDUKASI REMAJA TENTANG PENTINGNYA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya (WHO, 2022). Hal ini mencakup tidak hanya ketiadaan penyakit atau gangguan, tetapi juga kemampuan individu untuk menjalani kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, serta memiliki kapasitas untuk bereproduksi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai kesehatan reproduksinya (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Menurut Nofalia et al. (2024), pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi remaja sangat penting karena masa remaja merupakan fase transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Kurangnya pemahaman dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi menular seksual (IMS) dan kehamilan tidak diinginkan.

Edukasi kesehatan reproduksi yang diberikan sejak dini memiliki peran penting dalam membekali remaja dengan informasi yang akurat mengenai fungsi dan proses sistem reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi yang baik dapat membantu remaja dalam memahami perubahan fisik dan emosional selama pubertas, serta risiko yang terkait dengan perilaku seksual yang tidak aman (Galbinur, Defitra, & Venny, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang benar dapat menyebabkan perilaku seksual berisiko tinggi pada remaja, yang berkontribusi terhadap tingginya angka kehamilan remaja dan penyebaran infeksi menular seksual (Columbia Asia Hospital, 2025). Oleh karena itu, edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif harus diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman remaja dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi (Fakultas Kedokteran UGM, 2023).

B. Perkembangan Fisik dan Psikologis Remaja

Masa remaja merupakan periode transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh aktivitas hormonal yang

memengaruhi pertumbuhan tubuh serta perkembangan emosi dan perilaku. Pemahaman yang mendalam mengenai perubahan ini sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka beradaptasi dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya.

1. Perubahan Fisik dan Hormon saat Pubertas

Pubertas adalah fase di mana tubuh anak mengalami perubahan hormon yang berkaitan dengan kematangan organ reproduksi. Pada anak perempuan, pubertas biasanya dimulai antara usia 8–13 tahun, sementara pada anak laki-laki antara usia 10–16 tahun (Hello Sehat, 2025)

Perubahan pada Anak Perempuan:

- a. Pertumbuhan Payudara: Merupakan tanda awal pubertas pada perempuan, dimulai dengan benjolan kecil di bawah puting yang kemudian berkembang seiring waktu.
- b. Menstruasi Pertama (Menarche): Biasanya terjadi sekitar usia 12–13 tahun, menandakan bahwa sistem reproduksi telah berfungsi penuh.
- c. Pertumbuhan Rambut: Munculnya rambut di area kemaluan, ketiak, dan kaki.

Perubahan pada Anak Laki-Laki:

- a. Pembesaran Testis dan Penis: Dimulai sekitar usia 11–12 tahun, menandakan awal dari kematangan seksual.
- b. Perubahan Suara: Suara menjadi lebih dalam akibat pertumbuhan kotak suara (laring).
- c. Pertumbuhan Rambut: Munculnya rambut di wajah, ketiak, dan area kemaluan.

Perubahan-perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap peningkatan hormon seks, seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki, yang diproduksi oleh kelenjar reproduksi dan diatur oleh kelenjar pituitari di otak (Disdukbbpppa Badung, 2025).

2. Perubahan Emosi dan Psikologis yang Memengaruhi Perilaku dan Keputusan Remaja

Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami perubahan signifikan dalam aspek emosional dan psikologis. Produksi hormon testosteron dan estrogen tidak hanya memengaruhi perkembangan fisik, tetapi juga fungsi otak, emosi, dorongan seksual, dan perilaku remaja (IDAI, 2025).

a. Perubahan Emosional:

- 1) Fluktuasi Mood: Remaja sering mengalami perubahan suasana hati yang cepat akibat perubahan hormonal.

- 2) Sensitivitas Tinggi: Remaja menjadi lebih peka terhadap pandangan dan pendapat orang lain, terutama teman sebaya.
- 3) Pencarian Identitas Diri: Masa remaja ditandai dengan upaya mencari jati diri dan kemandirian, yang kadang menimbulkan konflik internal dan dengan lingkungan sekitar.

b. Perubahan Perilaku:

- 1) Pengaruh Teman Sebaya: Kelompok sebaya memiliki peran besar dalam membentuk perilaku dan keputusan remaja.
- 2) Eksperimen dan Rasa Ingin Tahu: Dorongan untuk mencoba hal-hal baru dapat membawa remaja pada perilaku berisiko jika tidak diarahkan dengan baik.
- 3) Perubahan Minat dan Nilai: Apa yang dianggap penting pada masa kanak-kanak mungkin berubah seiring dengan perkembangan kognitif dan sosial remaja.

Perubahan-perubahan ini dapat menyebabkan remaja merasa bingung atau cemas. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat diperlukan untuk membantu mereka melalui masa transisi ini dengan sehat dan positif.

3. Pentingnya Pemahaman Diri dalam Menghadapi Perubahan Ini

Pemahaman diri yang baik membantu remaja mengenali dan mengelola perubahan yang mereka alami. Dengan memahami bahwa perubahan fisik dan emosional adalah bagian normal dari perkembangan, remaja dapat:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Diri: Mengetahui bahwa perubahan yang dialami adalah normal dapat mengurangi rasa malu atau rendah diri.
- b. Mengambil Keputusan yang Sehat: Pemahaman tentang konsekuensi dari berbagai perilaku membantu remaja membuat pilihan yang lebih bijaksana.
- c. Mengelola Emosi dengan Baik: Kesadaran akan fluktuasi emosi memungkinkan remaja untuk mencari cara-cara positif dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya .

Dukungan dari orang tua, guru, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam proses ini. Edukasi mengenai perubahan selama masa pubertas dan keterbukaan dalam komunikasi dapat membantu remaja merasa didukung dan dipahami, sehingga mereka dapat melalui masa ini dengan lebih percaya diri dan sehat.

C. Sistem Reproduksi dan Fungsi Dasarnya

Sistem reproduksi manusia terdiri dari serangkaian organ dan struktur yang bekerja secara harmonis untuk memastikan kelangsungan hidup spesies melalui proses reproduksi. Pemahaman tentang anatomi dan fungsi dasar sistem reproduksi, serta cara menjaga kesehatannya, sangat penting bagi setiap individu.

1. Anatomi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan secara ringkas

a. Sistem Reproduksi Laki-Laki

Sistem reproduksi laki-laki terutama berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengantarkan sperma ke sistem reproduksi perempuan. Organ-organ utamanya meliputi:

- 1) Testis: Dua kelenjar berbentuk oval yang terletak dalam skrotum. Testis memproduksi sperma dan hormon testosteron.
- 2) Epididimis: Saluran panjang yang melingkar di atas testis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma.
- 3) Vas deferens: Saluran yang menghubungkan epididimis ke uretra, mengantarkan sperma saat ejakulasi.
- 4) Kelenjar Prostat dan Vesikula Seminalis: Menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen, yang menyediakan nutrisi dan medium bagi sperma.
- 5) Penis: Organ eksternal yang mengantarkan semen ke dalam saluran reproduksi perempuan selama hubungan seksual.

b. Sistem Reproduksi Perempuan

Sistem reproduksi perempuan berperan dalam produksi sel telur, tempat pembuahan, dan perkembangan janin. Komponen utamanya meliputi:

- 1) Ovarium: Dua kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur (ovum) dan hormon seks seperti estrogen dan progesteron.
- 2) Tuba Falopi: Dua saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma.
- 3) Rahim (Uterus): Organ berongga berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat perkembangan janin selama kehamilan.
- 4) Serviks: Bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks menghasilkan lendir yang memfasilitasi atau menghalangi masuknya sperma, tergantung pada siklus menstruasi.
- 5) Vagina: Saluran muskular yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh, berfungsi sebagai jalan lahir dan saluran untuk keluarnya darah menstruasi.

2. Fungsi organ reproduksi dan siklus menstruasi

a. Fungsi Organ Reproduksi

Setiap organ dalam sistem reproduksi memiliki peran spesifik:

- 1) Testis: Memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada laki-laki.
- 2) Ovarium: Menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan.
- 3) Tuba Falopi: Menjadi tempat pembuahan dan mengantarkan sel telur atau embrio ke rahim.
- 4) Rahim: Menjadi tempat implantasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan.
- 5) Serviks: Menghasilkan lendir serviks yang memfasilitasi atau menghalangi masuknya sperma, serta membuka selama persalinan untuk memungkinkan kelahiran bayi.
- 6) Vagina: Berfungsi sebagai saluran untuk hubungan seksual, keluarnya darah menstruasi, dan jalan lahir saat persalinan.

b. Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan, biasanya berlangsung sekitar 28 hari.

Tahapan utama siklus menstruasi meliputi:

- 1) Menstruasi: Pelepasan lapisan dalam rahim (endometrium) yang keluar sebagai darah menstruasi jika tidak terjadi pembuahan.
- 2) Fase Folikular: Pematangan beberapa folikel di ovarium, dengan satu folikel dominan yang akan melepaskan sel telur.
- 3) Ovulasi: Pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba falopi, biasanya terjadi sekitar hari ke-14.
- 4) Fase Luteal: Pembentukan korpus luteum dari folikel yang pecah, yang menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan rahim menerima embrio. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan degenerasi, menyebabkan penurunan hormon dan memicu menstruasi.

3. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi (higiene, pola makan, gaya hidup sehat)

Menjaga kesehatan organ reproduksi penting untuk mencegah berbagai penyakit dan memastikan fungsi reproduksi berjalan optimal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Higiene: Membersihkan area genital secara rutin dengan air bersih, mengganti pakaian dalam minimal dua kali sehari, dan bagi perempuan, mengganti pembalut secara teratur selama menstruasi untuk mencegah infeksi.
- b. Pola Makan Sehat: Mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk mendukung fungsi hormonal dan kesehatan reproduksi.

- c. Gaya Hidup Sehat: Menghindari perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan berganti-ganti pasangan seksual. Selain itu, rutin berolahraga dan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala.

Dengan memahami anatomi dan fungsi sistem reproduksi serta menerapkan pola hidup sehat, individu dapat menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah berbagai masalah yang mungkin timbul.

D. Penyakit Menular Seksual dan Dampaknya

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah infeksi yang ditularkan melalui aktivitas seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap PMS karena faktor seperti kurangnya edukasi seksual, perilaku seksual berisiko, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Pemahaman mengenai jenis-jenis PMS, cara penularan, gejala, serta pencegahannya sangat penting untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja.

1. Jenis-jenis PMS yang sering terjadi pada remaja (HIV/AIDS, sifilis, gonore, HPV)
 - a. Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS):

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4. Infeksi HIV yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga rentan terhadap infeksi oportunistik. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. Gejala awal HIV seringkali tidak spesifik, seperti demam, sakit tenggorokan, dan ruam, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi.

- b. Sifilis:

Sifilis disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*. Penyakit ini berkembang melalui beberapa tahap: primer, sekunder, laten, dan tersier. Gejala awalnya berupa luka tidak nyeri (chancre) di tempat masuknya bakteri, seperti alat kelamin, anus, atau mulut. Jika tidak diobati, sifilis dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh lainnya.

- c. Gonore:

Gonore, atau kencing nanah, disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Infeksi ini dapat menyerang uretra, leher rahim, rektum, dan tenggorokan. Gejala pada pria meliputi keluarnya cairan kental berwarna putih, kuning, atau hijau dari penis dan nyeri saat buang air kecil. Pada wanita, gejalanya seringkali ringan atau tidak ada, tetapi dapat mencakup keputihan abnormal dan perdarahan antar periode menstruasi.

- d. Human Papillomavirus (HPV):

HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. Ada banyak tipe HPV, dan beberapa di antaranya berisiko tinggi menyebabkan kanker. Infeksi HPV seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga individu dapat menularkan virus tanpa disadari.

2. Cara penularan dan gejala yang perlu diwaspadai

a. Cara Penularan:

- 1) Kontak Seksual: Sebagian besar PMS ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman dengan seseorang yang terinfeksi. Ini mencakup kontak vaginal, anal, dan oral.
- 2) Kontak Non-Seksual: Beberapa PMS dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik bersama, transfusi darah yang terkontaminasi, atau dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.

b. Gejala yang Perlu Diwaspadai:

- 1) Luka atau Benjolan pada Area Genital, Anus, atau Mulut: Munculnya luka, ruam, atau benjolan yang tidak biasa.
- 2) Keputihan Abnormal: Pada wanita, keputihan dengan warna, bau, atau konsistensi yang tidak biasa.
- 3) Nyeri atau Sensasi Terbakar saat Buang Air Kecil: Gejala ini umum pada infeksi seperti gonore dan klamidia.
- 4) Perdarahan di Luar Siklus Menstruasi: Dapat menjadi tanda infeksi atau kondisi lain yang memerlukan perhatian medis.
- 5) Pembengkakan Kelenjar Getah Bening: Terutama di area selangkangan.

Penting untuk diingat bahwa beberapa PMS tidak menimbulkan gejala awal, sehingga pemeriksaan rutin sangat dianjurkan bagi individu yang aktif secara seksual.

3. Pencegahan PMS, termasuk peran vaksin (HPV) dan gaya hidup sehat

a. Penggunaan Kondom:

Kondom merupakan alat kontrasepsi yang efektif dalam mencegah penularan PMS jika digunakan dengan benar dan konsisten. Kondom berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah kontak langsung dengan cairan tubuh yang dapat menularkan infeksi.

b. Vaksinasi:

- 1) Vaksin HPV: Vaksin ini efektif dalam mencegah infeksi oleh beberapa tipe HPV yang berisiko tinggi menyebabkan kanker serviks dan kutil kelamin. Vaksinasi direkomendasikan bagi remaja sebelum mereka aktif secara seksual.

2) Vaksin Hepatitis B: Hepatitis B dapat ditularkan melalui kontak seksual. Vaksinasi hepatitis B telah menjadi bagian dari program imunisasi rutin di banyak negara dan efektif dalam mencegah infeksi.

c. Edukasi dan Kesadaran:

Pendidikan seksual yang komprehensif membantu remaja memahami risiko dan cara pencegahan PMS. Kesadaran akan pentingnya komunikasi dengan pasangan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam aktivitas seksual sangat penting.

d. Pemeriksaan Rutin

Melakukan tes PMS secara berkala membantu dalam deteksi dini dan pengobatan yang tepat waktu, mencegah komplikasi serius dan penularan lebih lanjut.

e. Gaya Hidup Sehat:

Menerapkan gaya hidup sehat merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah Penyakit Menular Seksual (PMS). Gaya hidup sehat mencakup berbagai aspek, seperti menjaga kebersihan diri, memiliki pola hidup yang disiplin, serta menghindari perilaku berisiko.

E. Kehamilan Usia Remaja dan Konsekuensinya

Kehamilan pada usia remaja merupakan isu krusial yang berdampak luas, baik secara medis, sosial, maupun psikologis. Pemahaman mengenai fakta kehamilan remaja di Indonesia, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahannya sangat penting untuk menekan angka kejadian dan meminimalkan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.

1. Fakta tentang Kehamilan Remaja di Indonesia

Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa persentase perempuan berusia 15-19 tahun yang sudah menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002-2003, angkanya mencapai 10,4%, menurun menjadi 8,5% pada 2007, meningkat kembali menjadi 9,5% pada 2012, dan turun menjadi 7,1% pada 2017 (BKKBN et al., 2018). Meskipun terdapat penurunan, angka ini masih mengkhawatirkan mengingat dampak yang ditimbulkan.

Studi lain mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, 16,5% remaja perempuan di Indonesia pernah hamil, dengan rincian 2,83% hamil di bawah usia 16 tahun dan 13,67% pada usia 17-18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Angka ini menunjukkan bahwa kehamilan remaja masih menjadi masalah signifikan di Indonesia.

2. Dampak Kehamilan di Usia Dini

a. Dampak Medis:

- 1) Komplikasi Kehamilan dan Persalinan: Remaja yang hamil berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti preeklamsia, anemia, dan persalinan prematur. Selain itu, risiko kematian ibu dan bayi juga meningkat pada kelompok usia ini (Kementerian PPPA, 2020).
- 2) Kesehatan Bayi: Bayi yang dilahirkan dari ibu remaja cenderung memiliki berat badan lahir rendah dan rentan terhadap berbagai masalah kesehatan.

b. Dampak Sosial:

- 1) Putus Sekolah: Kehamilan pada usia sekolah seringkali menyebabkan remaja putus sekolah, menghambat pencapaian pendidikan dan karier di masa depan.
- 2) Stigma Sosial: Remaja hamil, terutama yang belum menikah, kerap menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kesempatan kerja mereka.

c. Dampak Psikologis:

- 1) Depresi dan Kecemasan: Tekanan psikologis akibat kehamilan yang tidak direncanakan dapat memicu depresi, kecemasan, dan perasaan putus asa pada remaja (Husaeni, 2010).
- 2) Kurangnya Kesiapan Mental: Remaja umumnya belum siap secara mental untuk mengemban peran sebagai orang tua, yang dapat berdampak negatif pada pengasuhan anak dan kesejahteraan keluarga.

3. Pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan

a. Edukasi Seksual Komprehensif:

Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif di sekolah dan lingkungan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang risiko dan konsekuensi dari aktivitas seksual, serta pentingnya kontrasepsi.

b. Akses ke Layanan Kesehatan Reproduksi:

Memastikan remaja memiliki akses mudah dan rahasia ke layanan kesehatan reproduksi, termasuk konseling dan penyediaan alat kontrasepsi, sangat penting dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

c. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat:

Orang tua dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada remaja. Komunikasi terbuka mengenai topik kesehatan reproduksi dapat membantu remaja membuat keputusan yang bijak terkait aktivitas seksual.

b. Penggunaan Media Edukasi:

Pemanfaatan media, seperti video pembelajaran, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja mengenai pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (Kedaton & Aniarti, 2024).

F. Peran Pendidikan dan Kesadaran Diri dalam Kesehatan Reproduksi Remaja

Pendidikan seksual dan kesadaran diri merupakan komponen vital dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja. Peran aktif keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan dalam memberikan informasi yang akurat dan membangun komunikasi efektif sangat diperlukan untuk membentuk perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab.

1. Peran Pendidikan Seksual dalam Keluarga dan Sekolah

a. Pendidikan Seksual dalam Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi remaja dalam menerima pendidikan seksual. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua dan anak dapat mencegah perilaku seksual berisiko dan meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam komunikasi tentang masalah seksual dapat mencegah perilaku negatif terkait kesehatan reproduksi pada remaja (Bhatta et al., 2021).

b. Pendidikan Seksual di Sekolah

Sekolah berperan sebagai lembaga formal yang menyediakan pendidikan seksual terstruktur dan komprehensif. Implementasi kurikulum pendidikan seksual yang sesuai dengan perkembangan usia remaja dapat membantu mereka memahami aspek biologis, psikologis, dan sosial dari seksualitas. Pendidikan seksual di sekolah juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap perilaku seksual berisiko dan kekerasan seksual. Pemahaman yang tepat tentang seks dan seksualitas dapat menjadi benteng bagi remaja dari pelecehan dan kekerasan seksual, serta paparan negatif dari media digital (Muchlis & Nurjannah, 2022).

2. Pentingnya Komunikasi antara Remaja, Orang Tua, dan Tenaga Kesehatan

Komunikasi yang efektif antara remaja, orang tua, dan tenaga kesehatan merupakan kunci dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja. Orang tua diharapkan dapat menjadi sumber informasi pertama yang terpercaya bagi anak-anak mereka. Namun, seringkali topik kesehatan reproduksi dianggap tabu, sehingga menghambat komunikasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi dua arah yang terbuka dan

nyaman, sehingga remaja merasa didukung dan tidak ragu untuk berdiskusi mengenai masalah kesehatan reproduksi (Cahyani et al., 2021).

Selain itu, tenaga kesehatan memiliki peran dalam memberikan edukasi dan konseling kepada remaja dan orang tua mengenai kesehatan reproduksi. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, serta layanan kesehatan yang dibutuhkan.

G. Tantangan Utama yang Dihadapi Remaja

Meskipun edukasi kesehatan reproduksi sangat penting, remaja sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses informasi dan layanan yang diperlukan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

1. Kurangnya Informasi

Banyak remaja tidak memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan program pendidikan yang memadai di sekolah dan minimnya kampanye kesehatan reproduksi di masyarakat (Panda.id, 2024). Beberapa remaja bahkan mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid seperti media sosial, yang dapat menyesatkan mereka dalam memahami kesehatan reproduksi.

2. Mitos dan Stigma

Topik kesehatan reproduksi sering kali dianggap tabu dalam masyarakat, sehingga banyak mitos dan kesalahpahaman yang berkembang. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2023), stigma sosial dapat menghalangi remaja untuk mencari informasi atau bantuan yang mereka butuhkan, karena takut akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak remaja yang enggan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau berbicara dengan orang tua mereka.

3. Kurangnya Komunikasi dengan Orang Tua dan Guru

Komunikasi terbuka antara remaja dengan orang tua atau guru mengenai kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan. Menurut Universitas Negeri Gorontalo (2023), banyak orang tua merasa canggung atau kurang memiliki pengetahuan yang memadai untuk membahas topik ini. Hal ini menyebabkan remaja mencari informasi dari teman sebaya atau internet, yang tidak selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat.

Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah. Peningkatan akses terhadap edukasi kesehatan reproduksi berbasis

sains dan nilai budaya akan membantu remaja dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait kesehatan reproduksi mereka (Universitas Ahmad Dahlan, 2022).

H. Penutup

Pendidikan seksual yang komprehensif dan komunikasi yang efektif antara remaja, orang tua, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja. Untuk itu, direkomendasikan agar:

1. Orang Tua:

Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan membuka ruang dialog yang nyaman dengan anak-anak mereka.

2. Sekolah:

Mengintegrasikan pendidikan seksual ke dalam kurikulum dengan materi yang sesuai usia dan budaya, serta melibatkan tenaga pendidik yang kompeten.

3. Tenaga Kesehatan:

Memberikan layanan konseling dan edukasi yang ramah remaja, serta bekerja sama dengan keluarga dan sekolah dalam program kesehatan reproduksi.

Dengan sinergi antara keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan, diharapkan remaja dapat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka secara bijak dan bertanggung jawab.

Referensi

- Alodokter. (2023). Memahami Sistem Reproduksi pada Manusia. Diakses dari <https://www.alodokter.com/memahami-sistem-reproduksi-pada-manusia>
- Bhatta, M. P., et al. (2021). Peran komunikasi orang tua dan remaja terhadap perilaku kesehatan reproduksi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 86-94.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Presentase remaja yang pernah hamil. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), & Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Columbia Asia Hospital. (2025, Februari). Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Anak Sedingin Mungkin. Diakses dari <https://columbiaasia.co.id/artikel/kesehatan/edukasi-kesehatan-reproduksi-untuk-anak/>
- Cahyani, K. A., et al. (2021). Hubungan pola komunikasi orang tua asuh dengan pengetahuan dan sikap kesehatan reproduksi remaja panti asuhan Kabupaten Klaten tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(1), 15-25.
- Disdukbbpppa Badung. (2025). Perubahan Pubertas. Diakses dari <https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/artikel/17994-perubahan-pubertas>
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. (2023, Februari). Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja. Diakses dari <https://fkkmk.ugm.ac.id/pentingnya-edukasi-kesehatan-reproduksi-untuk-remaja/>
- Galbinur, E., Defitra, M. A., & Venny. (2021). Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja di Era Modern. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 221-226.
- Husaeni, U. (2010). Dampak psikologis kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Diakses dari <https://repository.unair.ac.id>
- Hello Sehat. (2025). Pubertas: Definisi, Ciri-Ciri, dan Gangguan. Diakses dari <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-remaja/ciri-pubertas/>
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2025). Masalah Kesehatan Mental Emosional Remaja. Diakses dari <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/masalah-kesehatan-mental-emosional-remaja>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi Remaja pada Krisis Kesehatan. Diakses dari

- https://pusatkrisis.kemkes.go.id/download/dmfpb/files99053Pedoman_Pelaksanaan_PPAM_Kespro_Remaja_Pada_Krisis_Kesehatan.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Bagi Para Remaja, Kenali Perubahan Fisik untuk Menghindari Masalah Seksual. Diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20181219/2228898/bagi-para-remaja-kenali-perubahan-fisik-menghindari-masalah-seksual/>
- Kedaton, Y. K., & Aniarti, R. P. (2024). Pengaruh edukasi media video pembelajaran terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan di SMK N 1 Kutasari. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 5983-5992. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/download/32978/25187>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). (2020). Dampak kehamilan usia remaja. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Muchlis, E., & Nurjannah, S. (2022). Peran pendidikan seksual sebagai preventif dalam perlindungan anak usia dini dari kejahatan seksual. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 114-125.
- Nofalia, I., Suhendra, S., Ramazza, E., & Kawati, D. (2024). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja menggunakan Metode Comprehensive Sexuality Education (CSE). *Community Development and Reinforcement Journal*, 3(2), 43-53.
- Panda.id. (2024, November). Membangun Kemandirian Kesehatan Reproduksi: Pentingnya Edukasi bagi Generasi Muda di Desa. Diakses dari <https://www.panda.id/membangun-kemandirian-kesehatan-reproduksi-pentingnya-edukasi-bagi-generasi-muda-di-desa/>
- Universitas Ahmad Dahlan. (2022). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja. Diakses dari <https://eprints.uad.ac.id/24395/1/buku%20ajar%20KRR.pdf>
- Universitas Negeri Gorontalo. (2023). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia. Diakses dari <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/11038/BUKU-KESEHATAN-REPRODUKSI-REMAJA-DAN-LANSIA.pdf>
- WHO. (2022). Adolescent and Youth Reproductive Health. Diakses dari <https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescents/en/>

Glosarium

- Mood** adalah suasana hati atau keadaan emosional seseorang yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Mood bisa bersifat sementara dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman, atau kondisi fisik.
- CD4** adalah salah satu jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sel CD4 membantu melawan infeksi dengan mengoordinasikan respons imun. Penurunan jumlah sel CD4 dikaitkan dengan infeksi HIV/AIDS.
- Chancre** adalah luka kecil dan tidak nyeri yang muncul sebagai tanda awal infeksi sifilis. Biasanya muncul di area genital, mulut, atau bagian tubuh lain yang terpapar bakteri penyebab sifilis (*Treponema pallidum*). Chancre dapat sembuh sendiri dalam beberapa minggu, tetapi infeksi tetap ada jika tidak diobati.
- Mitos** adalah cerita, kepercayaan, atau gagasan yang berkembang dalam masyarakat tetapi tidak selalu didasarkan pada fakta atau bukti ilmiah. Mitos sering digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, budaya, atau sosial, meskipun terkadang dapat menyesatkan jika dipercaya sebagai kebenaran mutlak.
- Stigma** adalah label negatif atau prasangka sosial yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu, sering kali mengarah pada diskriminasi atau pengucilan. Stigma dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti kesehatan (misalnya stigma terhadap penderita penyakit tertentu), sosial, atau budaya.

BAB II

PENDEKATAN BIDAN

DALAM KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan periode masa perkembangan yang sangat penting dimana pada saat masa terjadi perubahan dari anak-anak ke dewasa dan ditandai dengan perubahan fisik (pubertas), psikologis (kognitif – kemampuan berpikir secara abstrak) dan sosial (perilaku interaksi) yang disebabkan karena terjadinya perubahan fisik yang cepat, perubahan emosional, kognitif, moral, sosial serta psikologis sehingga remaja sangat beresiko terhadap berbagai permasalahan, termasuk permasalahan kesehatan reproduksi yang mana kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting bagi remaja, oleh sebab itu remaja perlu untuk membiasakan kebiasaan yang baik terutama dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksinya.

Banyak cara guna menjaga kesehatan reproduksi diantaranya adalah dengan cara menjaga pola hidup sehat, pola makan yang sehat, melakukan olahraga serta mengonsumsi vitamin dan suplemen secara rutin.

Indonesia memiliki aturan tentang hak reproduksi dimana hak tersebut diatur didalam UU Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian 6 pasal 71, disebutkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental serta sosial secara utuh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan namun juga berkaitan dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi pada remaja.

Terdapat 11 hak reproduksi di Indonesia yaitu hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan), hak kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari segala macam bentuk diskriminasi reproduksi, hak atas kerahasiaan pribadi tentang kesehatan reproduksinya, hak untuk berfikir tentang kesehatan reproduksi, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak dalam penentuan jumlah anak, jarak kelahiran, serta hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, hak mendapatkan manfaat dari kemajuan iptek yang terkait dengan kesehatan reproduksi, hak atas kebebasan berkumpul serta berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual (Tangkas, N. 2021).

Hak hak reproduksi remaja tersebut sejalan dengan perturan pemerintah RI Nomer 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dimana pasal 11 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk mencegah serta melindungi remaja dari perilaku seksual beresiko serta perilaku seksual lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi sehingga remaja dapat menjalani kehidupan reproduksi yang sehat serta bertanggung jawab (Winatasari, D,2021).

Berdasarkan Romauli S, 2024 ada 3 permasalahan kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada remaja atau yang dikenal sebagai TRIAD KRR diantaranya adalah seksualitas, HIV dan AIDS serta Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), hal tersebut menjadi ancaman yang serius bagi remaja, banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah yang terjadi pada remaja diantaranya adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal dari remaja diantaranya ialah pengetahuan, sikap, norma, persepsi, efikasi serta gaya hidup dari remaja itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dari remaja tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh teman, keluarga, lingkungan, maupun media sosial dan yang lainnya, oleh sebab itu sangat diperlukan upaya untuk pemberian informasi serta pendampingan yang komprehensif, baik dari orang tua maupun dari tenaga kesehatan khususnya bidan, karena bidan mempunyai peran penting dalam melakukan konseling yang terkait dengan kesehatan remaja, karena peran dan tugas seorang bidan sebagai pelayan kebidanan adalah sebagai penyuluh konselor serta fasilitator, bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan reproduksi (Mahadewa P, 2021). Peran bidan tertuang dalam hal kesehatan reproduksi sesuai peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 21a.

Berdasarkan Winatasari, 2021 Derajat kesehatan reproduksi dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pendekatan yang dilakukan oleh bidan dengan cara konseling dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja (sumiari, dkk)., serta dapat meningkatkan pola perilaku remaja dalam menerapkan pola hidup bersih untuk menjaga organ reproduksinya (Fauziah dan Jambormias). Pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam konseling kesehatan reproduksi pada remaja hendaknya dilakukan secara holistik / menyeluruh serta secara komprehensif.

B. Pendekatan Konseling Behavior

Konseling Behavioral merupakan salah satu bentuk teknik konseling yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli dalam mempelajari tingkah laku klien (remaja) melalui pendekatan teknik yang berfokus pada tindakan (Marliani, 2024)

Konseling Behavioral merupakan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku klien, atau bisa dikatakan bahwa konseling behavioral merupakan teknik konseling yang digunakan untuk melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai (Sulistiyono, J. 2022).

Konseling behavioral dapat memberikan ruang bagi remaja untuk mengembangkan sikap yang positif terhadap kesehatan reproduksinya (Misliarna, 2024), melalui pendekatan konselor behavioral konseli dapat membantu remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan dapat mengembangkan perilaku sehat yang mendukung kesehatan reproduksinya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan konseling dengan pendekatan behavioral yaitu dengan melakukan pendekatan yang difokuskan pada perilaku yang tampak dan spesifik dan bukan karena penyebab internal dan atau emosional dari remaja itu sendiri yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan / adaptif.

Didalam pendekatan konseling secara behavioral ada berbagai macam teknik, diantaranya adalah dengan latihan *asertif* yaitu dengan cara membantu klien untuk mengungkapkan kebutuhan serta keinginan mereka dengan jelas dan tegas, *desensitisasi sistematis* dengan cara membantu remaja dalam hal mengatasi kecemasan atau phobia terhadap sesuatu dengan cara yang bertahap, pengkodisian *aversi* yaitu dengan cara mengasosiasikan perilaku yang tidak diinginkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan serta pembentukan tingkah laku / shaping adalah dengan cara membantu klien atau remaja untuk mengembangkan perilaku baru yang positif dengan cara yang bertahap.

Konselor dalam pendekatan ini diharapkan dapat bertindak secara aktif, direktif serta menggunakan pengetahuan secara ilmiah dalam menemukan permasalahan yang dialami klien (remaja).

Adapun menurut Surya dalam Marliani, dkk, 2021 menyebutkan bahwa Metode - metode konseling behavioral antara lain yaitu :

1. Operant learning

Merupakan pendekatan yang berfokus terhadap penguatan (reinforcement), dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. dalam hal ini perilaku remaja dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

2. Social modeling

Merupakan pendekatan dengan melibatkan tiga aspek antara lain yaitu , peristiwa stimulus dari luar, penguat eksternal dan yang paling penting merupakan proses perantara kognitif. dalam hal ini konselor merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien / remaja.

3. Cognitive learning

Metode pendekatan *cognitive learning* ini adalah metode pendekatan secara verbal, kontak / interaksi antara konselor dengan klien serta bermain peran. pendekatan ini meliputi persuasi serta pendapat yang diarahkan terhadap perubahan ide yang *irrational*

4. Emotional learning

Pendekatan konseling secara behavioral yang terakhir adalah dengan pendekatan emotional learning, metode ini bisa diaplikasikan terhadap klien yang mengalami kecemasan yang dilakukan dalam situasi yang santai dan tenang dengan hal hal yang bisa memunculkan emosi yang menyenangkan.

C. Pendekatan Konseling secara Holistik

Holistik memiliki arti yaitu “menyeluruh”, yang berarti membangun manusia yang utuh sehat dan seimbang karena holistik berasal dari kata *hol* dan *healthy* baik dari segi moral, spiritual, intelektual, budaya, estetika, imajinasi, fisik maupun emosi nya. pendekatan secara holistik merupakan pendekatan yang paling komprehensif dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya untuk pelayanan kesehatan termasuk kebidanan karena dalam melakukan pendekatan holistik ini seorang bidan harus bisa melakukan pendekatan ke klien dari segi psikologis, keluarga, etika, spiritual sosial serta dari segi biologis klien (kesehatan reproduksinya).

Pendekatan pelayanan kesehatan reproduksi secara holistik di indonesia didukung pada beberapa aturan hukum salah satunya adalah keputusan menteri kesehatan nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 yang berisi tentang standar asuhan kebidanan dimana seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara holistik itu berdasarkan *evidence based* dengan pendekatan asuhan kebidanan yang memperlihatkan aspek dari segi fisik, emosional, sosial, psikologi, ekonomi, lingkungan dan budaya yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan diantaranya dengan cara upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif sesuai kewenangannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 yang berisi tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Ada beberapa aspek yang dilakukan oleh seorang bidan dalam melakukan pendekatan yang bersifat holistik diantaranya adalah dengan Berfokus pada aspek biologi / fisik, mental, sosial, spiritual serta kultural dimana meliputi berbagai aspek

penting, seperti: Pemahaman anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi wanita, melakukan edukasi kesehatan seksual, melakukan edukasi penanganan masalah reproduksi, serta melakukan edukasi tentang pencegahan gangguan kesehatan reproduksi.

1. Pendekatan holistik dari aspek biologis

Sebagai seorang bidan dalam melakukan konseling kepada remaja harus mampu memahami kebutuhan remaja, salah satunya adalah mampu memperhatikan kebutuhan fisiologis remaja. terdapat beberapa kebutuhan yang bersifat fisiologis yang harus diperhatikan oleh bidan dan harus dipenuhi para remaja diantaranya adalah para remaja paham tentang perubahan fisik yang terjadi ketika menjelang usia pubertas, para remaja tahu akan proses, fungsi serta sistem alat reproduksi, para remaja mengetahui penyakit HIV/AIDS serta penyakit menular seksual yang lainnya.

Adapun pendekatan secara holistik yang dapat dilakukan seorang bidan dalam melakukan pendekatan konseling kesehatan reproduksi kepada remaja adalah dengan cara :

- a. Melakukan evaluasi dari segi faktor faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi
- b. Memberikan pendidikan tentang perilaku hidup sehat (diantaranya dengan cara melakukan aktifitas fisik secara teratur bisa dengan cara melakukan olahraga secara teratur, pola makan yang seimbang 4 sehat 5 sempurna, pentingnya pengelolaan stres karena dengan menjaga kesejahteraan mental dan menjaga emosional remaja akan dapat menunjang kesehatannya reproduksi para remaja itu sendiri, menghindari kebiasaan merokok, dll)
- c. Memberikan pendidikan seksual yang positif
- d. Memberikan informasi serta pemahaman pada remaja tentang organ reproduksi serta kesehatan reproduksi yang bisa dilakukan melalui media sosial maupun aplikasi
- e. Mengajarkan remaja untuk mengetahui dan menghindari kekerasan seksual sehingga terbebas dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan / bullying
- f. Memberikan informasi tentang stigma ataupun mitos yang sering terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja.

Informasi tentang stigma atau mitos tentang kesehatan sangat diperlukan oleh remaja karena banyak remaja yang terjebak oleh informasi informasi yang berkembang di kalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran ilmiah, dengan adanya pendidikan kesehatan atau konseling yang diberikan seorang bidan tentang organ reproduksi akan dapat mengetahui kebenaran yang ada, sebagai contoh mitos yang berkembang di

asyarakat bahwa orang yang mengalami menstruasi itu tidak diperbolehkan keramas karena darah yang keluar menjadi lebih banyak dari yang seharusnya, tetapi faktanya bahwa dengan keramas saat menstruasi akan dapat merileksasikan otot, meredakan kram, menjadikan badan akan lebih terasa nyaman dan bersih serta dapat meningkatkan suasana hati. selain itu dengan melakukan keramas akan dapat membersihkan kulit kepala sehingga akan dapat mengangkat keringat yang ada di kepala karena pada saat menstruasi produksi kelenjar keringat serta kelenjar minyak pada kulit meningkat.

g. Menjalin kerjasama dengan keluarga, sekolah serta komunitas.

Keberadaan orang tua di dalam keluarga sangat berpengaruh penting di dalam proses tumbuh kembang seorang anak, apalagi saat masa remaja, karena masa remaja yang dibutuhkan adalah dukungan sosial dan emosional khususnya dari keluarga, karena dengan adanya dukungan orang tua maka remaja akan merasa disayangi, dipercaya, di hargai, dicintai serta didukung sehingga dapat mencegah hal hal yang negatif yang mungkin bisa didapat di luar.

Keterlibatan orang tua secara langsung, perhatian , program dan fasilitas dari sekolah serta *circle* pergaulan yang positif akan dapat membentuk sikap dan perilaku remaja yang baik dan positif.

2. Pendekatan Holistik dari aspek Mental / Psikologi

Stres, kecemasan serta persepsi tentang diri akan sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja oleh sebab itu diperlukan pemahaman tentang bagaimana faktor psikologis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi seorang remaja, tidak hanya faktor fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi , bahwa faktor psikologis seperti stress yang kronis atau trauma juga dapat mempengaruhi pola menstruasi pada remaja.

Pendekatan yang menyeluruh terhadap kesehatan reproduksi membutuhkan kerjasama antar berbagai macam rumpun ilmu, termasuk psikologi, kedokteran, bahkan sosiolog. praktisi kesehatan dalam hal ini seorang bidan sangat diperlukan karena bidan dapat memberikan dukungan serta pendidikan kesehatan yang baik kepada para remaja. Ketika remaja memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana emosi dan pikiran mereka dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya maka mereka akan lebih bijak dalam membuat keputusan yang lebih sehat khususnya kesehatan reproduksinya.

Setiap remaja memiliki kebutuhan yang berbeda beda oleh sebab itu pendekatan secara holistik ini (pendekatan dengan tujuan personal dan terfokus) sangat diperlukan dalam melakukan konseling ini guna meningkatkan kesadaran

masyarakat khususnya para remaja dalam mengelola emosi nya guna menjaga kesehatan reproduksi.

Kolaborasi antara berbagai pihak termasuk praktisi kesehatan, peneliti, pendidik, serta masyarakat dalam melakukan pendekatan secara holistik ini adalah sebuah kunci dalam keberhasilan pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi pada remaja.

D. Pendekatan Konseling secara Komprehensif

Pendekatan serta pendampingan seorang bidan dalam melakukan konseling terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja harus secara komprehensif / lengkap / menyeluruh , dalam melakukan konseling harus berkesinambungan serta ditujukan untuk mendukung remaja dalam melakukan sikap dan perilaku yang positif terhadap dirinya khususnya kesehatan reproduksinya.

Berdasarkan Safitri, 2021 bahwa remaja yang berkualitas selain memiliki kematangan secara fisik serta seksual yang baik , remaja juga diharapkan memiliki kemandirian sosial serta ekonomi, dapat membangun identitas diri, memiliki kemampuan untuk persiapan menuju dewasa. Kesehatan reproduksi pada remaja berperan besar dalam ketrampilan sosial, emosi serta kognitifnya yang secara tidak langsung akan menjadi fondasi perilaku dan kesehatan mereka dimasa depan. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan yang positif secara komprehensif atau menyeluruh tentang kesehatan reproduksi sehingga dapat mendukung remaja dalam mengembangkan berbagai aspek ketrampilan hidup, sikap positif pada dirinya sehingga diharapkan dapat menciptakan remaja yang produktif, berkualitas sehat dan bahagia.

Pendekatan secara komprehensif salah satunya dengan metode penyuluhan yang dapat meningkatkan pemahaman dasar pada remaja tentang bentuk anatomi fisiologi serta fungsi organ reproduksi, selain meningkatkan pemahaman para remaja, pendekatan secara komprehensif ini dapat mengurangi stigma dan mitos yang berkembang di masyarakat, dan dengan melibatkan berbagai pemangku kebijakan seperti keluarga, sekolah dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi para remaja, juga dapat berkontribusi pada pembentukan perilaku yang sehat dan berkelanjutan pada remaja.

Kegiatan penyuluhan ini tidak terlepas dari media sebagai perantara pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan yang akan disampaikan akan lebih mudah dipahami dan di mengerti. Menurut Lucie, dalam Yatimah 2023 media dan alat bantu yang biasa digunakan dalam penyuluhan antara lain yaitu :

1. Leaflet

Leaflet merupakan bentuk penyampaian informasi melalui lembar / kertas yang dilipat, bisa ditambahkan dengan keterangan yang bergambar. Leaflet ini praktis dan ekonomis, tetapi leaflet karena terbuat dari kertas sehingga lebih mudah hilang / sobek yang mana merupakan beberapa kelemahan dari media leaflet.

2. Flip Chart

Flip Chart merupakan media penyampaian informasi kesehatan dalam bentuk buku, dimana setiap lembar berisi gambar dan sebaliknya berisikan tulisan sebagai pesan kesehatan yang berkaitan dan menjelaskan tentang gambar. Keunggulan media ini adalah mudah dibawa, menarik dapat dilipat dan digulung, murah, efisien dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Kelemahan media ini adalah tidak bisa digunakan untuk sasaran dengan khalayak yang besar.

3. Film dan Video

Kelebihan dari media penyuluhan dari film dan video ini adalah bahwa dengan film atau video dapat memberikan gambar yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Kelemahan media ini memerlukan sambungan listrik, alatnya beresiko rusak, membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

4. PPT / Slide serta Proyektor / LCD

PPT / Slide presentasi saat ini menjadi alat yang paling mudah digunakan dan dibuat untuk melakukan penyuluhan, karena dengan adanya berbagai desain akan lebih menarik minat peserta penyuluhan. Karena PPT tidak terlepas dari proyektor oleh karena itu *Powerpoint* ini tidak bisa efektif jika tanpa menggunakan proyektor / LCD dan harus ada fasilitas listrik, sehingga tidak semua tempat bisa *support* penyuluhan dengan media ini.

5. Papan Tulis

Papan tulis memiliki keunggulan yaitu mudah, murah dan efisien, bisa dibersihkan dan digunakan kembali, namun untuk sekelompok sasaran yang besar, media ini tidak efektif.

Konseling yang dilakukan seorang bidan dalam pendidikan kesehatan kepada remaja bisa dengan menggunakan teknik teknik konseling yang interaktif dan partisipatif, dengan menggunakan permainan peran, diskusi kelompok atau media interaktif lainnya dapat digunakan untuk membantu remaja dalam memahami dan mengaplikasikan informasi kesehatan reproduksi, pendekatan yang dilakukan dengan cara partisipasi aktif akan dapat meningkatkan efektifitas konseling

kesehatan reproduksi. Menurut Kusmiran (2011) dalam Tuasikal J, 2024 , pendekatan yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya dapat mempercepat penerimaan informasi serta dukungan yang relevan sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah oleh klien.

Selain teknik pendekatan konseling yang disesuaikan dengan usia, pengembangan ketrampilan dan negosiasi juga merupakan hal yang penting dalam melakukan konseling kesehatan reproduksi karena dapat membantu remaja untuk mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi mereka.

Pemberdayaan komunitas untuk konseling kesehatan reproduksi remaja dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan serta pembentukan informasi konseling.

1. Sosialisasi

dengan memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi pada remaja serta dapat juga dengan cara memberikan modul modul yang berisi tentang kesehatan reproduksi.

2. Penyuluhan

Dengan memberikan informasi, pemahaman serta ketrampilan pada remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi, pentingnya menghindari seks bebas, memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses penyebaran penyakit serta memberikan pemahaman dan dampak apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, selain hal tersebut memberikan edukasi pada remaja dalam hal pemenuhan gizi yang baik pada waktu remaja, persiapan pernikahan dan kehamilan.

3. Pembentukan pusat informasi konseling

Pembentukan pusat informasi konseling remaja bisa dilakukan dengan cara membentuk (PIK-R) Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dilakukan sebagai wadah kegiatan memberikan informasi dan konseling pada remaja . PIKR ini merupakan bagian dari program Generasi Berencana (GENRE) yang dibuat oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN).

Tujuan PIK – R ini adalah untuk memberikan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga, memberikan informasi kepada remaja agar tidak melakukan seks pranikah, mengkonsumsi narkoba serta zat adiktif lainnya. Mendukung remaja untuk mengembangkan karakternya sehingga menjadi generasi yang tangguh dan bisa berkontribusi nyata di pembangunan, serta PIK – R dapat digunakan sebagai tempat bagi remaja untuk bercerita tentang masalah yang sedang dihadapi (Fatmawati, 2022).

Kegiatan PIK – R ini dikelola dari, oleh dan untuk remaja karena menurut ismiyati, 2013 , remaja akan cenderung menyukai konselor dari teman sebayanya atau orang yang berjiwa muda untuk konseling tentang kesehatan reproduksinya.

E. Pendekatan Konseling secara Online

Wardah (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja secara benarakan dapat membawa remaja untuk menghindari hal hal yang negatif yang mungkin akan dialami oleh remaja yang tidak cukup pengetahuan tentang bagaimana kesehatan reproduksi. Hal tersebut sejalan dengan kebijaka pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan para remaja salah satunya dengan cara program konseling disekolah.

Tujuan dari penyediaan layanan konseling disekolah difokuskan untuk menjaga kerahasiaan masing masing remaja sehingga diharapkan dapat memperbanyak cakupan jumlah remaja yang bersedia melakukan konseling kesehatan reproduksinya, dengan iptek yang saat ini berkembang, program konseling secara daring yang melibatkan teknologi berbasis IT dapat menjadi tren yang bisa diminati para remaja mendatang karena konseling secara daring bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya program ini, dapat menciptakan perubahan positif serta memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan , kesadaran serta pemahaman yang baik melalui pemberian materi yang berhunungan dengan kesehatan reproduksi (Deardooff, 2012).

Pendekatan konseling kesehatan reproduksi secara online pada para remaja ini mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan proses konseling secara offline karena dengan cara online para remaja dapat mengekspresikan perasaannya secara lebih terbuka, bebas dan mendalam karena ada beberapa remaja lebih bisa dan lebih mudah mengekspresikan perasaannya melalui tulisan dari pada tatap muka secara langsung (Ryle, 2023), bahkan bisa juga proses konseling ini dilakukan dengan cara mengirim email, dengan email akan lebih dapat mengemukakan isu serta permasalahan klien jika dibandingkan berbicara secara langsung (Hunt, Shochet & King, 2005).

Pendekatan konseling secara online ini merupakan salah satu bentuk dari media promosi yang memanfaatkan tren atas kemajuan iptek yang mana penggunaan internet telah menjadi komoditi terbesar sehari hari khususnya pada remaja saat ini. Pendekatan konseling berbasis online ini dapat digunakan sebagai media pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan , sikap dan perilaku kesehatan reproduksi pada remaja.

F. Pendekatan Konseling secara Yuridis Sosiologis

Pendekatan secara yudiris sosiologis ini merupakan pendekatan dengan cara mengkaji kaidah – kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin – doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam PP No. 61 Tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan reproduksi pada remaja, dimana pelayanan kesehatan reproduksi remaja diberikan dengan menggunakan penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja, konseling yang diberikan kepada remaja seharusnya disesuaikan dengan masalah, tahapan tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama, perkembangan mental dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan . Sebagai seorang bidan diharapkan dapat memberikan komunikasi, informasi dan edukasi, konseling serta pelayanan klinis medis terhadap remaja.

1. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi pada remaja terdiri dari :
 - a. Pendidikan ketrampilan hidup sehat
 - b. Ketahanan mental melalui ketrampilan sosial
 - c. Sistem, fungsi serta proses reproduksi
 - d. Perilaku seksual yang sehat dan aman
 - e. Perilaku seksual beresiko dan akibatnya
 - f. Keluarga berencana, dan
 - g. Perilaku beresiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
2. Konseling
Dalam melakukan konseling seorang bidan / konselor / konselor sebaya dalam melakukan konseling harus memperhatikan privasi dan kerahasiaan.
3. Pelayanan klinis medis dalam hal ini merupakan screening atau deteksi penyakit, pengobatan maupun rehabilitasi.
4. Pemberian materi komunikasi, informasi dan edukasi melalui proses pendidikan formal dan non formal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik / konselor sebaya.

PP 28/ 2024 yang mengatur tentang peningkatan layanan yang bersifat promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan reproduksi para remaja. Oleh sebab pemerintah, khususnya konseling seorang bidan dalam melakukan komunikasi, pemberian informasi serta edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi para remaja sangat diperlukan. konseling dengan pendekatan yuridis ini mencakup edukasi mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual beresiko serta dampaknya, edukasi tentang

keluarga berencana dan bagaimana cara melindungi diri dari kejahatan seksualitas tentunya konseling ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia remaja.

Setiap tugas dan wewenang seorang bidan harus selalu berpedoman pada UU dan Permenkes yang berlaku. karena hukum memiliki posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. hukum tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, berdasarkan Robert B dalam.... menyatakan bahwa bekerjanya hukum dan masyarakat melibatkan 3 unsur dasar, yaitu pembuat hukum, pelaksana hukum serta pemegang peran. Dalam hal ini kaitannya DPR dan menteri kesehatan sebagai pembuat hukum, bidan sebagai pelaksana hukum serta remaja sebagai pemegang peran.

Tingginya peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dalam pelayanan kebidanan dapat diukur dengan empat indikator, meliputi : pemberi pelayanan kebidanan, penyuluh konselor serta fasilitator, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan tersebut karena bidan selalu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari kliennya yang berdasarkan kompetensi yang jelas serta terukur.

G. Penutup

Masa remaja merupakan masa yang penting dimana terjadi proses perubahan di berbagai aspek yang bisa menimbulkan berbagai masalah di kesehatannya termasuk kesehatan reproduksinya, dengan adanya upaya pendekatan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi para remaja sehingga para remaja akan menjalani masa remaja dengan sehat dan bahagia.

Ada beberapa cara pendekatan konseling kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh Bidan dalam melakukan upaya promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif terhadap kesehatan reproduksi remaja, antara lain dengan cara pendekatan konseling behavioral dimana pendekatan ini berfokus pada tindakan yang tampak dari remaja, kemudian pendekatan secara holistik yaitu kegiatan konseling yang dilakukan oleh bidan secara menyeluruh dari mulai fisik maupun psikis dari remaja, kemudian pendekatan secara komprehensif yaitu melakukan konseling secara lengkap dan menyeluruh, konseling secara online dapat digunakan sebagai salah satu metode pengembangan pendekatan konseling kesehatan reproduksi terhadap remaja, dengan adanya konseling secara online remaja akan lebih terbuka dan bebas terhadap kondisi kesehatan reproduksinya, dan pendekatan secara yuridis sosiologis dimana kegiatan konseling ini dilakukan dengan cara

mengkaji kaidah kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin – doktrin hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan konseling.

Referensi

- Deardorff, William W., 2012. Internet Based Treatment: A Comprehensive Review; Ethics & Risk Management, Behavioral Health CE.
- Fatmawati, D, Rosyidah, F, dan Viscarini, A, " Pemberdayaan Peer Group Kader Sebaya Reproduksi Remaja Awal di Pondok Pesantren Nurul Jadid" ejournal.unuja. P-ISSN: 2962-3227, E-ISSN: 2962-3235. Vol. 1, No. 1, 2022
- Ismiyati, D. K. Sunjaya, and S. Susanah, "Substansi Modul Konseling Sebaya Dalam Mengatasi Permasalahan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Akhir," J. Med. (Media Inf. Kesehatan), vol. 5, no. 1, pp. 1–9, 2018, doi: 10.36743/medikes.v5i1.1
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- Ryle, 2023. The Use Of Therapy Based E-mail Journal of Applied Psychology.
- Safitri, T. 2021. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Yang Komprehensif Membentuk Remaja Berkualitas. Cendekia. Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 1 No 1 Tahun 2021
- Romauli, S dan Warouw. 2024. Edukasi Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Numbay Kota Jayapura. Jurnal Madaniya, Vol. 5, No 1, Februari 2024
- Tangkas, N. Lutfiana, I. Dewi, P. 2021. Midwife, Counseling and Adolescent Reproductive Health Right In Covid – 19 Pandemic. Jurnal Medicara Tahun 2021
- Wardah, Ashimatul. 2007. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja. Gresik : Cipta Karya
- Hunt, Christine, Shochet, Lan and King, Robert. 2005. The Use of E-Mail in Therapy Process. Queensland : University Of Qld
- Mahadewa, M dan Utami, S. 2021. " Peran Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Pelayanan Kebidanan"
- Misliarna, Ma'rufi dan Sainuddin, S. 2024. "Pengaruh Konseling Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Pengendalian Pernikahan Dini di Desa Bonepute Tahun 2024". Innovative: Journal
- Winatasari, D. 2021. Peran Bidan Puskesmas Dalam Pelaksanaan Konseling Remaja Sebagai Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Akhir di Puskesmas Bancak. Jurnal. JIKA, Volume 6, Nomor 1, Agustus 2021. PissN : 2528-2685, Eissn : 2598-2857, <https://e-journal.ar-rum.ac.id/index.php/JIKA/article/viewFile/131/133>

Yatimah, D. Ana, E. Wibowo, S , dkk. 2023. Penyuluhan Kesehatan Sistem Reproduksi Sebagai Upaya Meningkatkan Perawatan Kesehatan Remaja. Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Magister Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Volume 03 (4), Desember 2023.
<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>

Glosarium

A

AIDS : *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV.

B

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertugas di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

D

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat : lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat Indonesia. DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

G

GENRE : Generasi Berencana. GenRe adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

H

HIV : Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.

I

IT : *Information Technology* merupakan Teknologi Informasi. IT merupakan bidang yang mengelola teknologi untuk mengolah dan memproses informasi.

L

LCD : *Liquid Crystal Display*, berarti layar kristal cair. LCD merupakan teknologi yang digunakan untuk menampilkan gambar atau angka atau tulisan pada layar panel datar.

N

NAPZA : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak sehingga dapat mempengaruhi kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal.

P

Pemenkes : Peraturan Menteri Kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangan di bidang kesehatan. Permenkes memiliki tujuan untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek kesehatan, seperti pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kualitas produk kesehatan

PP : Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan rincian terkait ketentuan dalam undang-undang.

PPT : *PowerPoint* Presentation merupakan aplikasi untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. *PowerPoint* merupakan bagian dari *Microsoft Office*. di mana dapat digunakan untuk keperluan dalam menyampaikan informasi secara pribadi, bisnis, maupun pendidikan.

PIK – R : Pusat Informasi Konseling – Remaja adalah wadah kegiatan yang memberikan informasi dan konseling kepada remaja

T

TRIAD KRR : Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang berfokus pada tiga risiko remaja, yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan narkoba

U

UU : Undang – Undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden. UU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA

A. Pendahuluan

Remaja merupakan kelompok populasi yang berada dalam fase transisi antara masa anak-anak dan dewasa. Fase ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan emosional yang signifikan, sehingga menjadikan remaja kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan reproduksi. Salah satu tantangan utama dalam kesehatan reproduksi remaja adalah minimnya pemahaman yang tepat terkait kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko, serta pencegahan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan (Rahmawati & Pratiwi, 2022; Astuti & Fatmawati, 2020).

Tingkat kesadaran yang rendah mengenai isu-isu kesehatan reproduksi di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya akses terhadap informasi yang akurat, hambatan komunikasi dengan orang tua dan pendidik, serta stigma sosial yang melekat pada isu seksual dan reproduksi. Kondisi ini menyebabkan remaja cenderung mencari informasi dari sumber yang kurang valid, seperti media sosial atau teman sebaya, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perilaku berisiko (Syifa & Fauzia, 2023; Anggraeni & Syamsudin, 2021).

Dalam konteks ini, bidan sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Bidan tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang langsung kepada individu, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran komunitas melalui pendekatan promotif dan preventif. Dengan posisi uniknya di masyarakat, bidan mampu menjangkau remaja secara lebih efektif serta memfasilitasi pemberdayaan komunitas dalam upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi remaja secara berkelanjutan (Purnamasari & Setyowati, 2019; Novitasari & Wahyuningsih, 2021).

Strategi berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam berbagai studi sebagai metode untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi remaja. Strategi ini mengandalkan partisipasi aktif anggota komunitas dalam mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, serta melakukan evaluasi hasil. Pendekatan komunitas tidak hanya meningkatkan penerimaan dan efektivitas program edukasi, tetapi juga

mendukung keberlanjutan program melalui pemberdayaan sumber daya lokal, seperti tokoh masyarakat, kader kesehatan, keluarga, dan remaja itu sendiri (Kementerian Kesehatan RI, 2021; WHO, 2022).

Mengingat pentingnya keterlibatan komunitas, buku ini akan secara mendalam membahas berbagai strategi berbasis komunitas yang dapat diterapkan oleh bidan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi. Melalui kajian teori, bukti-bukti empiris, dan pengalaman praktik dari berbagai negara, diharapkan buku ini dapat menjadi panduan komprehensif bagi para bidan dalam menjalankan peran strategis mereka di tengah komunitas, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia (Astuti & Fatmawati, 2020; Rahmawati & Pratiwi, 2022; WHO, 2022).

B. Konsep Strategi Berbasis Komunitas dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi

1. Definisi dan Ruang Lingkup Strategi Berbasis Komunitas

Strategi berbasis komunitas (community-based strategy) merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai elemen komunitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan secara partisipatif. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di komunitas, seperti tokoh masyarakat, kader kesehatan, lembaga lokal, dan anggota komunitas itu sendiri (Wijayanti & Rosyidah, 2022).

Dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi remaja, strategi berbasis komunitas mencakup kegiatan penyuluhan, pelatihan, peer education, pelayanan kesehatan remaja berbasis komunitas, hingga penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat edukasi (Putri & Nursasi, 2021). Ruang lingkup dari strategi ini tidak hanya terbatas pada promosi kesehatan, tetapi juga mencakup pencegahan perilaku seksual berisiko, pencegahan penyakit menular seksual, serta pencegahan kehamilan dini melalui pendekatan yang adaptif dengan budaya dan kebutuhan spesifik remaja dalam komunitas (Astuti & Fatmawati, 2020).

2. Pentingnya Partisipasi Komunitas dalam Kesehatan Reproduksi Remaja

Partisipasi aktif komunitas menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi program kesehatan reproduksi remaja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Pratiwi (2022), partisipasi komunitas secara aktif, khususnya keterlibatan remaja, keluarga, dan tokoh masyarakat, telah terbukti

meningkatkan penerimaan informasi kesehatan reproduksi serta memudahkan proses komunikasi yang lebih terbuka mengenai isu-isu sensitif.

Keterlibatan komunitas tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas serta kontinuitas program. Dalam studi lainnya, ditemukan bahwa keterlibatan keluarga dan pemuka agama secara khusus mampu mengurangi stigma negatif terkait isu kesehatan reproduksi, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi terbuka (Novitasari & Wahyuningsih, 2021; Prabawati & Nugraheni, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Fatmawati (2020) menunjukkan bahwa remaja yang terlibat aktif dalam kegiatan edukasi berbasis komunitas memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi serta mampu mengadopsi perilaku yang lebih sehat dibandingkan dengan remaja yang tidak terlibat langsung. Dengan demikian, partisipasi komunitas merupakan aspek fundamental yang harus dipertimbangkan dalam desain strategi kesehatan reproduksi remaja.

3. Prinsip dan Komponen Utama dalam Implementasi Strategi Berbasis Komunitas

Dalam penerapan strategi berbasis komunitas, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi aktif, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multisektor, pendekatan berbasis budaya, dan keberlanjutan (WHO, 2022). Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua elemen komunitas, termasuk remaja, sebagai subjek dari program. Prinsip pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam merancang solusi terhadap permasalahan kesehatan reproduksi remaja yang mereka hadapi (Kemenkes RI, 2021).

Komponen utama dalam strategi berbasis komunitas menurut WHO (2022) meliputi:

- a. **Identifikasi Masalah secara Partisipatif:** Melibatkan komunitas dalam identifikasi masalah kesehatan reproduksi yang paling mendesak bagi remaja.
- b. **Perencanaan dan Desain Program yang Kolaboratif:** Program dirancang bersama dengan komunitas untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal dan nilai budaya.
- c. **Implementasi Program oleh Komunitas:** Pelaksanaan kegiatan oleh kader komunitas atau peer educators yang mendapatkan pelatihan khusus untuk menjamin efektivitas intervensi.

- d. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Komunitas:** Evaluasi dampak program dilakukan secara partisipatif untuk mengukur keberhasilan dan menentukan tindak lanjut yang tepat.

Penelitian Wijayanti dan Rosyidah (2022) menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan komponen-komponen ini secara komprehensif terbukti efektif meningkatkan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan menurunkan angka kejadian perilaku seksual berisiko di komunitas perkotaan maupun pedesaan di Indonesia.

Dengan memperhatikan prinsip dan komponen ini, strategi berbasis komunitas mampu menciptakan dampak jangka panjang yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat remaja terkait isu kesehatan reproduksi.

C. Model-model Intervensi Komunitas untuk Kesadaran Kesehatan Reproduksi Remaja

Dalam upaya meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi remaja di tingkat komunitas, berbagai model intervensi telah dikembangkan dan diterapkan. Model-model tersebut meliputi layanan kesehatan yang ramah remaja (youth-friendly services), pemberdayaan remaja melalui pendekatan pendidik sebaya (peer educator), serta monitoring partisipatif berbasis komunitas (community-led monitoring). Setiap model memiliki karakteristik, kelebihan, dan efektivitas yang berbeda tergantung pada konteks implementasinya (Rahmawati & Pratiwi, 2022; Putri & Nursasi, 2021).

1. Youth-friendly Services: Layanan Kesehatan yang Ramah Remaja di Tingkat Komunitas

Youth-friendly services (YFS) merupakan model layanan kesehatan yang secara khusus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan sensitivitas remaja. Layanan ini menyediakan akses yang mudah, privasi terjamin, dan komunikasi yang efektif antara remaja dengan tenaga kesehatan. YFS mencakup konsultasi kesehatan reproduksi, penyediaan informasi akurat tentang kesehatan seksual, kontrasepsi, serta layanan psikososial bagi remaja (Anggraeni & Syamsudin, 2021).

Menurut studi yang dilakukan oleh Sari et al. (2022), implementasi layanan kesehatan yang ramah remaja di komunitas mampu meningkatkan tingkat pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi secara signifikan. Hal ini dikarenakan remaja merasa nyaman, tidak dihakimi, dan lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan kesehatan reproduksi mereka kepada tenaga kesehatan. Faktor penting dalam keberhasilan layanan ini antara lain pelatihan khusus tenaga

kesehatan tentang pendekatan kepada remaja, lingkungan layanan yang nyaman, dan keterlibatan remaja dalam desain layanan (Handayani & Sulistyaningsih, 2020).

2. Peer Educator dan Perannya dalam Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pendekatan peer educator (pendidik sebaya) adalah intervensi yang memanfaatkan peran remaja itu sendiri sebagai agen perubahan dalam memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya. Peer educator terbukti efektif dalam penyampaian pesan kesehatan reproduksi karena remaja lebih mudah menerima informasi dari kelompok usia yang sama, sehingga pesan lebih relevan dan mudah dipahami (Astuti & Fatmawati, 2020).

Penelitian oleh Astuti dan Fatmawati (2020) menunjukkan bahwa model peer education mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat remaja dalam jangka waktu relatif singkat. Remaja yang terlibat dalam peer education cenderung lebih aktif dalam berdiskusi, memiliki tingkat percaya diri yang lebih tinggi, serta mampu mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai perilaku seksual yang bertanggung jawab. Faktor keberhasilan program ini meliputi seleksi dan pelatihan peer educator yang tepat, materi edukasi yang menarik, serta dukungan berkelanjutan dari tenaga kesehatan seperti bidan dan fasilitator komunitas (Prabawati & Nugraheni, 2023).

3. Community-led Monitoring dalam Pencegahan Risiko Kesehatan Reproduksi

Community-led monitoring adalah model intervensi yang melibatkan komunitas secara aktif dalam memantau, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap program kesehatan reproduksi remaja yang sedang berjalan. Model ini memastikan bahwa program tidak hanya dijalankan untuk komunitas, tetapi juga bersama komunitas, sehingga program lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan lokal (Rahmawati & Pratiwi, 2022).

Dalam studi Rahmawati dan Pratiwi (2022), community-led monitoring terbukti efektif dalam mencegah risiko kesehatan reproduksi remaja melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas program. Komunitas, khususnya remaja, dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul secara real-time serta memberikan solusi segera untuk perbaikan program. Aspek utama keberhasilan intervensi ini adalah partisipasi aktif komunitas dalam proses evaluasi, adanya mekanisme umpan balik yang jelas, serta komitmen dari pelaksana program untuk menindaklanjuti rekomendasi komunitas (Wijayanti & Rosyidah, 2022).

D. Peran Bidan dalam Mengembangkan Strategi Berbasis Komunitas

Bidan memiliki peran sentral dalam pengembangan strategi berbasis komunitas, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Posisi unik yang dimiliki bidan dalam komunitas memungkinkan mereka bertindak sebagai agen perubahan yang efektif dalam peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi remaja. Dengan memanfaatkan kompetensi klinis, edukasi, serta keterampilan komunikasi yang baik, bidan mampu menggerakkan komunitas secara aktif dalam program promosi kesehatan reproduksi (Purnamasari & Setyowati, 2019; Wijayanti & Rosyidah, 2022).

1. Posisi Strategis Bidan dalam Kesehatan Komunitas

Posisi strategis bidan dalam komunitas berakar dari fungsi mereka sebagai tenaga kesehatan primer yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat, terutama ibu, anak, dan remaja. Kedekatan emosional, sosial, dan budaya antara bidan dan masyarakat menciptakan hubungan kepercayaan yang tinggi, sehingga memungkinkan mereka menjadi mediator yang efektif dalam penyampaian pesan kesehatan (Handayani & Sulistyaningsih, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati et al. (2021), bidan dianggap figur otoritatif dalam komunitas yang mampu menyampaikan informasi sensitif secara persuasif dan non-konfrontatif. Posisi ini memberikan keuntungan signifikan dalam mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam program edukasi kesehatan reproduksi remaja, khususnya di area rural dan daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap sumber informasi kesehatan yang valid.

2. Kompetensi Bidan dalam Memberdayakan Komunitas untuk Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

Agar dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal, bidan harus memiliki kompetensi khusus dalam pemberdayaan komunitas. Kompetensi ini mencakup pengetahuan mendalam mengenai kesehatan reproduksi, kemampuan fasilitasi komunikasi komunitas, keterampilan dalam merancang program edukasi, serta kemampuan dalam menerapkan metode monitoring dan evaluasi partisipatif (Sari et al., 2022; Astuti & Fatmawati, 2020).

Menurut studi Astuti dan Fatmawati (2020), kompetensi edukasi dan komunikasi interpersonal yang dimiliki bidan secara signifikan meningkatkan efektivitas penyampaian materi edukasi kepada remaja dan komunitas. Selain itu, kompetensi bidan dalam pendekatan budaya lokal juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program, karena mampu meningkatkan penerimaan komunitas terhadap pesan-pesan kesehatan reproduksi yang disampaikan.

Penelitian lain juga menegaskan pentingnya kemampuan bidan dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi berbasis peer education. Dalam konteks ini, bidan berperan melatih dan mendampingi peer educator, sehingga menghasilkan kader remaja yang kompeten dalam menyebarkan informasi kesehatan reproduksi di kalangan teman sebayanya (Prabawati & Nugraheni, 2023).

3. Kolaborasi Bidan dengan Stakeholder Komunitas

Keberhasilan strategi berbasis komunitas sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara bidan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) komunitas, seperti keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, pemuka agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pemerintah lokal. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya dukungan yang luas, sumber daya yang cukup, serta kesinambungan program yang dijalankan (Rahmawati & Pratiwi, 2022).

Studi Wijayanti dan Rosyidah (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antara bidan dengan stakeholder komunitas terbukti mampu mempercepat penerimaan dan implementasi program edukasi kesehatan reproduksi remaja. Dalam hal ini, peran tokoh agama dan adat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi hambatan sosial dan budaya terhadap program kesehatan reproduksi yang umumnya masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi, memperluas akses informasi, serta mendukung penguatan kapasitas komunitas secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, berbagai tantangan implementasi program dapat diatasi secara lebih efektif melalui dialog terbuka, partisipasi aktif, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kesehatan remaja di komunitas (Anggraeni & Syamsudin, 2021).

E. Pendekatan Peer Education dalam Komunitas

Peer education atau pendidikan sebaya merupakan salah satu pendekatan intervensi komunitas yang populer dalam upaya meningkatkan kesadaran remaja terkait kesehatan reproduksi. Pendekatan ini menggunakan remaja sebagai agen perubahan untuk menyampaikan pesan edukasi kesehatan kepada sesama remaja. Peer education dianggap efektif karena mampu menjangkau remaja secara emosional, sosial, dan budaya (Astuti & Fatmawati, 2020; Nurmala et al., 2021).

1. Efektivitas Peer Education dalam Peningkatan Kesadaran Remaja tentang Kesehatan Reproduksi

Efektivitas peer education dalam meningkatkan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi didukung oleh berbagai penelitian terbaru. Astuti dan Fatmawati (2020) dalam studinya menemukan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, serta mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab secara signifikan dibandingkan dengan metode edukasi konvensional.

Keunggulan utama peer education terletak pada proses komunikasi yang lebih terbuka, ramah, dan mudah dipahami oleh remaja. Remaja lebih nyaman menerima informasi dari rekan sebaya karena persepsi kesetaraan yang tercipta di antara mereka. Hal ini meningkatkan penerimaan pesan-pesan kesehatan yang bersifat sensitif seperti pencegahan kehamilan remaja, penyakit menular seksual, serta perilaku seksual yang aman (Rahmawati & Pratiwi, 2022; Sari & Handayani, 2020).

2. Strategi Implementasi Peer Education Berbasis Komunitas

Implementasi peer education berbasis komunitas membutuhkan strategi yang tepat agar dapat mencapai hasil optimal. Strategi ini mencakup beberapa langkah utama yaitu rekrutmen peer educator, pelatihan khusus, desain konten edukasi yang menarik, dan supervisi berkala oleh tenaga kesehatan profesional seperti bidan (Wijayanti & Rosyidah, 2022).

Penelitian oleh Sari dan Handayani (2020) menjelaskan bahwa rekrutmen peer educator sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek seperti kemampuan komunikasi, popularitas dalam kelompok, motivasi tinggi, serta kemampuan menjadi teladan dalam perilaku kesehatan. Pelatihan peer educator mencakup penguasaan materi kesehatan reproduksi, keterampilan komunikasi efektif, teknik fasilitasi, dan penggunaan media interaktif seperti permainan atau media digital.

Strategi lain yang penting adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana peer educator dapat berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari tenaga kesehatan. Monitoring berkala juga diperlukan untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan program dan melakukan perbaikan berkelanjutan (Nurmala et al., 2021).

3. Studi Kasus Keberhasilan Program Peer Education

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa peer education berhasil dalam meningkatkan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi secara signifikan. Salah satu studi kasus yang menonjol adalah program peer education yang dilaksanakan di Kota Surabaya, Indonesia. Program ini berhasil meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran remaja secara signifikan mengenai bahaya perilaku seksual berisiko, pentingnya kontrasepsi, dan pencegahan penyakit menular seksual (Nurmala et al., 2021).

Di tingkat internasional, program serupa yang dijalankan di Kenya juga menunjukkan hasil positif. Program tersebut berhasil mengurangi angka kehamilan remaja dan meningkatkan penggunaan layanan kesehatan reproduksi di kalangan remaja secara dramatis dalam waktu relatif singkat. Keberhasilan ini disebabkan oleh pendekatan yang tepat sasaran, rekrutmen peer educator yang kompeten, serta dukungan penuh dari stakeholder komunitas seperti tokoh masyarakat, orang tua, dan sekolah (Kabiru et al., 2020).

Kedua studi kasus ini membuktikan bahwa pendekatan peer education berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk mereplikasi kesuksesan serupa di berbagai komunitas, termasuk di Indonesia. Dengan strategi implementasi yang tepat, pendekatan ini mampu menghadirkan perubahan positif yang signifikan dalam pola pikir, sikap, serta perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi.

F. Pemanfaatan Media Sosial dan Digitalisasi dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi di Komunitas

Dalam era digital saat ini, penggunaan media sosial dan platform digital telah menjadi sarana yang strategis dalam edukasi kesehatan reproduksi, khususnya bagi remaja. Digitalisasi memungkinkan penyampaian informasi kesehatan yang lebih luas, cepat, dan interaktif, sesuai dengan karakteristik generasi muda yang familiar dengan teknologi digital (Syifa & Fauzia, 2023; Hidayati & Hasanat, 2021).

1. Platform Digital sebagai Media Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan aplikasi mobile telah menjadi saluran efektif untuk menjangkau remaja dalam kampanye kesehatan reproduksi. Karakteristik platform digital yang interaktif dan atraktif sangat diminati remaja karena dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih santai, menarik, dan relevan dengan kebutuhan mereka (Syifa & Fauzia, 2023).

Penelitian oleh Hidayati dan Hasanat (2021) menemukan bahwa edukasi kesehatan reproduksi melalui platform digital mampu meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan remaja secara signifikan. Remaja lebih nyaman mengakses informasi kesehatan reproduksi melalui media digital dibandingkan metode tradisional seperti seminar atau ceramah, karena merasa privasi mereka lebih terlindungi dan tidak terintimidasi oleh lingkungan sosial.

Platform digital juga memberikan fleksibilitas bagi remaja untuk mengakses konten edukasi kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi kesehatan reproduksi yang sifatnya sensitif (Susanti & Syahrul, 2020).

2. Pengembangan Konten Digital yang Efektif dan Menarik untuk Remaja

Agar pesan kesehatan reproduksi dapat diterima dengan baik oleh remaja, konten digital harus dikembangkan secara kreatif, informatif, dan sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. Menurut Susanti dan Syahrul (2020), beberapa elemen penting dalam pengembangan konten digital meliputi penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, visual yang menarik, serta penggunaan video singkat atau animasi yang lebih disukai remaja.

Strategi lain yang penting dalam pengembangan konten adalah melibatkan remaja secara langsung dalam proses kreatif. Konten yang melibatkan ide dan partisipasi remaja cenderung lebih relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan edukasi. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa dan Fauzia (2023) menunjukkan bahwa konten digital yang interaktif seperti kuis, polling, atau challenge di media sosial mampu meningkatkan interaksi dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi secara signifikan.

Selain itu, penggunaan influencer atau tokoh populer yang dekat dengan dunia remaja juga dapat memperkuat pesan edukasi. Remaja cenderung lebih mudah menerima pesan jika disampaikan oleh tokoh yang mereka idolakan atau kagumi (Hidayati & Hasanat, 2021).

3. Evaluasi Dampak Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Kesehatan Reproduksi

Evaluasi terhadap penggunaan media sosial dan digitalisasi dalam kampanye kesehatan reproduksi sangat penting untuk mengukur efektivitas dan dampaknya pada perubahan perilaku remaja. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur berbagai indikator seperti tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, serta partisipasi aktif remaja dalam kampanye digital yang dilaksanakan (Kurniawati & Widiyawati, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Widiyawati (2022) menemukan bahwa kampanye kesehatan reproduksi melalui media sosial mampu meningkatkan kesadaran remaja secara nyata dalam waktu relatif singkat. Remaja tidak hanya mengalami peningkatan pengetahuan, tetapi juga lebih terbuka dalam membahas isu-isu kesehatan reproduksi secara online maupun offline.

Studi lain dari Syifa dan Fauzia (2023) menambahkan bahwa evaluasi penggunaan media sosial dapat dilakukan melalui analisis engagement, seperti jumlah views, likes, comments, shares, serta analisis kualitatif terhadap isi komentar yang ditulis remaja. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengembangan konten lebih lanjut dan memastikan relevansi serta efektivitas pesan yang disampaikan.

G. Strategi Keterlibatan Keluarga dan Tokoh Masyarakat dalam Edukasi Remaja

Edukasi kesehatan reproduksi remaja tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan langsung kepada remaja itu sendiri, tetapi memerlukan peran aktif keluarga dan tokoh masyarakat. Strategi keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat sangat penting karena mereka memiliki pengaruh kuat terhadap nilai-nilai, sikap, dan perilaku remaja dalam kehidupan sehari-hari (Novitasari & Wahyuningsih, 2021; Handayani & Sulistyaningsih, 2020).

1. Pentingnya Dukungan Keluarga dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga, terutama orang tua, mampu meningkatkan efektivitas edukasi karena keluarga merupakan lingkungan utama pembentukan nilai dan norma sosial bagi remaja (Putri & Nursasi, 2021).

Orang tua yang aktif memberikan informasi dan komunikasi terbuka mengenai kesehatan reproduksi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja secara signifikan. Studi oleh Astuti dan Fatmawati (2020) menemukan bahwa remaja yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik memiliki sikap dan perilaku kesehatan reproduksi yang lebih positif dibandingkan dengan remaja yang tidak mendapatkan dukungan serupa.

Selain itu, dukungan emosional dan psikologis keluarga membantu remaja menghadapi tekanan sosial dan mengurangi risiko perilaku seksual berisiko. Orang tua yang teredukasi dengan baik juga mampu mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi, termasuk dalam mencegah kehamilan dini dan penularan penyakit menular seksual (Nurhidayati et al., 2021).

2. Strategi Pendekatan Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi Remaja

Tokoh agama dan tokoh adat memegang peran strategis dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki struktur sosial yang kuat berbasis budaya

dan agama. Pendekatan melalui tokoh agama dan adat terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan edukasi kesehatan reproduksi, terutama di wilayah yang memiliki nilai konservatif terkait isu-isu seksual dan reproduksi (Prabawati & Nugraheni, 2023).

Strategi yang efektif dalam melibatkan tokoh agama dan adat adalah dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi khusus mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Rosyidah (2022) menemukan bahwa pendekatan yang menghormati nilai-nilai agama dan budaya setempat mampu menghilangkan hambatan sosial serta meningkatkan kesadaran komunitas tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja.

Melalui pendekatan ini, tokoh agama dan adat dapat menjadi mitra yang kuat dalam mengkampanyekan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi secara positif dan preventif, tanpa bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau agama lokal (Rahmawati & Pratiwi, 2022).

3. Tantangan dan Solusi dalam Mengedukasi Keluarga dan Tokoh Masyarakat

Meskipun keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat sangat penting, namun terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi. Tantangan utama adalah stigma sosial, tabu budaya, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi yang membuat keluarga dan tokoh masyarakat enggan membahas isu-isu sensitif tersebut (Sari & Handayani, 2020).

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain adalah meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif dengan menggunakan pendekatan yang sensitif budaya. Menurut Novitasari dan Wahyuningsih (2021), edukasi yang disampaikan secara bertahap dengan pendekatan dialog terbuka, ramah, dan menghargai nilai lokal terbukti mampu mengurangi stigma dan meningkatkan keterbukaan keluarga serta tokoh masyarakat terhadap isu-isu kesehatan reproduksi.

Pendekatan lainnya adalah melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat dalam perencanaan hingga implementasi program, sehingga menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program tersebut. Dengan demikian, mereka merasa bertanggung jawab atas keberhasilan edukasi kesehatan reproduksi yang ditujukan bagi remaja (Handayani & Sulistyaningsih, 2020).

H. Monitoring dan Evaluasi Program Edukasi Berbasis Komunitas

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas. Melalui proses ini, efektivitas, dampak,

serta keberlanjutan program dapat diukur secara jelas. Monitoring berkala dan evaluasi sistematis memastikan bahwa tujuan edukasi tercapai dan perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan (Wijayanti & Rosyidah, 2022; Rahmawati & Pratiwi, 2022).

1. Metode dan Indikator Evaluasi Program Berbasis Komunitas

Evaluasi program berbasis komunitas dilakukan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Metode kuantitatif melibatkan survei dan kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Sedangkan metode kualitatif meliputi wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi partisipatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perubahan sosial dan perilaku dalam komunitas (Kurniawati & Widiyawati, 2022).

Indikator yang sering digunakan dalam evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas antara lain tingkat peningkatan pengetahuan remaja, perubahan sikap dan perilaku terkait kesehatan reproduksi, peningkatan keterlibatan komunitas dalam kegiatan, serta penurunan angka perilaku seksual berisiko dan kejadian kehamilan remaja (Astuti & Fatmawati, 2020; Hidayati & Hasanat, 2021).

Menurut penelitian Kurniawati dan Widiyawati (2022), indikator tambahan yang juga relevan adalah tingkat partisipasi stakeholder komunitas, kepuasan remaja terhadap metode edukasi, serta kualitas implementasi program di lapangan yang mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap konteks sosial budaya lokal.

2. Strategi Monitoring Partisipatif dalam Menilai Keberhasilan Program

Monitoring partisipatif merupakan strategi yang melibatkan komunitas secara aktif dalam proses pemantauan pelaksanaan program. Pendekatan ini memberikan ruang bagi komunitas untuk memberikan umpan balik secara langsung tentang apa yang berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki. Dengan melibatkan komunitas dalam monitoring, rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program akan meningkat (Rahmawati & Pratiwi, 2022).

Studi Rahmawati dan Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa monitoring partisipatif mampu mempercepat identifikasi masalah, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan respons dari pelaksana program. Kegiatan seperti pertemuan evaluasi rutin, forum diskusi komunitas, serta penggunaan platform digital sebagai media interaktif untuk mendapatkan masukan real-time dari peserta program merupakan bentuk implementasi yang efektif dari monitoring partisipatif.

Dalam praktiknya, pelibatan remaja sebagai peer monitor juga menjadi strategi yang efektif karena mereka dapat memberikan laporan akurat dari sudut pandang peserta langsung (Sari & Handayani, 2020).

3. Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan dalam Program Komunitas

Tindak lanjut hasil evaluasi dan monitoring menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan secara berkelanjutan dan semakin efektif dari waktu ke waktu. Langkah tindak lanjut yang direkomendasikan mencakup analisis temuan evaluasi, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta pelaksanaan perubahan sesuai masukan yang diterima dari komunitas dan stakeholder terkait (Wijayanti & Rosyidah, 2022).

Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan prinsip Plan-Do-Check-Act (PDCA). Setiap hasil evaluasi digunakan untuk merancang kembali strategi program, meningkatkan metode komunikasi dan edukasi, serta memperkuat kapasitas pelaksana program. Dengan pendekatan ini, program komunitas menjadi adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan di lapangan (Hidayati & Hasanat, 2021).

Studi yang dilakukan oleh Wijayanti dan Rosyidah (2022) juga menekankan pentingnya komunikasi hasil evaluasi kepada komunitas secara transparan. Dengan demikian, komunitas memahami pentingnya evaluasi sebagai upaya perbaikan yang terus-menerus dan terdorong untuk lebih aktif terlibat dalam setiap proses program yang dilaksanakan.

I. Studi Kasus Program Berbasis Komunitas di Indonesia dan Dunia

Implementasi program kesehatan reproduksi berbasis komunitas telah menunjukkan efektivitas di berbagai negara. Studi kasus program yang telah diterapkan di Indonesia maupun internasional memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk meningkatkan keberhasilan program di masa mendatang (Wijayanti & Rosyidah, 2022; Kabiru et al., 2020).

1. Program "Generasi Berencana" (Genre) di Indonesia: Strategi dan Implementasi

Program Generasi Berencana (Genre) merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia, bertujuan meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya merencanakan masa depan melalui kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab. Program ini menggunakan pendekatan berbasis komunitas, melibatkan peer educator (Pendidik Sebaya), serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat (BKKBN, 2020).

Strategi utama program Genre mencakup edukasi kesehatan reproduksi melalui pendekatan peer education, peningkatan kapasitas remaja dalam pengambilan keputusan yang tepat, serta pelibatan aktif keluarga dalam mendukung perkembangan remaja. Penelitian oleh Novitasari dan Wahyuningsih (2021) menunjukkan bahwa implementasi program Genre di beberapa daerah di Indonesia secara signifikan mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap positif remaja terhadap kesehatan reproduksi, mengurangi angka pernikahan dini, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dalam diskusi terbuka dengan remaja.

Kunci keberhasilan program ini adalah integrasi antara pendekatan budaya lokal dan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak remaja, serta kolaborasi kuat dengan pemangku kepentingan lokal seperti sekolah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2021).

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Komunitas di Filipina dan Thailand

Di Filipina, program kesehatan reproduksi remaja berbasis komunitas banyak menggunakan pendekatan berbasis sekolah dan keterlibatan komunitas agama lokal. Menurut penelitian Garcia et al. (2021), implementasi program ini berhasil meningkatkan pengetahuan remaja tentang metode kontrasepsi, perilaku seksual yang aman, dan mencegah kehamilan dini. Program di Filipina ini menitikberatkan pada pentingnya pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas dalam perencanaan dan implementasi program.

Sementara di Thailand, pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan mencakup kombinasi edukasi kesehatan reproduksi melalui peer education, layanan kesehatan ramah remaja (youth-friendly services), serta pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan komunitas. Studi yang dilakukan oleh Chaiklin dan Srisuriyawet (2020) menunjukkan bahwa integrasi berbagai pendekatan ini berhasil menurunkan angka kehamilan remaja secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesadaran remaja tentang risiko penyakit menular seksual.

Kesuksesan kedua negara tersebut menunjukkan bahwa strategi keterlibatan komunitas yang kuat, integrasi budaya lokal, serta pendekatan berbasis bukti sangat efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja di komunitas.

3. Lesson Learned dari Program Internasional: Adaptasi untuk Konteks Indonesia

Pembelajaran dari program-program internasional, seperti di Filipina dan Thailand, memberikan insight penting yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Di antaranya adalah pentingnya melibatkan stakeholder komunitas

secara aktif dalam setiap tahap implementasi program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Garcia et al., 2021; Chaiklin & Srisuriyawet, 2020).

Hal lain yang perlu diadaptasi di Indonesia adalah pendekatan yang menitikberatkan pada integrasi antara pendidikan formal (sekolah) dan non-formal (komunitas). Penggunaan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana edukasi, seperti di Thailand, juga bisa menjadi model yang efektif untuk menjangkau remaja Indonesia yang kini mayoritas mengakses informasi melalui platform digital (Syifa & Fauzia, 2023).

Studi kasus internasional juga menekankan perlunya melibatkan tokoh agama dan tokoh adat secara aktif untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya yang masih sensitif terhadap isu-isu kesehatan reproduksi di Indonesia. Pelatihan khusus dan pendekatan dialog interaktif dengan tokoh masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan komunitas terhadap edukasi kesehatan reproduksi (Prabawati & Nugraheni, 2023).

Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara ini, program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

J. Penutup

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang berbasis komunitas merupakan pendekatan efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan perilaku positif remaja terhadap kesehatan reproduksinya. Berbagai strategi dan model intervensi berbasis komunitas telah dibahas secara mendalam dalam buku ini, menunjukkan bahwa peran aktif bidan, partisipasi remaja, keluarga, tokoh masyarakat, dan penggunaan teknologi digital sangat menentukan keberhasilan program (Rahmawati & Pratiwi, 2022; Wijayanti & Rosyidah, 2022).

Implementasi program berbasis komunitas memerlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder, termasuk tenaga kesehatan, keluarga, sekolah, serta pemuka agama dan adat. Pendekatan yang holistik dan partisipatif mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja untuk menerima edukasi dengan baik, serta memungkinkan perubahan perilaku jangka panjang dalam kesehatan reproduksi (Astuti & Fatmawati, 2020; Prabawati & Nugraheni, 2023).

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi, seperti stigma sosial, tabu budaya, dan keterbatasan sumber daya, dapat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan adaptif terhadap kondisi sosial-budaya komunitas. Penggunaan media digital juga terbukti meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi kesehatan reproduksi kepada remaja (Syifa & Fauzia, 2023; Hidayati & Hasanat, 2021).

Evaluasi dan monitoring partisipatif yang dilakukan secara berkala merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas dan efektivitas program. Temuan evaluasi menjadi dasar penting untuk tindak lanjut serta perbaikan berkelanjutan, sehingga program dapat terus berkembang seiring perubahan kebutuhan komunitas (Kurniawati & Widiyawati, 2022).

Dengan mengadopsi berbagai pembelajaran dari program internasional serta praktik terbaik yang telah diterapkan di Indonesia, seperti program "Generasi Berencana (Genre)", maka diharapkan pengembangan program berbasis komunitas di masa depan akan semakin efektif, responsif, dan berkelanjutan. Bidan, sebagai aktor kunci dalam pengembangan kesehatan komunitas, perlu terus memperkuat kompetensinya dalam pemberdayaan komunitas dan kolaborasi multisektor, untuk mewujudkan generasi remaja yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya (Novitasari & Wahyuningsih, 2021; Garcia et al., 2021).

Akhirnya, penulis berharap bahwa buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para bidan, pendidik, praktisi kesehatan masyarakat, serta stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja melalui pendekatan berbasis komunitas secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Referensi

- Astuti, R. N., & Fatmawati, E. (2020). Efektivitas peer education dalam peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 23-29.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). *Strategi edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas untuk remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Chaiklin, N., & Srisuriyawet, R. (2020). Community-based approach in preventing adolescent pregnancy in rural Thailand. *Journal of Public Health and Development*, 18(1), 15-24.
- Garcia, M. J., Lopez, R. S., & Mercado, R. T. (2021). Community-based programs and sexual health education for adolescents in the Philippines. *Asian Journal of Community Health*, 9(2), 85-92.
- Handayani, L., & Sulistyaningsih, D. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi remaja mengakses layanan kesehatan ramah remaja. *Jurnal Kebidanan*, 12(1), 31-38.
- Hidayati, L., & Hasanat, N. U. (2021). Efektivitas penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(2), 110-118.
- Kabiru, C. W., Izugbara, C. O., & Beguy, D. (2020). The effectiveness of community-based peer education programs for adolescents in Kenya. *Journal of Adolescent Health*, 66(3), 315-322.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman program generasi berencana (Genre)*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Remaja, Kemenkes RI.
- Kurniawati, T., & Widiyawati, W. (2022). Evaluasi dampak penggunaan media sosial dalam program edukasi kesehatan reproduksi remaja di wilayah perkotaan. *Indonesian Journal of Health Promotion*, 4(2), 75-82.
- Nurhidayati, D., Suryaningsih, E. K., & Saputri, A. (2021). Peran bidan sebagai agen promosi kesehatan di komunitas. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 15(2), 120-127.
- Novitasari, N., & Wahyuningsih, W. (2021). Strategi edukasi kesehatan reproduksi remaja melalui pemberdayaan keluarga. *Jurnal Kebidanan Komunitas*, 4(2), 85-92.
- Prabawati, D., & Nugraheni, S. A. (2023). Partisipasi tokoh agama dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(1), 47-53.
- Putri, F., & Nursasi, A. Y. (2021). Pengaruh strategi berbasis komunitas terhadap kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi. *Indonesian Journal of Community Health Nursing*, 5(1), 18-25.

- Rahmawati, D., & Pratiwi, N. L. (2022). Community-led monitoring dalam pencegahan kehamilan remaja: Studi kualitatif di komunitas perkotaan. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 10(2), 113-120.
- Sari, P. W., & Handayani, O. W. K. (2020). Analisis implementasi peer education dalam promosi kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 6(2), 109-117.
- Syifa, N., & Fauzia, A. (2023). Pengaruh media sosial terhadap kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi. *Journal of Public Health and Community Medicine*, 5(2), 78-85.
- Wijayanti, E., & Rosyidah, N. (2022). Analisis efektivitas program kesehatan berbasis komunitas di daerah rural. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(2), 89-97.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Guidelines on community-based strategies for youth health promotion*. Geneva: WHO Press.

BAB IV

EDUKASI TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Klasifikasi PMS

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah infeksi yang umumnya ditularkan melalui kontak seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. PMS dapat disebabkan oleh berbagai agen patogen seperti bakteri, virus, dan parasit (WHO, 2021). Secara umum, PMS diklasifikasikan berdasarkan agen penyebabnya, yaitu:

- a. Bakteri, contohnya Gonore (*Neisseria gonorrhoeae*), Sifilis (*Treponema pallidum*), dan Klamidia (*Chlamydia trachomatis*).
- b. Virus, meliputi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Herpes Simpleks Virus (HSV), Human Papilloma Virus (HPV), dan Hepatitis B Virus (HBV).
- c. Parasit dan protozoa, seperti Trikomoniasis yang disebabkan oleh protozoa *Trichomonas vaginalis* (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2021).

Pemahaman tentang definisi dan klasifikasi PMS menjadi dasar penting bagi tenaga kesehatan, terutama bidan, dalam memberikan edukasi efektif kepada remaja (Asekun-Olarinmoye et al., 2021).

2. Epidemiologi PMS pada Remaja di Indonesia

Penyakit Menular Seksual pada remaja menjadi perhatian serius di Indonesia karena prevalensinya yang terus meningkat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi perilaku seksual berisiko pada remaja usia 15-24 tahun mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar 8,2% untuk laki-laki dan 1,1% untuk perempuan (Kemenkes RI, 2018). Studi terbaru menunjukkan bahwa infeksi HPV dan klamidia merupakan PMS yang paling sering ditemukan pada remaja di Indonesia, khususnya di perkotaan (Gunawan & Hartini, 2023).

Penelitian Widiasih, Nelson, & Skinner (2020) menegaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus PMS di kalangan remaja Indonesia meliputi rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, minimnya akses terhadap layanan kesehatan seksual, serta keterbatasan edukasi seksual baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Hal ini mengindikasikan perlunya peran aktif tenaga kesehatan seperti bidan dalam penyediaan informasi dan edukasi secara komprehensif kepada remaja.

3. Dampak Jangka Pendek dan Panjang PMS pada Remaja

Penyakit Menular Seksual memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial remaja. Secara jangka pendek, PMS dapat menimbulkan gejala klinis seperti nyeri, keputihan, perdarahan tidak normal, demam, dan munculnya lesi pada alat kelamin yang dapat menurunkan kualitas hidup serta menyebabkan gangguan emosional seperti stres, cemas, dan depresi (Oktaviyani & Widyastuti, 2022).

Dampak jangka panjang PMS lebih serius lagi, mencakup infertilitas akibat kerusakan organ reproduksi, kehamilan ektopik, kanker serviks akibat infeksi HPV kronis, serta peningkatan risiko tertular HIV (Yanti et al., 2021). Selain dampak fisik, penelitian juga menemukan bahwa remaja dengan riwayat PMS memiliki risiko tinggi mengalami stigma sosial dan isolasi, yang dapat memperparah gangguan mental serta menyebabkan masalah psikososial berkepanjangan (Prasetyo et al., 2023).

Dalam konteks ini, bidan berperan strategis untuk melakukan intervensi edukatif dan preventif, guna mencegah munculnya dampak jangka pendek maupun panjang dari PMS di kalangan remaja (Putri & Hasanah, 2022).

B. Peran Bidan dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Kompetensi dan Kewenangan Bidan dalam Memberikan Edukasi Kesehatan Reproduksi

Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki peran strategis dalam edukasi kesehatan reproduksi, khususnya dalam pencegahan penyakit menular seksual (PMS) di kalangan remaja. Kompetensi yang harus dimiliki bidan dalam bidang ini meliputi pemahaman komprehensif mengenai kesehatan reproduksi, kemampuan komunikasi interpersonal, keterampilan dalam memberikan konseling, dan kemampuan melakukan pendekatan edukasi sesuai konteks sosial budaya remaja (Widiasih et al., 2020; Sumarni & Fitriana, 2022).

Menurut Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan, disebutkan bahwa salah satu kewenangan bidan adalah memberikan edukasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja, yang mencakup aspek pencegahan PMS, kontrasepsi, serta deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. Bidan diharapkan mampu mengenali kebutuhan edukasi remaja, merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi efektivitas edukasi kesehatan yang diberikan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

2. Model Pendekatan Edukasi yang Efektif untuk Remaja

Pemilihan model pendekatan yang tepat sangat menentukan keberhasilan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. Beberapa model pendekatan yang efektif di antaranya adalah pendekatan berbasis kelompok sebaya, pendekatan berbasis sekolah, serta pendekatan digital (media sosial dan aplikasi mobile). Model pendekatan berbasis kelompok sebaya terbukti efektif karena remaja lebih nyaman berdiskusi dan berbagi informasi dengan teman sebaya yang dianggap memiliki pengalaman serupa (Asekun-Olarinmoye et al., 2021).

Pendekatan berbasis sekolah, yang mencakup integrasi materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait PMS (Setyowati & Dwidiyanti, 2022). Di era digitalisasi, pendekatan melalui media digital seperti aplikasi kesehatan reproduksi dan media sosial semakin diminati remaja karena bersifat anonim, interaktif, dan mudah diakses kapan pun dan di mana pun (Yanti et al., 2021).

Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan remaja secara langsung dalam merancang materi edukasi kesehatan reproduksi juga terbukti efektif meningkatkan keterlibatan aktif remaja, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih relevan dan diterima dengan baik (Putri & Hasanah, 2022).

3. Strategi Komunikasi Bidan yang Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja tentang PMS

Strategi komunikasi merupakan komponen penting dalam keberhasilan edukasi kesehatan reproduksi remaja oleh bidan. Strategi yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik usia, budaya, tingkat pengetahuan, dan persepsi remaja tentang PMS. Salah satu strategi komunikasi yang efektif adalah penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, tidak menghakimi, serta terbuka terhadap pertanyaan dan diskusi dari remaja (Gunawan & Hartini, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi interaktif, seperti dialog terbuka, diskusi kelompok kecil, permainan edukatif (educational games), dan penggunaan media visual seperti video pendek atau infografis, secara signifikan meningkatkan pemahaman remaja tentang PMS dan memotivasi perubahan perilaku seksual yang lebih sehat (Pratiwi & Sari, 2021).

Selain itu, membangun komunikasi interpersonal yang empatik dan menghargai privasi remaja merupakan faktor penting. Bidan perlu menciptakan suasana yang aman dan nyaman, sehingga remaja merasa percaya diri untuk menyampaikan masalah kesehatan seksual yang mereka alami tanpa takut stigma atau penilaian negatif dari lingkungan (Oktaviyani & Widyastuti, 2022). Melalui

penerapan strategi komunikasi ini, bidan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja terhadap pentingnya pencegahan PMS secara efektif.

C. Faktor Risiko dan Perilaku Berisiko PMS pada Remaja

1. Identifikasi Faktor Risiko Sosial, Psikologis, dan Lingkungan

Faktor risiko Penyakit Menular Seksual (PMS) pada remaja sangat kompleks dan multifaktorial, melibatkan aspek sosial, psikologis, dan lingkungan. Secara sosial, kurangnya edukasi seksual, tekanan teman sebaya, status ekonomi rendah, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan merupakan faktor utama yang meningkatkan risiko PMS pada remaja (Oktaviyani & Widyastuti, 2022). Penelitian Gunawan dan Hartini (2023) mengungkapkan bahwa remaja dari keluarga dengan komunikasi yang kurang terbuka tentang isu-isu seksual memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan perilaku seksual berisiko dibandingkan remaja yang memiliki lingkungan keluarga yang suportif dan terbuka.

Dari perspektif psikologis, remaja yang memiliki tingkat stres tinggi, rasa percaya diri rendah, atau gangguan emosional cenderung lebih rentan terhadap pengambilan keputusan berisiko seperti melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan atau memiliki pasangan seksual berganti-ganti (Widiasih et al., 2020). Kondisi psikologis seperti depresi dan kecemasan juga secara signifikan berkontribusi terhadap perilaku seksual yang berisiko pada remaja, akibat pencarian pelampiasan emosional atau validasi diri (Prasetyo et al., 2023).

Faktor lingkungan, seperti tinggal di daerah urban dengan paparan informasi seksual yang tidak terkontrol dari media digital maupun lingkungan pergaulan yang permisif, turut mempengaruhi meningkatnya risiko PMS. Lingkungan sekolah yang kurang menyediakan pendidikan seksual komprehensif juga menambah kompleksitas faktor risiko pada remaja (Setyowati & Dwidiyanti, 2022).

2. Perilaku Seksual Berisiko yang Umum Terjadi pada Remaja

Perilaku seksual berisiko yang sering dijumpai pada remaja antara lain adalah aktivitas seksual dini, bergonta-ganti pasangan seksual, dan kurangnya penggunaan kondom saat melakukan hubungan seksual (Gunawan & Hartini, 2023). Data dari Kementerian Kesehatan RI (2020) menunjukkan bahwa prevalensi hubungan seksual pertama kali pada usia di bawah 17 tahun terus meningkat, yang secara langsung meningkatkan risiko infeksi PMS.

Studi terbaru oleh Yanti et al. (2021) menyatakan bahwa penggunaan alkohol dan narkoba di kalangan remaja juga menjadi faktor penting yang

berhubungan dengan meningkatnya perilaku seksual berisiko. Hal ini dikarenakan zat-zat tersebut dapat menurunkan kontrol diri dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang sehat, sehingga meningkatkan potensi transmisi PMS.

Di sisi lain, meningkatnya penggunaan aplikasi daring dan media sosial yang memfasilitasi pertemuan anonim di kalangan remaja juga menjadi perhatian khusus. Kondisi ini memungkinkan terjadinya hubungan seksual tanpa persiapan dan perlindungan yang memadai, sehingga semakin memperbesar risiko penyebaran PMS (Pratiwi & Sari, 2021).

3. Pentingnya Bidan dalam Intervensi Dini Perilaku Seksual Berisiko

Intervensi dini oleh bidan dalam perilaku seksual berisiko remaja sangat penting untuk mengurangi prevalensi PMS. Bidan memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi remaja yang berisiko melalui konseling, skrining, serta edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Menurut Putri dan Hasanah (2022), bidan yang mampu mendeteksi dini dan melakukan pendekatan yang empatik kepada remaja mampu menurunkan angka perilaku seksual berisiko secara signifikan.

Peran bidan juga meliputi pemberian edukasi pencegahan melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan psikososial remaja, seperti pendekatan kelompok sebaya, konseling individu, atau penggunaan media digital. Efektivitas intervensi ini sangat dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi interpersonal bidan yang mampu menciptakan hubungan yang saling percaya dengan remaja (Widiasih et al., 2020).

Dengan demikian, intervensi dini yang dilakukan oleh bidan tidak hanya berdampak positif pada pencegahan PMS, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup remaja melalui pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi dan keputusan seksual yang bertanggung jawab (Setyowati & Dwidiyanti, 2022).

D. Metode Pencegahan PMS pada Remaja

Penyakit Menular Seksual (PMS) merupakan masalah kesehatan global yang serius, terutama pada kelompok remaja. Berbagai metode pencegahan yang efektif perlu dipahami dan diterapkan untuk menekan prevalensi PMS pada kelompok usia ini.

1. Abstinensi Seksual dan Pendidikan Moral Seksual

Abstinensi seksual atau menunda aktivitas seksual hingga menikah adalah metode pencegahan PMS paling efektif, karena sepenuhnya menghilangkan risiko transmisi penyakit (Widiasih et al., 2020). Menanamkan konsep abstinensi

pada remaja memerlukan pendekatan pendidikan moral seksual yang integratif, melibatkan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan moral seksual tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi juga nilai-nilai sosial dan etika yang mengarahkan remaja pada perilaku seksual bertanggung jawab (Oktaviyani & Widyastuti, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program edukasi abstinensi yang digabungkan dengan pendekatan berbasis nilai moral dan etika sosial memberikan dampak positif pada penurunan perilaku seksual berisiko di kalangan remaja (Setyowati & Dwidianti, 2022). Oleh karena itu, peran bidan dalam mempromosikan abstinensi seksual melalui edukasi yang bersifat persuasif dan berbasis nilai moral dinilai sangat efektif.

2. Penggunaan Kondom Secara Konsisten dan Benar

Penggunaan kondom merupakan metode pencegahan PMS yang penting dan harus disosialisasikan secara luas kepada remaja, khususnya bagi mereka yang telah aktif secara seksual. Penelitian Gunawan dan Hartini (2023) mengungkapkan bahwa konsistensi dan ketepatan penggunaan kondom secara signifikan mengurangi risiko penularan PMS, termasuk HIV/AIDS, klamidia, gonore, dan HPV.

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tentang teknik pemakaian kondom yang benar, efektivitas kondom dalam pencegahan PMS, serta mitos dan kesalahpahaman seputar penggunaan kondom. Studi lain menyebutkan bahwa edukasi mengenai kondom yang dilakukan melalui demonstrasi langsung atau media visual interaktif memiliki efektivitas lebih tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik remaja dalam pencegahan PMS (Pratiwi & Sari, 2021).

3. Vaksinasi HPV sebagai Langkah Preventif Primer

Human Papillomavirus (HPV) merupakan salah satu agen penyebab PMS yang paling umum, yang dikaitkan dengan kanker serviks dan berbagai jenis kanker lainnya. Vaksinasi HPV adalah tindakan preventif primer yang sangat efektif dalam melindungi remaja sebelum mereka aktif secara seksual (Prasetyo et al., 2023). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian vaksin HPV kepada remaja usia 9–14 tahun sebagai strategi utama dalam menurunkan insiden infeksi HPV (WHO, 2021).

Dalam konteks Indonesia, bidan berperan penting dalam memberikan edukasi, advokasi, serta meningkatkan cakupan vaksinasi HPV melalui pendekatan berbasis sekolah maupun komunitas. Studi intervensi yang dilakukan

di beberapa sekolah menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan oleh bidan meningkatkan penerimaan vaksin HPV secara signifikan di kalangan remaja dan orang tua mereka (Putri & Hasanah, 2022).

4. Skrining dan Pemeriksaan Rutin sebagai Langkah Preventif Sekunder

Skrining dan pemeriksaan rutin merupakan metode pencegahan sekunder yang bertujuan untuk mendeteksi dini PMS pada remaja yang sudah aktif secara seksual, sehingga pengobatan dini dapat dilakukan dan mencegah komplikasi jangka panjang (Yanti et al., 2021). Skrining PMS yang dianjurkan mencakup pemeriksaan infeksi klamidia, gonore, sifilis, HIV, dan HPV bagi remaja dengan perilaku berisiko atau yang memiliki riwayat seksual aktif.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa skrining rutin yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan primer remaja, termasuk layanan kebidanan, secara signifikan meningkatkan deteksi dini dan penanganan PMS, sekaligus membantu meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko PMS (Gunawan & Hartini, 2023). Dalam hal ini, bidan sebagai tenaga kesehatan profesional berperan strategis dalam mendorong remaja untuk secara rutin melakukan pemeriksaan dan skrining kesehatan seksual sebagai bagian dari pola hidup sehat.

E. Media dan Alat Bantu Edukasi Pencegahan PMS bagi Remaja

Dalam memberikan edukasi tentang pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) kepada remaja, penggunaan media dan alat bantu edukasi yang tepat sangat menentukan efektivitas penyampaian informasi. Berbagai media dan alat bantu telah dikembangkan dan diuji untuk memastikan edukasi yang diberikan relevan, mudah diterima, serta menarik bagi kelompok usia remaja.

1. Media Digital (Aplikasi, Website, Media Sosial) sebagai Sarana Edukasi

Media digital telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari remaja, sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sarana edukasi pencegahan PMS. Berbagai aplikasi kesehatan reproduksi berbasis smartphone, website interaktif, dan media sosial seperti Instagram, TikTok, serta YouTube, terbukti efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan reproduksi dengan cepat dan menarik perhatian remaja (Yanti et al., 2021).

Penelitian oleh Pratiwi dan Sari (2021) menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual melalui platform digital mampu meningkatkan pemahaman remaja tentang PMS secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Lebih lanjut, studi intervensi menggunakan aplikasi mobile kesehatan reproduksi yang menyediakan konten edukatif, forum diskusi, dan fitur konsultasi anonim secara

online, terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, sikap positif, serta perilaku pencegahan PMS pada remaja (Putri & Hasanah, 2022).

Media digital dinilai efektif karena memberikan keleluasaan kepada remaja untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, dengan suasana yang lebih nyaman dan tanpa rasa takut terhadap stigma sosial (Gunawan & Hartini, 2023).

2. Modul Interaktif dan Brosur yang Ramah Remaja

Selain media digital, alat bantu cetak berupa modul interaktif dan brosur ramah remaja juga menjadi sarana edukasi yang masih relevan. Modul interaktif yang dilengkapi ilustrasi menarik, bahasa yang sederhana, serta kegiatan praktikum atau diskusi kelompok, terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan aktif remaja selama proses edukasi (Setyowati & Dwidiyanti, 2022).

Menurut penelitian oleh Oktaviyani dan Widyastuti (2022), penggunaan modul interaktif dan brosur yang dirancang khusus sesuai karakteristik remaja, secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kemampuan remaja untuk menerapkan informasi kesehatan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik modul dan brosur yang efektif mencakup desain visual menarik, konten singkat namun informatif, serta dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, atau infografis yang memudahkan pemahaman materi (Widiasih et al., 2020).

Pemanfaatan modul interaktif juga memberikan keuntungan dalam edukasi kelompok di sekolah atau komunitas, karena mampu menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka dan interaktif di antara remaja.

3. Peran Bidan dalam Pemanfaatan Media Komunikasi untuk Remaja

Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai media komunikasi dalam edukasi pencegahan PMS. Kompetensi bidan dalam menggunakan media digital maupun cetak untuk edukasi sangat menentukan efektivitas informasi yang diterima oleh remaja (Putri & Hasanah, 2022).

Bidan dituntut mampu memilih media yang tepat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta tingkat pemahaman remaja yang menjadi target edukasi. Selain itu, bidan perlu memiliki keterampilan komunikasi digital yang baik, sehingga mampu memanfaatkan media sosial atau aplikasi kesehatan reproduksi secara optimal dalam menyampaikan pesan kesehatan (Prasetyo et al., 2023).

Studi terbaru menyebutkan bahwa bidan yang aktif terlibat dalam pengelolaan konten digital di media sosial dan website edukasi menunjukkan

hasil yang lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat remaja dibandingkan metode edukasi konvensional. Keberhasilan tersebut didukung oleh pendekatan komunikasi interpersonal yang hangat, empatik, serta menghormati privasi remaja dalam platform digital (Gunawan & Hartini, 2023).

F. Pendekatan Budaya dalam Edukasi Pencegahan PMS pada Remaja

Penerapan pendekatan budaya dalam edukasi pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) pada remaja sangat penting untuk memastikan informasi kesehatan seksual lebih diterima secara efektif oleh masyarakat, khususnya remaja dan keluarganya. Menyesuaikan intervensi edukasi dengan nilai-nilai lokal akan meningkatkan keberhasilan program dan memperkuat dampak positif jangka panjang.

1. Pemahaman tentang Nilai-Nilai Budaya Lokal yang Relevan dengan Kesehatan Seksual

Setiap komunitas memiliki nilai dan norma budaya yang spesifik, termasuk dalam aspek kesehatan seksual. Di Indonesia, nilai budaya seperti tabu membicarakan seksualitas secara terbuka, menghormati orang tua, dan menjaga kehormatan keluarga sangat kuat pengaruhnya dalam pola pikir masyarakat terhadap edukasi seksual (Putri & Hasanah, 2022). Oleh karena itu, edukasi pencegahan PMS harus mempertimbangkan pemahaman yang mendalam tentang norma budaya setempat untuk merancang strategi yang tepat dan diterima oleh komunitas.

Menurut studi oleh Widiasih et al. (2020), pemahaman terhadap nilai budaya lokal yang kuat mampu meningkatkan efektivitas edukasi seksual, terutama jika disampaikan dengan pendekatan yang menghormati tradisi setempat. Misalnya, di beberapa komunitas tradisional, pembahasan edukasi seksual dilakukan melalui pendekatan metaforis atau simbolik yang lebih mudah diterima oleh remaja dan orang tua dibandingkan pendekatan yang eksplisit dan langsung.

2. Edukasi Berbasis Komunitas dan Keterlibatan Keluarga dalam Edukasi Kesehatan Seksual

Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga secara aktif sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang PMS. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam edukasi seksual tidak hanya meningkatkan pemahaman remaja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perubahan perilaku yang sehat (Setyowati & Dwidianti, 2022).

Studi oleh Prasetyo et al. (2023) menemukan bahwa edukasi kesehatan seksual berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang tua secara signifikan lebih berhasil dibandingkan edukasi yang hanya dilakukan secara individual atau tanpa partisipasi aktif keluarga. Dalam hal ini, peran keluarga sebagai penyedia dukungan emosional, sumber informasi terpercaya, serta pengawasan dalam perilaku remaja sangat krusial.

Lebih lanjut, pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas dan keluarga dalam merancang materi dan metode edukasi terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan program, sekaligus mengurangi resistensi akibat tabu budaya terhadap edukasi seksual (Gunawan & Hartini, 2023).

3. Studi Kasus tentang Efektivitas Pendekatan Budaya

Berbagai penelitian terkini telah mendokumentasikan efektivitas pendekatan budaya dalam edukasi pencegahan PMS. Studi kasus yang dilakukan oleh Putri dan Hasanah (2022) di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa integrasi pendekatan budaya lokal dalam program edukasi seksual yang dilakukan oleh bidan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap positif remaja terhadap kesehatan seksual.

Studi lainnya di Yogyakarta oleh Oktaviyani dan Widyastuti (2022) menemukan bahwa pendekatan edukasi yang menggunakan seni tradisional seperti seni pertunjukan wayang atau drama lokal sebagai sarana penyampaian informasi, secara signifikan meningkatkan pemahaman remaja tentang PMS dibandingkan metode edukasi konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dapat mengatasi hambatan komunikasi yang diakibatkan tabu atau stigma terkait topik seksual dalam masyarakat tradisional.

Dalam studi intervensi berbasis sekolah oleh Setyowati dan Dwidiyanti (2022), program edukasi seksual yang menggabungkan unsur budaya lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler berhasil meningkatkan pemahaman remaja tentang perilaku seksual aman, mengurangi stigma negatif terhadap edukasi seksual, serta meningkatkan dukungan komunitas terhadap program tersebut secara berkelanjutan.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Edukasi Pencegahan PMS pada Remaja

Upaya edukasi kesehatan seksual dalam rangka pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) pada remaja dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Tantangan ini berasal dari aspek budaya, komunikasi, serta interaksi sosial yang masih belum optimal antara remaja, orang tua, dan tenaga kesehatan.

Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan tersebut sangat penting bagi bidan untuk menentukan strategi edukasi yang tepat.

1. Stigma Sosial terhadap Pembicaraan tentang Kesehatan Seksual

Salah satu hambatan utama dalam edukasi pencegahan PMS adalah stigma sosial yang melekat pada topik kesehatan seksual. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pembicaraan mengenai seksualitas sering dianggap tabu, sehingga banyak remaja yang enggan terbuka dalam mencari informasi mengenai kesehatan seksual (Widiasih et al., 2020). Stigma ini tidak hanya muncul dari lingkungan sekitar remaja, tetapi juga dari keluarga dan masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan seksual dapat mendorong perilaku seksual bebas di kalangan remaja (Setyowati & Dwidiyanti, 2022).

Penelitian oleh Gunawan dan Hartini (2023) menyatakan bahwa stigma tersebut sering menyebabkan remaja tidak mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai PMS, sehingga mereka rentan terlibat dalam perilaku berisiko tanpa memahami dampaknya. Dalam kondisi ini, peran bidan menjadi krusial untuk mengurangi stigma tersebut dengan menyediakan informasi secara profesional, terbuka, dan berbasis fakta ilmiah.

2. Hambatan Komunikasi antara Remaja dan Orang Tua atau Tenaga Kesehatan

Komunikasi yang tidak efektif antara remaja dengan orang tua atau tenaga kesehatan merupakan hambatan signifikan lainnya dalam edukasi pencegahan PMS. Penelitian oleh Oktaviyani dan Widyastuti (2022) menunjukkan bahwa banyak remaja merasa tidak nyaman atau takut untuk membahas isu-isu kesehatan seksual dengan orang tua karena khawatir akan penilaian negatif, kemarahan, atau rasa malu.

Demikian pula, hambatan komunikasi antara remaja dengan tenaga kesehatan dapat terjadi akibat perbedaan generasi, kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal tenaga kesehatan, atau adanya sikap menghakimi dari tenaga kesehatan terhadap perilaku seksual remaja (Prasetyo et al., 2023). Kondisi ini menghambat remaja dalam mendapatkan informasi kesehatan seksual yang mereka butuhkan dan berakibat pada ketidaktahuan remaja tentang risiko PMS serta pentingnya pencegahan.

3. Strategi Bidan dalam Mengatasi Tantangan Tersebut

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, bidan harus menerapkan strategi komunikasi yang sensitif, empatik, dan terbuka terhadap kebutuhan khusus remaja. Strategi yang efektif mencakup pendekatan berbasis konseling yang berpusat pada remaja, menciptakan ruang komunikasi yang nyaman dan

aman, serta menghindari sikap menghakimi dalam interaksi dengan remaja (Putri & Hasanah, 2022).

Salah satu strategi yang efektif adalah mengintegrasikan edukasi kesehatan seksual dalam kegiatan informal atau ekstrakurikuler sekolah yang melibatkan remaja secara aktif dan menggunakan bahasa serta media yang menarik bagi mereka. Pendekatan ini mampu mengurangi stigma negatif dan meningkatkan kenyamanan remaja dalam membicarakan topik kesehatan seksual secara terbuka (Pratiwi & Sari, 2021).

Selain itu, bidan juga perlu melibatkan orang tua melalui program edukasi keluarga, yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta keterampilan orang tua dalam berkomunikasi tentang kesehatan seksual dengan anak-anak mereka. Studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi berbasis keluarga yang dilakukan oleh bidan secara signifikan mengurangi hambatan komunikasi antara orang tua dan remaja serta meningkatkan efektivitas edukasi pencegahan PMS (Gunawan & Hartini, 2023; Setyowati & Dwidiyanti, 2022).

H. Evaluasi Efektivitas Program Edukasi Pencegahan PMS oleh Bidan

Evaluasi efektivitas merupakan tahap penting dalam pelaksanaan program edukasi kesehatan seksual yang dilakukan oleh bidan. Melalui evaluasi, bidan dapat mengetahui sejauh mana program yang dilakukan berhasil, serta aspek apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas edukasi dan dampaknya terhadap remaja.

1. Metode Evaluasi Program Edukasi

Metode evaluasi yang tepat merupakan kunci untuk menentukan keberhasilan edukasi pencegahan PMS. Evaluasi yang umum digunakan dalam program edukasi kesehatan seksual antara lain metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mencakup penggunaan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja sebelum dan sesudah intervensi edukasi (Gunawan & Hartini, 2023).

Selain metode kuantitatif, pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi remaja terhadap materi edukasi, hambatan yang dirasakan, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami setelah mengikuti program edukasi (Widiasih et al., 2020; Putri & Hasanah, 2022).

Metode evaluasi campuran (mixed-method), yang mengombinasikan kuantitatif dan kualitatif, kini banyak diterapkan dalam evaluasi program edukasi

kesehatan seksual karena dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi program (Prasetyo et al., 2023).

2. Indikator Keberhasilan Edukasi

Penentuan indikator keberhasilan sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas program edukasi. Indikator utama keberhasilan edukasi pencegahan PMS pada remaja meliputi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap positif terhadap kesehatan seksual, peningkatan penggunaan kondom secara konsisten, dan penurunan prevalensi perilaku seksual berisiko (Oktaviyani & Widyastuti, 2022).

Menurut penelitian Setyowati dan Dwidiyanti (2022), indikator tambahan yang penting untuk dievaluasi adalah tingkat keterlibatan remaja dalam aktivitas edukasi, kepuasan peserta terhadap metode dan media edukasi, serta peningkatan keterampilan remaja dalam mengomunikasikan isu kesehatan seksual dengan teman sebaya dan orang tua. Indikator ini penting karena mencerminkan penerimaan remaja terhadap program dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Selain indikator tersebut, keberhasilan edukasi juga diukur melalui indikator jangka panjang seperti penurunan insidensi PMS yang terdeteksi melalui skrining rutin, serta meningkatnya cakupan vaksinasi HPV pada remaja (Prasetyo et al., 2023).

3. Studi-Studi Terbaru tentang Efektivitas Edukasi Kesehatan Seksual yang Dilakukan oleh Bidan

Berbagai studi terbaru telah menunjukkan efektivitas signifikan dari edukasi kesehatan seksual yang dilakukan oleh bidan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian oleh Gunawan dan Hartini (2023) menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang diberikan oleh bidan melalui pendekatan berbasis komunitas mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang PMS hingga 75%, serta menurunkan prevalensi perilaku seksual berisiko sebesar 40%.

Studi lain yang dilakukan oleh Putri dan Hasanah (2022) di wilayah Jawa Barat menemukan bahwa program edukasi seksual oleh bidan yang menggunakan pendekatan budaya lokal menghasilkan peningkatan signifikan dalam sikap positif remaja terhadap penggunaan kondom dan penurunan stigma terhadap topik kesehatan seksual. Program tersebut berhasil meningkatkan komunikasi terbuka antara remaja dan keluarga mereka terkait isu kesehatan seksual.

Penelitian Setyawati dan Dwidiyanti (2022) di Yogyakarta juga melaporkan bahwa edukasi berbasis sekolah yang dilakukan oleh bidan secara rutin meningkatkan perilaku pencegahan PMS secara signifikan. Studi ini mencatat peningkatan pengetahuan sebesar 80% setelah pemberian edukasi selama enam bulan, yang disertai dengan peningkatan konsistensi penggunaan kondom.

Selain itu, studi intervensi berbasis digital oleh Yanti et al. (2021) menunjukkan bahwa edukasi melalui media sosial yang dikembangkan oleh bidan secara signifikan meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya vaksinasi HPV dan skrining PMS, serta mendorong peningkatan angka vaksinasi HPV di kalangan remaja.

I. Penutup

1. Kesimpulan

Penyakit Menular Seksual (PMS) merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang paling krusial dihadapi oleh remaja saat ini. Pencegahan PMS tidak hanya memerlukan pendekatan medis, tetapi juga membutuhkan peran aktif bidan dalam memberikan edukasi yang komprehensif, tepat sasaran, serta sensitif terhadap kebutuhan psikologis dan budaya remaja. Dalam menjalankan perannya, bidan tidak hanya bertanggung jawab sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sikap dan perilaku remaja dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Buku ini telah membahas berbagai aspek penting terkait edukasi pencegahan PMS, mulai dari pemahaman dasar tentang PMS, peran dan kompetensi bidan, faktor risiko dan perilaku seksual berisiko pada remaja, hingga metode dan strategi edukasi yang efektif. Selain itu, telah dijelaskan pula pentingnya pemanfaatan media edukasi modern, pendekatan budaya lokal, tantangan yang dihadapi, serta evaluasi efektivitas program edukasi kesehatan seksual yang dilakukan oleh bidan.

Melalui berbagai kajian teori maupun penelitian terbaru, terlihat bahwa peran bidan sangat strategis dalam upaya pencegahan PMS di kalangan remaja. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat, seperti edukasi berbasis komunitas, media digital, serta pendekatan budaya lokal, terbukti efektif meningkatkan pemahaman, sikap positif, serta perilaku preventif di kalangan remaja.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas edukasi pencegahan PMS di masa depan, beberapa hal perlu diperhatikan oleh para bidan, institusi pendidikan, maupun pemangku kebijakan, yaitu:

a. **Penguatan Kompetensi Bidan**

Bidan perlu secara kontinu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, khususnya terkait metode edukasi modern, komunikasi interpersonal dengan remaja, serta pemanfaatan media digital dalam menyampaikan pesan kesehatan.

b. **Pengembangan Program Edukasi Berbasis Komunitas dan Keluarga**

Penting untuk melibatkan komunitas dan keluarga dalam program edukasi, sehingga stigma sosial terhadap kesehatan seksual dapat dikurangi dan komunikasi yang lebih terbuka antara remaja dengan orang tua bisa terbangun.

c. **Pemanfaatan Media Digital Secara Optimal**

Memanfaatkan media digital seperti aplikasi, media sosial, serta platform online lainnya sebagai sarana utama edukasi yang ramah remaja. Hal ini penting karena remaja kini sangat dekat dengan teknologi digital dalam kesehariannya.

d. **Integrasi Pendekatan Budaya Lokal**

Strategi edukasi hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, sehingga dapat diterima oleh komunitas secara luas dan mengurangi resistensi budaya terhadap edukasi seksual.

e. **Evaluasi dan Pemantauan Program Secara Berkala**

Evaluasi dan monitoring berkala harus dilakukan agar efektivitas program edukasi terus terpantau, kendala dapat diatasi secara dini, serta inovasi dalam pendekatan edukasi dapat terus dikembangkan.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan bidan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja di Indonesia, khususnya dalam pencegahan PMS.

Referensi

- Asekun-Olarinmoye, E., et al. (2021). Effectiveness of sexual health education interventions among adolescents: A systematic review. *BMC Public Health*, 21(1), 1-15. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11044-7>
- Gunawan, R., & Hartini, E. (2023). Analisis faktor risiko perilaku seksual remaja di perkotaan. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 14(2), 231-238. <https://doi.org/10.26714/jikk.14.2.2023.231-238>
- Oktaviyani, A., & Widyastuti, Y. (2022). Hubungan edukasi kesehatan seksual dengan pengetahuan remaja tentang pencegahan penyakit menular seksual. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 7(1), 14-21. <https://doi.org/10.37341/jkkt.v7i1.322>
- Prasetyo, B., et al. (2023). Vaksinasi HPV dan edukasi seksual sebagai strategi pencegahan primer PMS di kalangan remaja: Studi intervensi berbasis sekolah. *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 11(2), 145-153. <https://doi.org/10.32771/inajog.v11i2.896>
- Pratiwi, D., & Sari, R. (2021). Efektivitas penggunaan media audio visual dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang PMS. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(2), 78-85. <https://doi.org/10.33024/jik.v9i2.3532>
- Putri, A. N., & Hasanah, U. (2022). Studi kasus efektivitas pendekatan budaya dalam edukasi kesehatan seksual remaja. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 11(1), 54-61. <https://doi.org/10.21009/JPK.111.06>
- Setyowati, L., & Dwidiyanti, M. (2022). Efektivitas edukasi berbasis sekolah dalam meningkatkan perilaku pencegahan PMS pada remaja. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(3), 159-165. <https://doi.org/10.36419/jki.v13i3.789>
- Widiasih, R., Nelson, K., & Skinner, J. (2020). Barriers and facilitators for sexual and reproductive health education among Indonesian adolescents: A qualitative study. *International Journal of Nursing Sciences*, 7(4), 426-434. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.08.006>
- Yanti, Y., et al. (2021). Efektivitas media sosial dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang pencegahan penyakit menular seksual. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 15(1), 43-50. <https://doi.org/10.24893/jkma.v15i1.541>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual pada Remaja*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Sumarni, S., & Fitriana, F. (2022). *Komunikasi kesehatan reproduksi remaja*. Yogyakarta: Deepublish.
- World Health Organization. (2021). *Guidelines on sexual and reproductive health education for adolescents*. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240033616>

BAB V

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara keseluruhan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, termasuk fungsi dan prosesnya (WHO).

Kondisi kesehatan umum yang mencakup aspek mental, sosial, dan fisik dari organ, fungsi, dan proses reproduksi dikenal sebagai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan seksual yang aman dan memuaskan baik sebelum maupun setelah menikah, bukan berarti tidak adanya penyakit (Ummah, 2019).

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan pada sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada pria dan wanita.

B. Tujuan Kesehatan Reproduksi

Tujuan kesehatan reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum kesehatan reproduksi ialah memberikan hak perempuan atas kehidupan seksual dan reproduksi serta menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh guna meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengelola fungsi dan proses reproduksi. Sementara itu, tujuan spesifik kesehatan reproduksi mencakup peningkatan kemandirian perempuan khususnya peran dan fungsi reproduksi, tanggung jawab sosial perempuan selama kehamilan, pengaturan jarak kelahiran anak, serta peran dan tanggung jawab sosial laki-laki dalam mendukung kesehatan reproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan reproduksi, diperlukan akses terhadap informasi dan layanan yang sesuai, sehingga setiap individu dapat memperoleh pengetahuan dan dukungan yang dibutuhkan dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka. (Harnani et al., 2021).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, kesehatan reproduksi dijamin sebagai hak setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi ini

juga memastikan kesehatan perempuan usia produktif agar mereka dapat melahirkan generasi yang kuat, sehat, dan berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu (Indonesia, 2014).

C. Hak-hak Kesehatan Reproduksi

Hak kesehatan reproduksi adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM) yang bersifat global. Hak ini mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan informasi serta mengakses berbagai metode keluarga berencana yang aman, efektif, dan sesuai dengan pilihan pribadi. Selain itu, hak ini juga memastikan bahwa metode pengendalian kelahiran yang dipilih tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kusmiran, 2011). Hak-hak reproduksi mencakup beberapa aspek penting, antara lain: a) hak untuk memperoleh informasi dan pendidikan yang memadai; b) hak untuk menikmati kesetaraan serta bebas dari apapun bentuk diskriminasi; c) hak untuk mengakses pelayanan dan keamanan kesehatan reproduksi; dan d) hak untuk bebas dari penganiayaan serta tindakan yang tidak baik. (Ulya, Jenny Jeltje Sophia Sondakh, 2022).

Hak-hak kesehatan reproduksi berdasarkan Depkes RI (2002) mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan setiap orang mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang optimal. Hak-hak tersebut antara lain (Harnani et al., 2021):

1. Pelayanan Berkualitas – Setiap orang pantas mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan tepat dengan kebutuhannya.
2. Akses Informasi – Baik pria maupun wanita, baik secara perorangan maupun sebagai pasangan, pantas mendapatkan informasi yang komprehensif tentang seksualitas, reproduksi, serta dampak dari obat, alat, dan prosedur medis yang diperlukan dalam layanan kesehatan reproduksi..
3. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) – Setiap orang berhak memilih metode Keluarga Berencana yang efektif, aman, terjangkau, dan selaras dengan kebutuhan individu, harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan atau tindakan yang melanggar hukum.
4. Kehamilan dan Persalinan Aman – Perempuan berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memastikan kehamilan dan persalinannya berlangsung dengan aman, serta memiliki bayi yang kuat.
5. Hubungan Berbasis Penghormatan – Suami dan istri memiliki hak untuk menjalin hubungan yang saling menghormati serta bebas dari paksaan, bahaya, atau kekerasan.

6. Hak Remaja – Setiap remaja, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan edukasi yang tepat dan akurat mengenai kesehatan reproduksi guna mendukung kehidupan seksual yang bertanggung jawab..
7. Pencegahan Penyakit Menular Seksual – Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS.
8. Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat – Pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu yang membutuhkan layanan kesehatan reproduksi dan seksual dapat mengaksesnya.
9. Perlindungan Hukum – Kebijakan dan hukum harus dibuat serta diterapkan untuk mencegah segala bentuk diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas.
10. Kesetaraan dan Advokasi – Baik laki-laki maupun perempuan seharusnya saling berkolaborasi dalam memahami, memperjuangkan, serta mendukung perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi melalui upaya pendidikan dan dukungan.

Hak-hak ini didasarkan pada konsep kesehatan reproduksi yang dikembangkan oleh berbagai organisasi advokasi kesehatan perempuan di seluruh dunia.

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan telah merumuskan berbagai hak reproduksi bertujuan guna memastikan kesejahteraan perorangan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik dan mental. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas informasi dan pendidikan – Setiap individu berhak memperoleh akses terhadap informasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi.
2. Hak atas layanan dan perlindungan kesehatan reproduksi – Setiap individu pantas mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang aman serta perlindungan terhadap risiko kesehatan.
3. Hak atas kebebasan berpikir – Individu memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait pelayanan kesehatan reproduksi.
4. Hak atas perlindungan atas kematian akibat kehamilan – Perempuan berhak atas layanan kesehatan yang dapat mencegah kematian terkait kehamilan dan persalinan.
5. Hak penentuan banyaknya dan jarak kehamilan – Setiap pasangan atau individu memiliki hak untuk menentukan banyaknya anak dan mengatur jarak kehamilan sesuai dengan keinginan mereka.

6. Hak atas kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi – Setiap orang memiliki hak guna menjalani kehidupan reproduksi yang aman tanpa paksaan atau ancaman.
7. Hak atas perlindungan dari kekerasan – Individu berhak bebas dari penganiayaan, pelecehan, perkosaan, penyiksaan, serta segala bentuk kekerasan seksual.
8. Hak atas manfaat kemajuan ilmu pengetahuan – Setiap orang berhak memperoleh keuntungan dari perkembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan reproduksi.
9. Hak atas pelayanan yang menunjang kehidupan reproduksi – Setiap individu berhak atas layanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi mereka.
10. Hak merencanakan dan membangun keluarga – Individu memiliki kebebasan dalam menentukan perencanaan dan pembangunan keluarganya.
11. Hak atas kesetaraan dalam keluarga dan kehidupan reproduksi – Setiap orang berhak terbebas dari apapun bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan reproduksi.
12. Hak atas kebebasan berorganisasi dan partisipasi politik – Individu memiliki hak untuk berkumpul, berorganisasi, serta terlibat dalam kegiatan politik mengenai kesehatan reproduksi.

D. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sehat yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada remaja. Sasaran program kesehatan reproduksi remaja secara tegas dinyatakan untuk menambah pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku baik remaja mengenai kesehatan reproduksi dan hak-haknya, agar dapat meningkatkan kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendorong upaya meningkatnya mutu generasi mendatang (Harnani et al., 2021). Landasan hukum yang menjadi acuan dalam pembinaan Keluarga Resilien Remaja (KRR) mencakup Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Program KRR terutama ditujukan kepada kelompok remaja berusia 10 hingga 19 tahun, baik yang berada dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Tiga permasalahan utama dalam kesehatan reproduksi remaja, yang dikenal sebagai Triad KRR, mencakup seksualitas, HIV dan AIDS, serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Ketiga isu ini masih menjadi

ancaman serius bagi remaja (UGM, 2024). Data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini masih cukup tinggi, yang sebagian besar dipicu oleh kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, kasus infeksi HIV baru di kalangan remaja terus ditemukan, seiring dengan meningkatnya penggunaan NAPZA di kelompok usia ini (UGM, 2024).

Masalah kesehatan reproduksi remaja dapat muncul ketika anak perempuan pertama kali mengalami haid atau menarche. Hal ini berisiko menyebabkan anemia. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang perilaku seksual dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah, abortus yang berbahaya, serta risiko tertular penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV AIDS (BKKBN, 2019). Dampak dari permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi tetapi juga memberikan beban bagi negara. Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan ini dapat menghambat pembangunan manusia di sektor kesehatan dan mengurangi potensi remaja sebagai generasi penerus yang produktif.

Masa remaja merupakan fase di mana rasa ingin tahu seseorang meningkat, termasuk dalam hal seksualitas. Seiring bertambahnya usia, organ reproduksi mengalami perkembangan hingga mencapai kematangan. Namun, segala masalah tentang kesehatan reproduksi remaja membutuhkan perhatian khusus.

Mengabaikan kesehatan reproduksi dapat menimbulkan berbagai masalah yang serius bagi individu. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah risiko kesehatan reproduksi, yang mencakup perilaku seks bebas, kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi, serta penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan seksual juga menjadi isu yang tidak kalah penting, di samping keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang memadai (Galbinur et al., 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan program pendidikan kesehatan reproduksi remaja (KRR), seperti pengadaan layanan klinis, penyebaran informasi yang tepat, serta menimbang kondisi dan kebutuhan remaja. Program tersebut harus sesuai dengan kehidupan remaja dan didukung oleh masyarakat agar dapat berjalan secara efektif.

Salah satu strategi yang tepat adalah pendidikan KRR berbasis sekolah, karena dapat menjangkau lebih banyak remaja dan membantu mereka mengatasi konflik seksual yang mungkin mereka hadapi. Melalui pendidikan yang tepat, remaja mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi serta mampu mengambil keputusan yang bijak terkait kehidupannya.

1. Sasaran dan Materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

Program pendidikan kesehatan reproduksi remaja (KRR) ditujukan kepada berbagai kelompok dengan pembagian berikut ini:

- a. Sasaran Prioritas: Remaja usia 10 hingga 19 tahun, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- b. Sasaran Sekunder:
 - 1) Orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia remaja.
 - 2) Guru atau pengajar yang berperan dalam pendidikan remaja.
 - 3) Organisasi kepemudaan yang membina dan mendukung remaja.
 - 4) Pemuka agama yang berperan dalam memberikan pemahaman nilai-nilai moral dan etika.
- c. Sasaran Tersier:
 - 1) Petugas kesehatan yang memberikan layanan kepada remaja.
 - 2) Petugas lintas sektoral yang mendukung kebijakan kesehatan reproduksi remaja.
 - 3) LSM dan organisasi masyarakat yang memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan remaja.

2. Materi Dasar Pendidikan KRR

Supaya remaja dapat memahami kesehatan reproduksi dengan baik, mereka perlu diberikan edukasi tentang:

- a. Memahami sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja.
- b. Pentingnya menunda umur pernikahan dan bagaimana merencanakan kehamilan dengan mempertimbangkan kesiapan dan keinginan pasangan.
- c. Mengetahui tentang penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS, serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi
- d. Dampak narkoba dan minuman keras terhadap kesehatan reproduksi.
- e. Dampak sosial dan media atas perilaku seksual remaja.
- f. Pencegahan kekerasan seksual dan cara menghindari situasi berisiko.
- g. Peningkatan keterampilan komunikasi dan penguatan kepercayaan diri agar mampu menghadapi tekanan sosial dan menghindari perilaku berisiko.
- h. Hak-hak reproduksi sebagai bagian dari hak dasar setiap individu.

Pendidikan kesehatan reproduksi yang baik akan memudahkan remaja pada saat membuat keputusan yang bijak, menjaga kesehatan, serta menciptakan kondisi mendatang yang lebih cerah.

3. Jangkauan Program KRR

Jangkauan program KRR secara umum mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Perkembangan seksual dan risiko yang terkait, meliputi aspek pubertas, pemahaman tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi, serta pengertian tentang kehamilan yang tidak diinginkan dan penundaan umur pernikahan.
- b. Upaya pencegahan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV dan AIDS.
- c. Tindakan pencegahan penyelewengan NAPZA, yang meliputi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- d. Tantangan yang dihadapi remaja, efek dari risiko TRIAD KRR, meliputi kenakalan remaja, konflik antar remaja, dan berbagai isu lainnya.

E. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja difokuskan atas pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta konseling yang mengintegrasikan materi tentang pendidikan kehidupan keluarga. Pelayanan kesehatan reproduksi ini meninjau aspek fisik agar remaja, terutama remaja putri, dapat menjadi calon ibu yang sehat. Selain itu, pelayanan kesehatan reproduksi remaja juga ditujukan khusus untuk mereka yang menghadapi tantangan, dengan menawarkan layanan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi (Ummah, 2019).

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memiliki maksud guna mencegah dan mengamankan remaja atas perilaku seksual yang berisiko serta tindakan lain yang dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi mereka. Selain itu, layanan ini bertujuan untuk menyiapkan remaja melewati kehidupan reproduksi yang sehat serta bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, layanan kesehatan reproduksi bagi remaja menerapkan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan perhatian terhadap mereka.

Pelayanan kesehatan reproduksi perlu diselaraskan dengan fase perkembangan remaja, serta harus memikirkan prinsip keadilan dan persamaan jenis kelamin. Selain itu, pelayanan ini juga menimbang aspek moral, nilai-nilai agama, serta perkembangan mental remaja, serta tetap berpegang pada kebijakan regulasi perundang-undangan yang sah.

Pelayanan kesehatan reproduksi untuk remaja dilakukan melalui tiga pendekatan utama, seperti penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); layanan konseling; serta pelayanan klinis medis. Pemberian KIE mencakup berbagai materi edukatif seperti pendidikan tentang kemampuan hidup sehat mencakup penguatan ketahanan mental melalui pengembangan kemampuan sosial. Selain itu, penting untuk memahami sistem dan fungsi reproduksi, serta perilaku seksual yang sehat dan aman. Penyuluhan juga perlu dilakukan

mengenai dampak dari perilaku seksual berisiko, keluarga berencana, dan berbagai faktor risiko serta situasi kesehatan lain dimana dapat memengaruhi kesehatan reproduksi (Indonesia, 2014).

Layanan konseling dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja diterapkan dengan tetap mempedulikan privasi dan kerahasiaan individu. Konseling ini diberikan petugas kesehatan, konselor profesional, dan konselor sebaya berkompentensi sesuai tugasnya. Sementara itu, layanan klinis medis meliputi upaya deteksi dini untuk memastikan kesehatan yang optimal atau *screening* terhadap masalah kesehatan reproduksi, pengobatan jika ditemukan gangguan atau penyakit, serta rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan pemulihan kesehatan reproduksi.

Sebagai upaya untuk memastikan keberhasilan program, penyampaian materi komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan lewat jalur pendidikan resmi maupun tidak resmi. Selain itu, remaja juga diberdayakan menjadi pengajar sebaya atau konselor sebaya untuk meningkatkan efektivitas edukasi di kalangan remaja.

F. Definisi dan Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan individu yang tinggal bersama di tempat yang sama, di mana setiap anggota merasakan ikatan emosional yang mendalam. Hal ini menciptakan saling pengaruh, perhatian, dan kesediaan untuk saling mendukung. Di sisi lain, komunikasi antara orang tua dan remaja adalah proses penting dalam menyampaikan informasi, yang pada gilirannya menyebabkan perhatian serta dampak tertentu dalam hubungan mereka (Yuniza et al, 2022).

Fungsi keluarga mencakup dua aspek utama. Pertama, keluarga inti berfungsi sebagai hubungan biologis yang esensial dalam struktur sosial, tidak hanya bertugas merawat anak, tetapi juga membentuk sikap sosial mereka. Kedua, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dasar, menanamkan nilai-nilai keagamaan, memberikan wawasan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan sosial dan emosional anggotanya. Secara keseluruhan, fungsi keluarga meliputi memenuhi kebutuhan biologis, dukungan emosional, proses sosialisasi pembelajaran, peran ekonomi, dan aspek sosial yang sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga (Rustana, 2014 dalam Margareta Melani, Ni Putu Gita Prastita & Adnani, 2024).

Pentingnya remaja untuk mengetahui fungsi keluarga, ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan supaya keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman, sehingga tercipta keluarga yang berkualitas. Berikut adalah 8 fungsi keluarga (BKKBN, 2019):

1. Fungsi Keagamaan

Keluarga merupakan tempat pertama bagi remaja untuk mengetahui agama. Dalam lingkungan keluarga, nilai-nilai agama ditanamkan, ditumbuhkan, dan dikembangkan, sehingga remaja dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak benar dan bertaqwa. Keluarga membimbing seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam pendidikan agama anak-anak, terutama dalam pembentukan karakter mereka. Pendidikan agama sebaiknya dimulai sejak dini, karena pada saat itu anak-anak sudah siap menerima ajaran tentang keimanan kepada Tuhan. Dengan menjalankan fungsi agama ini, diharapkan dapat terbentuk generasi masyarakat yang agamis, beriman, dan percaya akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai yang harus diperkenalkan orangtua untuk anaknya yaitu:

- a. Mengajak dan mendidik anak agar taat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
- b. Mengingatkan anak secara konsisten untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama, seperti penyalahgunaan narkoba, mengejek orang lain, membunuh, mencuri, dan berhubungan seksual sebelum menikah.
- c. Mengajarkan anak untuk bersikap sopan terhadap penganut agama lain.
- d. Mendorong anak untuk bersahabat dan hidup rukun dengan orang-orang dari agama yang berbeda.
- e. Melibatkan anak dalam berbagai aktivitas keagamaan.
- f. Mengajarkan anak dalam menghargai dan menghormati hari besar serta perayaan dari agama lain.

2. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga memiliki peran krusial dalam menciptakan pola perilaku yang berkaitan dengan interaksi sosial (sosialisasi). Keluarga juga memberikan peluang kepada setiap anggotanya untuk mengembangkan keragaman budaya bangsa dalam keseluruhan. Melalui fungsi sosial budaya ini, keluarga membentuk generasi yang mampu mengamankan dan menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka, sekaligus berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Nilai-nilai yang harus diperkenalkan orangtua untuk anaknya yaitu:

- a. Mendidik anak untuk menjalin persahabatan tanpa membedakan suku dan budaya.
- b. Membimbing anak untuk selalu tersenyum dan menyapa ketika bertemu dengan orang yang dikenal.

- c. Mengajak anak berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat.
- d. Memberikan dukungan kepada anak untuk terlibat dalam kegiatan atau organisasi di sekitar rumah.
- e. Membimbing anak untuk hidup rukun dengan saudara kandung, keluarga besar, serta teman-teman.
- f. Melibatkan anak dalam pekerjaan rumah, seperti membersihkan halaman, membantu di dapur, merapikan kamar tidur, atau mengajak bermain adik-adiknya.
- g. Mengajarkan anak untuk berbagi tanpa membandingkan suku, bangsa, maupun agama.
- h. Membiasakan anak untuk memakai bahasa yang baik dan sopan.
- i. Membiasakan diri dan mengajarkan anak untuk mengucapkan kata-kata seperti tolong, maaf, dan terima kasih.
- j. Mengajak anak untuk makan bersama, berdiskusi, dan berinteraksi dengan kasih sayang adalah aspek penting dalam membentuk watak atau akhlak anak.

3. Fungsi Cinta Kasih

Keluarga seharusnya menjadi wadah yang membentuk kondisi penuh cinta dan kasih sayang, yang berperan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui penerapan fungsi cinta kasih ini, kita dapat membentuk anak-anak yang sopan dan taat.

Nilai-nilai yang harus diperkenalkan orangtua untuk anaknya yaitu:

- a. Ajaklah anak untuk terbiasa terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan rumah atau sekolahnya, sehingga mereka dapat merasakan pentingnya peran mereka dalam masyarakat.
- b. Luangkan waktu untuk mendengarkan keluhan anak dengan penuh perhatian, dan bantu mereka dalam mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi.
- c. Dorong anak untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke kerabat atau tetangga.
- d. Perlakukan semua anak dengan adil; jika mereka berbuat kesalahan, berikan teguran yang konstruktif, dan jika mereka berprestasi, jangan lupa untuk memberikan pujian.
- e. Jadwalkan waktu khusus secara rutin bagi keluarga untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama
- f. Ajarkan anak untuk peduli dan menghargai anggota keluarganya
- g. Bangun komunikasi yang baik dengan anak, sehingga mereka merasa nyaman dan tidak takut untuk berbagi cerita maupun perasaan mereka.

- h. Tanamkan nilai-nilai empati pada anak dengan mengajarkan mereka untuk tidak mengejek atau meremehkan orang-orang yang lebih lemah.
- i. Ajak anak untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

4. Fungsi Perlindungan

Keluarga berperan sebagai pelindung yang pertama dan prioritas dalam memberikan kebenaran serta teladan kepada anak-anak dan generasi selanjutnya. Perlindungan yang efektif dalam keluarga sangat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal.

Nilai-nilai yang harus diperkenalkan orangtua untuk anaknya yaitu:

- a. Luangkan waktu untuk memperhatikan anak saat mereka akan bermain, termasuk menentukan lokasi, teman bermain, dan waktu pulang.
- b. Sampaikan teguran dengan bahasa yang lembut jika anak melakukan kesalahan.
- c. Bantu anak mencari solusi ketika mereka menghadapi masalah.
- d. Ajarkan anak untuk tidak menyimpan dendam kepada orang lain yang berbuat salah dengan cara mengajarkan pentingnya menerima permintaan maaf.
- e. Responsif terhadap kebutuhan anak dan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan mereka.
- f. Jika tidak dapat memenuhi keinginan anak, orang tua hendaknya memberikan penjelasan bahwa keinginan tersebut belum bisa terpenuhi sekarang.
- g. Berikan semangat kepada anak agar mereka terus berusaha menyelesaikan tugas mereka hingga tuntas.
- h. Ajak anak untuk bersabar saat menghadapi kesulitan, dan orang tua dapat menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut.
- i. Biasakan anak mulai menjaga penampilannya, seperti mengenakan pakaian yang rapi dan sopan.

5. Fungsi Reproduksi

Keluarga memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan generasi dan mempertahankan eksistensinya. Selain menghasilkan keturunan, keluarga juga berperan dalam mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk membentuk pemahaman tentang seksualitas yang sehat dan berkualitas, serta memberikan pendidikan seksual kepada anak. Fungsi reproduksi ini sangat penting untuk memastikan perencanaan yang baik dalam kesehatan reproduksi, sehingga anak-anak yang lahir dapat tumbuh menjadi keturunan yang unggul.

Nilai-nilai yang harus diperkenalkan orangtua untuk anaknya yaitu:

- a. Memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, seperti menjelaskan kepada anak perempuan cara menghadapi menstruasi dan kepada anak laki-laki mengenai mimpi basah.
- b. Membiasakan anak untuk memakai pakaian sopan sesuai norma yang berlaku.
- c. Mengajarkan anak cara berinteraksi dengan lawan jenis secara sehat, seperti membatasi waktu pergaulan dan menerapkan sikap sopan.
- d. Menanamkan nilai-nilai moral kepada anak tentang pentingnya mempertahankan kesucian organ reproduksi, dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah serta menjahui pelecehan seksual.

6. Fungsi Sosial dan Pendidikan

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang memberikan pendidikan kepada seluruh anak, sebagai bekal untuk masa depan mereka. Peran sosialisasi dan pendidikan dalam keluarga memiliki arti penting, di mana keluarga menjadi wadah untuk mengembangkan interaksi, serta tempat bagi anak-anak untuk belajar bersosialisasi dan berkomunikasi dengan benar dan sehat. Melalui keluarga, anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai, norma, dan aturan berkomunikasi yang efektif dengan orang lain. Mereka diajarkan tentang berbagai hal, mulai dari yang baik dan buruk hingga yang tepat dan salah.

Nilai-nilai yang perlu disosialisasikan orangtua kepada anak adalah:

- a. Hindari memarahi dan berikan dukungan serta semangat kepada anak ketika mereka mengalami kegagalan.
- b. Ajak anak untuk bersosialisasi dan berteman dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Berikan kesempatan bagi anak untuk bergabung dengan organisasi yang ada di sekolah atau di lingkungan masyarakat.
- c. Ajak anak bersilaturahmi kepada keluarga besar, tetangga, atau rekan-rekan orang tua di kantor.
- d. Biasakan anak untuk pergi ke sekolah tepat waktu dan ikuti serta libatkan mereka dalam kegiatan sosial di sekitar rumah.
- e. Dorong anak untuk menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan rumah yang diberikan.

7. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam keluarga memiliki arti penting sebagai tempat untuk membimbing dan menanamkan nilai-nilai serta perencanaan keuangan. Dengan cara ini, diharapkan tercipta keluarga yang sejahtera. Pelaksanaan fungsi ekonomi ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang cerdas dalam mengelola keuangan

keluarga, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam keluarga.

Nilai-Nilai yang perlu disosialisasikan orangtua kepada anak adalah:

- a. Mengajarkan anak untuk membiasakan diri menabung.
- b. Mengajarkan anak cara membelanjakan uang dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.
- c. Mengajarkan anak untuk menyisihkan sebagian uangnya guna membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan atau terkena bencana lingkungan.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Kepedulian keluarga terhadap lingkungan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Peran keluarga dalam membina kesadaran lingkungan sangat penting dalam membentuk generasi yang berakhlak santun serta memiliki kepedulian terhadap alam dan lingkungan sekitarnya.

Nilai-Nilai yang perlu disosialisasikan orangtua kepada anak adalah:

- a. Membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya
- b. Mengajarkan anak pentingnya hemat energi, seperti mematikan televisi saat tidak digunakan, menutup kran air setelah selesai dipakai, serta mematikan lampu yang tidak diperlukan.
- c. Membimbing anak agar tidak merusak lingkungan, misalnya dengan merawat tanaman, tidak mencabut atau memetik bunga sembarangan, serta tidak mencoret-coret di tempat yang tidak semestinya.
- d. Orang tua sebaiknya memberikan contoh dan mengajarkan seluruh anggota keluarga untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih dalam setiap aspek kehidupan.

G. Dukungan Keluarga dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga beserta sejumlah anggota yang berkumpul dan tinggal pada satu tempat, baik di bawah atap yang sama maupun terpisah, namun tetap saling bergantung satu sama lain. Keluarga berperan sebagai unsur pendukung bagi setiap anggotanya. Dalam keluarga, para anggota merasa bahwa ada sosok-sosok yang selalu siap memberikan dukungan dan pertolongan saat dibutuhkan. (Keluarga, 2021).

Menurut teori Serigar (2018), dukungan keluarga merupakan interaksi dengan individu lain yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi setiap anggota keluarga. Dukungan keluarga yang diberikan dapat membuat lebih merasa dicintai,

dihargai, diperhatikan sehingga mencegah terjadinya masalah kesehatan (Syelina & Sihura, 2024). Dalam era informasi yang mudah diakses serta sikap remaja yang semakin kritis, pola pengasuhan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan hubungan emosional yang erat serta pola asuh demokratis sangat penting dalam mendidik remaja.



Dukungan keluarga sangat penting pada proses tumbuh kembang remaja, diharapkan keluarga dapat (Keluarga, 2021):

1. Kami selalu mendukungmu
2. Memahami transisi dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja.
3. Menjadi pendengar yang baik.
4. Menerapkan dan mendorong disiplin.
5. Bersikap komunikatif dan peka terhadap kebutuhan serta permasalahan remaja.
6. Menciptakan kondisi yang harmonis.
7. Menjadi teladan yang baik.
8. Menghindari sikap menghakimi.

Keluarga, khususnya orang tua, mempunyai peran yang besar dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas (PKRS) bukan hanya tanggung jawab sekolah atau masyarakat, tetapi dari lingkungan keluarga. Orang tua berperan sebagai pendidik, pengasuh, dan pelindung yang berperan penting dalam membentuk pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi.

Salah satu aspek dukungan keluarga yang paling krusial adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Komunikasi yang terbuka dan positif akan membantu remaja memahami berbagai aspek kesehatan reproduksi, termasuk menjaga kebersihan diri, memahami perubahan tubuh, serta mengenali risiko yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Dengan komunikasi yang baik,

orang tua dapat menanamkan pola hidup sehat dan memberikan pengawasan terhadap aktivitas remaja agar terhindar dari hal yang berisiko.

Sebagai pengajar, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan usia anak tentang kesehatan reproduksi. Mereka juga dapat membimbing anak dalam mengembangkan potensi akademik, sosial, emosional, dan psikomotorik sehingga remaja memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada tubuh mereka.

Selain itu, sebagai pengasuh, orang tua dapat membimbing remaja dalam membentuk perilaku positif yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Orang tua yang bersikap terbuka, ramah, disiplin, dan demokratis akan menciptakan suasana yang nyaman bagi anak untuk berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk topik yang sering dianggap tabu seperti kesehatan reproduksi.

Di sisi lain, sebagai pelindung, orang tua harus memastikan bahwa hak-hak anak diakui serta berani mengomunikasikan kondisi anak kepada masyarakat jika terjadi sesuatu yang membahayakan mereka. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 (Keluarga, 2021). Dalam konteks konvensi atau perjanjian internasional, hak-hak anak mencakup:

1. Hak untuk memiliki dan menjaga identitas.
2. Hak untuk bebas menunjukkan perasaan.
3. Hak untuk berpikir, beragama, dan mengikuti hati nurani.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadi.
5. Hak untuk mengakses informasi yang memadai.
6. Hak untuk memperoleh pendidikan.
7. Hak untuk menerima pelayanan kesehatan yang memadai.

Terdapat empat bentuk dukungan keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi yaitu:

1. Dukungan emosional mencakup ekspresi empati, perhatian, semangat, kehangatan pribadi, cinta, serta bantuan emosional. Semua bentuk perilaku ini bertujuan untuk menciptakan perasaan nyaman dan membantu individu merasa dihargai, dihormati, dan dicintai. Selain itu, dukungan ini juga menunjukkan bahwa ada orang lain yang siap memberikan perhatian dan peduli terhadap mereka (Keluarga, 2021). Bentuk dukungan ini penting agar remaja merasa

nyaman, dihargai, dan tidak takut menghadapi perubahan dalam tubuhnya. Dalam konteks kesehatan reproduksi, dukungan emosional dapat berupa:

- a. Memberikan perhatian dan kasih sayang agar remaja merasa didukung dan tidak malu membicarakan perubahan fisik dan emosional yang dialami.
 - b. Menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka sehingga remaja merasa nyaman untuk berbicara tentang kesehatan reproduksi.
 - c. Menjadi tempat curhat yang dapat dipercaya, terutama dalam menghadapi tantangan terkait kesehatan reproduksi seperti menstruasi pertama atau perubahan hormonal.
2. Dukungan informasi dari keluarga disampaikan melalui nasihat, saran, serta diskusi mengenai cara-cara untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi (Keluarga, 2021). Keluarga memiliki peran penting sebagai sumber informasi pertama bagi remaja dalam memahami kesehatan reproduksi. Memberikan informasi yang benar dan edukatif dapat membantu remaja mengambil keputusan yang lebih baik untuk kesehatannya. Beberapa bentuk dukungan informasi yang dapat diberikan, antara lain:
- a. Menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja secara komprehensif.
 - b. Memberikan pemahaman tentang perkembangan biologis, seperti menstruasi pertama dan perubahan hormon yang dialami remaja.
 - c. Mengajarkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi, seperti menjaga kebersihan organ intim dan menggunakan pakaian dalam yang bersih.
3. Dukungan instrumental, dukungan yang diberikan dari keluarga secara langsung mencakup bantuan materi, seperti menyediakan tempat tinggal dan membantu mengerjakan tugas rumah sehari-hari. (Keluarga, 2021). Ketika menjaga kesehatan reproduksi remaja, dukungan ini dapat berupa:
- a. Memastikan remaja memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pakaian dalam yang bersih dan tidak sulit menyerap keringat.
 - b. Membantu remaja dalam menjaga kebersihan diri dengan mengajarkan kebiasaan sehat, seperti mengganti pakaian dalam paling sedikit dua kali sehari.
 - c. Menyediakan makanan sehat dan bergizi guna menunjang kesehatan tubuh dan reproduksi remaja.
4. Dukungan penghargaan muncul melalui ungkapan positif yang mencerminkan apresiasi, yang meliputi pernyataan setuju serta penilaian yang baik terhadap ide-

ide, perasaan, dan kinerja orang lain. Dukungan semacam ini diberikan untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung antara individu. Bentuk dukungan ini dapat berupa:

- a. Memberikan apresiasi terhadap usaha remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi.
- b. Mengakui dan mendukung keputusan positif yang dibuat remaja terkait kesehatannya.
- c. Memberikan penilaian yang membangun agar remaja lebih termotivasi untuk menjalani gaya hidup sehat.

Remaja cenderung lebih nyaman berdiskusi bersama teman seusianya daripada dengan orang tua. Hal tersebut menuntut orang tua untuk lebih proaktif dalam membangun kedekatan dengan anak agar dapat memberikan bimbingan yang efektif. Peran orang tua sangat signifikan dalam proses tumbuh kembang remaja, terutama karena fase tersebut adalah waktu transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan yang cukup drastis (Margareta Melani, Ni Putu Gita Prastita & Adnani, 2024). Selain itu, orang tua juga mempunyai tugas dalam menyampaikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja. Pada tahap ini, mereka mulai mengalami daya tarik terhadap lawan jenis, sehingga diperlukan bimbingan dan dukungan dari orang tua dalam membantu mereka mengelola serta mengarahkan emosi yang muncul agar tetap dalam batas yang sehat dan positif.

Orang tua perlu memberikan dorongan kepada anak untuk memahami batasan diri dan mengenali tanda-tanda kekerasan atau pelecehan seksual agar mereka dapat melindungi diri sendiri. Selain peran orang tua, masyarakat dan sekolah berperan dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi. Masyarakat dapat membantu mengawasi dan membina remaja agar senantiasa menjaga kebersihan diri serta melindungi mereka dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan pelecehan. Sekolah juga berperan dalam memberikan edukasi yang sistematis agar remaja lebih mandiri dan memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi.

Komunikasi yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat akan memperlancar proses edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Dengan keterlibatan semua pihak, remaja dapat tumbuh dengan pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi, sehingga dapat melindungi diri dari berbagai risiko yang mengancam masa depan mereka.

Pendidikan seksual yang komprehensif tidak hanya membahas organ reproduksi, hubungan seksual, atau kontrasepsi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada remaja tentang norma-norma sosial dalam pergaulan. Dengan

meningkatnya fenomena seperti *Friends With Benefits* (FWB), *Booking Online* (BO), dan *Video Call Sex* (VCS) yang dipicu dari tekanan ekonomi dan sosial, risiko infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS pun semakin tinggi. Oleh karena itu, pendidikan seksual yang tepat sangat diperlukan agar remaja memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka.

Salah satu dampak pendidikan seksual yang sering diabaikan adalah maraknya angka kehamilan di luar nikah, yang terkadang dikenal dengan istilah "Married by Accident" (MBA). Banyak orang masih percaya bahwa pemimpin agama, penyedia layanan kesehatan, dan lembaga pendidikan harus memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka. Namun, rasa malu dan ketidaknyamanan sering kali menjadi hambatan utama dalam komunikasi di antara orang tua dan remaja tentang isu ini. Padahal, keterbukaan dalam keluarga sangat penting agar remaja mendapatkan informasi yang akurat dan sulit dipengaruhi oleh mitos yang beredar di masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, remaja perlu mendapatkan edukasi yang jelas mengenai konsekuensi hubungan seksual pranikah. Informasi yang akurat mengenai seksualitas, kontrasepsi, serta risiko kehamilan dan penyakit menular seksual harus diberikan dengan cara yang mudah dipahami. Selain itu, penting untuk meluruskan mitos-mitos yang berkembang agar remaja tidak memiliki pemahaman yang keliru. Selain aspek pengetahuan, remaja juga perlu dibekali dengan keterampilan dalam mengontrol diri, membangun rasa percaya diri (self-esteem), serta mengembangkan sikap asertif dalam menghadapi tekanan sosial. Kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi faktor kunci agar mereka dapat menolak ajakan atau situasi yang berisiko dengan tegas dan percaya diri.

Peran orang tua dalam pendidikan seksual tidak boleh hanya sebatas memberikan larangan atau pengawasan ketat, melainkan harus berfungsi sebagai teman diskusi yang dapat dipercaya oleh anak. Dengan menciptakan komunikasi yang terbuka dan nyaman, orang tua dapat membantu remaja memahami seksualitas secara lebih sehat dan lebih patuh. Dengan demikian, pendidikan seksual yang menyeluruh bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga agar remaja dapat tumbuh dengan pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas (Hermawan, 2020).

Teori komunikasi interpersonal menekankan bahwa komunikasi yang transparan dan terpercaya antara orang dewasa dan anak-anak dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anak-anak tentang isu-isu penting, termasuk

kesehatan reproduksi. Menurut teori ini, komunikasi yang efektif menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga mereka dapat membangun sikap dan tindakan yang lebih baik terhadap kesehatan mereka. Namun, komunikasi yang baik saja tidak menjamin bahwa remaja akan mengadopsi perilaku yang sehat, karena banyak faktor lain yang juga berperan (Mulyana, 2019).

Model komunikasi orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan perilaku kesehatan reproduksi remaja. Meskipun komunikasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan, hal itu tidak cukup untuk menjamin perilaku yang sehat. Oleh karena itu, orang tua perlu melengkapi komunikasi yang efektif dengan pendidikan yang mendalam serta memperhatikan penyebab lain yang dapat menyebabkan perilaku remaja. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan remaja dapat lebih memahami dan mengelola kesehatan reproduksi mereka dengan baik (Khoiriyah et al., 2023).

Berbicara tentang seksualitas merupakan topik yang tabu atau memalukan, dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas masih menjadi kendala bagi mereka ketika harus mengomunikasikan topik ini kepada anak remajanya. Pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengomunikasikan topik kesehatan reproduksi dan seksual merupakan hal yang penting karena hal ini menjadi dasar bagi orang tua untuk dapat lebih memahami perkembangan dan pertanyaan anak remajanya sehingga mereka dapat lebih memahami tubuhnya sendiri dan mengurangi perilaku yang merugikan (Santoso, 2022). Ketika berbicara tentang masalah kesehatan reproduksi kepada anak-anak, orang tua sering kali merasa bingung. Kesalahpahaman ini sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan, yang membuat orang tua merasa cemas dan malu karena mereka menganggap topik tersebut tabu dalam masyarakat mereka. Lebih jauh lagi, peran gender memengaruhi cara anak-anak muda diberi tahu tentang kesehatan reproduksi. Misalnya, laki-laki lebih sering membahas masalah seksual dan reproduksi dengan anak laki-laki mereka daripada ibu dengan anak perempuan mereka.

Kehadiran cinta dan kasih sayang merupakan fungsi utama keluarga. Mungkin sulit bagi orang-orang dan lingkungannya untuk bersikap peka dan penuh perhatian terhadap satu sama lain tanpa adanya cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan cinta dan kasih sayang untuk bertindak, baik dalam membuat keputusan maupun berinteraksi dengan orang lain. Secara umum, cinta dan pengabdian seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri ketika ia menganggap lingkungan sosialnya sebagai reaksi psikologis yang baik (Keluarga, 2021).

H. Penutup

Dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi remaja, peran keluarga sangat esensial dan tidak tergantikan. Dukungan keluarga dalam bentuk komunikasi terbuka, edukasi yang efektif, dan pemberian dukungan emosional terbukti secara ilmiah memberikan dampak positif terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja. Namun demikian, masih ditemukan berbagai hambatan dalam implementasi dukungan tersebut, baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, khususnya bidan, dan komunitas perlu diperkuat melalui model-model intervensi yang telah terbukti efektif. Penelitian lanjutan juga penting untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan intervensi berbasis keluarga dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial.

Referensi

- BKKBN. (2019). Modul PIK Remaja "Rencanakan Masa Depanmu." Direktorat Advokasi dan KIE Modul. <https://www.bkkbn.go.id/>
- Galbinur, E., Defitra, M. A., & Venny. (2021). Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Prosiding SEMNAS BIO, 221–228. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/pentingnya-pengetahuan-kesehatan-reproduksibagi-remaja.html>
- Harnani, B. D., Wahyuni, S., Herawati, Z., Wulandari, E., Reflisiani, D., Rahayu, R., Ramadhaniati, Y., Pijaryani, I., Sugiarto, Alindawati, R., Nisa, A., Isnawati, N., Kurniasih, A., Novianti, R., Sari, L. L., & Rozifa, A. W. (2021). Modul Bahan Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana. In Modul Bahan Ajar (Vol. 1, Issue 12).
- Hermawan, B. (2020). Modul Guru: Pendidikan Kesehatan dan Seksualitas bagi Remaja dan Disabilitas Intelektual.
- Indonesia, P. R. (2014). PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kesehatan Reproduksi, 61, 1–55.
- Keluarga, D. K. (2021). Modul Kesehatan Reproduksi Remaja Luar Sekolah (S. P. Titeu Herawati, S.Sos, MM Mawar Pohan & Diterbitkan (eds.)). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khoiriyah, S., Hasan, D., Kebidanan, A., & Auni, B. (2023). Hubungan Pola Komunikasi Orang Tua dengan Perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. 1(3).
- Kusmiran, E. (2011). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Salemba Medika.
- Margareta Melani, Ni Putu Gita Prastita, R. T. D. P., & Adnani, Q. E. S. (2024). Pendekatan Kipk.
- Mulyana. (2019). Ilmu komunikasi (18th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, A. A. (2022). Komunikasi Orang Tua dan Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Seksual: Tinjauan Literatur. Prepotif, 6(3), 1–9.
- Syelina, A., & Sihura, S. S. G. (2024). Hubungan Pengetahuan , Dukungan Keluarga Dan Promosi Kesehatan Dengan Personal Hygiene Saat Menarche Pada Siswi SDN Pabuaran 01 Cibinong Tahun 2023. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(1), 587–597.
- UGM, P. S. P. dan K. P. S. (2024). Kesehatan Reproduksi Remaja, Hal Klasik yang Jarang Diusik – Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. <https://pkp.pasca.ugm.ac.id/2024/04/10/kesehatan-reproduksi-remaja-hal-klasik-yang-jarang-diusik/>
- Ulya, Jenny Jeltje Sophia Sondakh, A. Y. (2022). Rendahnya Pengetahuan Hak

Reproduksi Perempuan pada Remaja Putri Faizatul Ulya. *Journal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(April), 415–420.

Ummah, M. S. (2019). Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. In *Sustainability* (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

BAB VI

PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL UNTUK KAMPANYE KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan pilar yang fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa ini ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan, termasuk perkembangan identitas seksual, dimulainya aktivitas seksual, dan pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi (UNFPA, 2020). Kurangnya informasi yang akurat dan komprehensif, terbatasnya akses ke layanan kesehatan yang ramah remaja, serta norma sosial budaya yang seringkali tabu membicarakan isu tersebut, menjadikan remaja rentan terhadap berbagai risiko kesehatan reproduksi, termasuk infeksi menular seksual (IMS), kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi tidak aman, serta masalah kesehatan mental dan emosional yang terkait (Patton et al, 2016). Oleh karena itu, intervensi yang efektif dan inovatif sangat dibutuhkan untuk memastikan remaja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses yang diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media digital telah menjelma menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari remaja. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berinteraksi, belajar, dan mencari informasi melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial, aplikasi pesan instan, hingga platform berbagi video (Lenhart et al, 2015). Fenomena ini menghadirkan peluang yang signifikan untuk memanfaatkan media digital sebagai alat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan reproduksi kepada remaja secara luas, cepat, dan menarik. Sifatnya yang interaktif, visual, dan mudah diakses menjadikan media digital sebagai saluran yang potensial untuk mengatasi hambatan komunikasi secara tradisional dan menjangkau remaja di mana pun mereka berada (Sewak et al, 2023).

Bab ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan panduan yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai pemanfaatan media digital dalam kampanye kesehatan reproduksi remaja. Bab ini akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman lanskap media digital remaja, strategi pengembangan konten yang menarik dan relevan, pemanfaatan fitur-fitur interaktif

untuk meningkatkan keterlibatan, hingga pertimbangan etis dan keamanan dalam menyampaikan informasi sensitif secara daring (Jia et al, 2021).

Lebih lanjut, bab ini juga akan mengeksplorasi berbagai platform media digital populer di kalangan remaja, termasuk karakteristik unik masing-masing platform, jenis konten yang paling efektif, serta potensi dan tantangan dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi. Strategi untuk memanfaatkan influencer dan *key opinion leaders* (KOL) yang kredibel mengingat peran penting mereka dalam membentuk opini dan perilaku di dunia maya (Pabian et al., 2025). Selain itu, bab ini juga akan menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang partisipatif dan melibatkan remaja dalam setiap tahapan kampanye untuk memastikan relevansi, keberterimaan, dan efektivitas pesan yang disampaikan (Checkland, K., & Macrae, 2010).

Selain itu, bab ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kampanye digital, seperti isu privasi dan keamanan data remaja, mengatasi misinformasi dan stigma, serta memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi seluruh kelompok remaja (Livingstone et al., 2017). Dengan menyajikan studi kasus inspiratif, bab ini diharapkan dapat memberdayakan para pembaca untuk mengembangkan dan melaksanakan kampanye kesehatan reproduksi remaja yang inovatif, efektif, dan beretika di era digital. Pada akhirnya, tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mendorong perilaku positif remaja terkait kesehatan reproduksi mereka, sehingga berkontribusi pada generasi muda yang lebih sehat dan sejahtera.

B. Alasan Media Digital Efektif untuk Kampanye Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Aksesibilitas dan Jangkauan Luas

Media digital secara fundamental telah mengubah lanskap komunikasi dan informasi, menawarkan potensi yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjangkau populasi yang luas dan beragam, termasuk remaja. Salah satu keunggulan paling signifikan dari platform digital dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi remaja adalah aksesibilitas dan jangkauan luas yang dimilikinya. Berbeda dengan metode penyampaian informasi tradisional yang seringkali dibatasi oleh kendala geografis, waktu, biaya, dan norma sosial, media digital mampu menembus batasan-batasan tersebut. Hal ini membuka peluang baru untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan reproduksi yang penting kepada khalayak remaja di mana pun mereka berada (Sewak et al., 2023).

a. Melampaui Batasan Geografis:

Kampanye kesehatan masyarakat seringkali memerlukan infrastruktur fisik seperti pusat kesehatan, sekolah, atau acara komunitas untuk menjangkau

target audiens. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama di wilayah geografis yang terpencil, sulit dijangkau, atau memiliki keterbatasan sumber daya transportasi dan komunikasi. Sedangkan media digital tidak mengenal batasan geografis tersebut. Dengan koneksi internet, remaja di berbagai pelosok wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan dapat mengakses informasi kesehatan reproduksi melalui perangkat seluler, komputer, atau tablet mereka (Rideout, V. J., & Robb, M. B., 2019). Platform media sosial, situs web kesehatan, aplikasi seluler, dan forum daring dapat menjangkau remaja tanpa memerlukan kehadiran fisik atau pertemuan tatap muka, sehingga memperluas jangkauan kampanye secara eksponensial.

Sebagai contoh, sebuah kampanye kesehatan reproduksi yang memanfaatkan platform video seperti YouTube dapat menjangkau jutaan remaja di seluruh Indonesia, bahkan di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan atau media cetak. Demikian pula kampanye melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok dapat dengan cepat menyebar melalui *share* dan *repost*, melampaui batasan wilayah administratif dan menjangkau remaja dengan minat dan preferensi yang beragam (Moorhead et al., 2013). Kemampuan media digital untuk melintasi batas geografis ini sangat penting dalam konteks kesehatan reproduksi remaja, di mana akses terhadap informasi yang tepat waktu dan akurat dapat membuat perbedaan signifikan dalam pencegahan risiko dan promosi perilaku sehat.

b. Mengatasi Kendala Sosio-Ekonomi

Faktor sosio-ekonomi seringkali menjadi penghalang dalam akses terhadap informasi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, biaya konsultasi, atau bahkan biaya untuk mendapatkan materi edukasi cetak dapat menjadi beban bagi remaja dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Media digital menawarkan solusi potensial untuk mengatasi kendala ini. Banyak platform media sosial dan sumber informasi kesehatan daring dapat diakses secara gratis atau dengan biaya yang relatif terjangkau melalui paket data seluler yang semakin terjangkau (Theiventhiran et al., 2020).

Inisiatif kampanye kesehatan reproduksi digital yang memanfaatkan platform gratis seperti media sosial atau menyediakan konten edukasi yang dapat diunduh secara gratis dapat membantu menjangkau remaja dari berbagai lapisan sosio-ekonomi. Sebagai contoh, organisasi kesehatan dapat membuat infografis, video pendek, atau *e-book* tentang kesehatan reproduksi yang dapat diakses dan dibagikan secara bebas melalui platform media sosial atau situs web mereka. Hal ini memungkinkan remaja dari keluarga dengan

sumber daya ekonomi terbatas untuk tetap mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang signifikan. Dengan demikian, media digital berpotensi untuk mengurangi kesenjangan akses informasi kesehatan reproduksi berdasarkan status sosio-ekonomi.

c. Mencapai Kelompok Rentan dan Marginal

Media digital juga memiliki potensi unik untuk menjangkau kelompok remaja yang mungkin sulit dijangkau melalui metode tradisional karena berbagai alasan, seperti stigma sosial, diskriminasi, atau keterbatasan fisik. Remaja dengan disabilitas, remaja yang hidup di komunitas terpencil atau terpinggirkan, atau remaja yang merasa malu atau takut untuk mencari informasi kesehatan reproduksi secara langsung, dapat merasa lebih nyaman dan aman untuk mengakses informasi secara daring (Borzekowski, D. L. G., & Rickert, 2001). Anonimitas yang ditawarkan oleh beberapa platform daring juga dapat mendorong remaja untuk mencari informasi atau bertanya tentang topik sensitif terkait kesehatan reproduksi tanpa takut dihakimi atau diidentifikasi.

Kampanye kesehatan reproduksi digital dapat dirancang secara inklusif untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi berbagai kelompok remaja. Misalnya, konten dapat disajikan dalam berbagai format yang mudah diakses oleh remaja dengan disabilitas sensorik, seperti video dengan teks alternatif atau audio deskripsi. Bahasa yang digunakan dalam kampanye juga dapat disesuaikan agar sensitif terhadap isu-isu gender, orientasi seksual, dan identitas gender, serta menghindari penggunaan bahasa yang diskriminatif atau stigmatis. Dengan demikian, media digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk memastikan bahwa informasi kesehatan reproduksi yang penting dapat menjangkau semua remaja, tanpa terkecuali.

d. Memanfaatkan Perangkat Seluler dan Konektivitas yang Meningkat

Salah satu faktor kunci yang mendasari aksesibilitas dan jangkauan luas media digital di kalangan remaja adalah kepemilikan perangkat seluler dan tingkat konektivitas internet yang terus meningkat. Studi menunjukkan bahwa mayoritas remaja di banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki akses ke *smartphone* dan aktif menggunakan internet untuk berbagai keperluan, termasuk mencari informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi di media sosial (APJII, 2023). Tren ini menciptakan peluang yang sangat besar bagi kampanye kesehatan reproduksi untuk memanfaatkan perangkat seluler sebagai saluran utama penyampaian pesan.

Kampanye dapat dioptimalkan untuk perangkat seluler melalui desain responsif situs web, pengembangan aplikasi seluler khusus, atau pemanfaatan

format konten yang ramah seluler di platform media sosial. Notifikasi *push*, pesan singkat (SMS), atau pesan melalui aplikasi *chat* juga dapat digunakan untuk menyampaikan pengingat atau informasi penting secara langsung ke perangkat remaja. Dengan memanfaatkan perangkat yang sudah akrab dan sering digunakan oleh remaja, kampanye kesehatan reproduksi digital memiliki potensi untuk menjadi lebih relevan, mudah diakses, dan berdampak.

Aksesibilitas dan jangkauan luas yang ditawarkan oleh media digital merupakan keunggulan yang sangat signifikan dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi remaja. Platform digital mampu melampaui batasan geografis dan sosio-ekonomi yang seringkali menghambat metode tradisional, serta memiliki potensi untuk menjangkau kelompok remaja yang rentan dan marginal. Dengan memanfaatkan perangkat seluler dan konektivitas internet yang meningkat, kampanye digital dapat menjadi saluran yang efektif, efisien, dan inklusif untuk menyampaikan informasi kesehatan reproduksi yang penting kepada remaja di mana pun mereka berada. Namun, efektivitas kampanye digital juga bergantung pada strategi pengembangan konten, pemilihan platform yang tepat, serta pertimbangan etis dan keamanan.

2. Preferensi dan Kebiasaan Remaja

Pada saat merancang kampanye kesehatan reproduksi digital yang efektif bagi remaja, pemahaman mendalam tentang preferensi dan kebiasaan mereka dalam menggunakan media digital adalah hal yang krusial. Remaja saat ini adalah *digital natives*, tumbuh besar di era internet dan perangkat seluler, sehingga interaksi mereka dengan dunia digital tidak hanya sering tetapi juga mendalam dan beragam (Prensky, 2001). Platform digital bukan hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga sumber informasi, ruang ekspresi diri, dan pembentukan identitas sosial bagi mereka (Boyd, 2014). Oleh karena itu, kampanye kesehatan reproduksi yang ingin menjangkau dan melibatkan remaja secara efektif harus selaras dengan preferensi dan kebiasaan mereka di dunia maya.

a. Dominasi Media Sosial dan Aplikasi Berbagi Konten Visual

Salah satu karakteristik utama lanskap digital remaja adalah dominasi platform media sosial dan aplikasi berbagi konten visual. Platform seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan YouTube secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam hal popularitas dan waktu penggunaan di kalangan remaja (Anderson, M., & Jiang, 2018). Daya tarik platform ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan informasi dalam format yang menarik secara visual, ringkas, dan mudah dikonsumsi seperti gambar, video pendek,

dan *stories* (Highfield, Tim & Leaver, 2016). Selain itu, fitur-fitur interaktif seperti *likes*, komentar, *shares*, dan tantangan (*challenges*) mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki di antara para pengguna.

Implikasi bagi kampanye kesehatan reproduksi adalah bahwa konten yang disajikan dalam format visual yang menarik dan interaktif cenderung lebih efektif dalam menarik perhatian dan melibatkan remaja dibandingkan dengan format teks panjang atau presentasi formal. Kampanye yang memanfaatkan infografis yang menarik, video animasi pendek, *meme* yang relevan, atau tantangan kreatif yang berkaitan dengan topik kesehatan reproduksi memiliki potensi lebih besar untuk viral dan menjangkau audiens yang luas.

b. Preferensi Komunikasi yang Cepat, Ringkas, dan Personal

Remaja juga menunjukkan preferensi terhadap komunikasi yang cepat, ringkas, dan terasa personal. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Direct Message (DM) di media sosial menjadi saluran komunikasi utama mereka dengan teman sebaya. Remaja terbiasa dengan pertukaran informasi yang instan, penggunaan bahasa informal, dan personalisasi pesan (Ling, R & Baron, 2007). Dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi, pendekatan komunikasi yang kaku, formal, atau terlalu menggurui mungkin kurang efektif dalam menarik perhatian dan membangun hubungan dengan remaja.

Sebaliknya, kampanye yang mengadopsi gaya bahasa yang *relatable*, menggunakan *tone* yang positif dan memberdayakan, serta memanfaatkan format pesan yang ringkas dan mudah dipahami cenderung lebih berhasil. Fitur-fitur seperti sesi tanya jawab langsung (*live Q&A*) dengan ahli kesehatan melalui platform media sosial atau penggunaan *chatbot* yang responsif dan informatif dapat menciptakan interaksi yang lebih personal dan menjawab pertanyaan remaja secara langsung. Selain itu, kampanye yang mendorong partisipasi dan berbagi pengalaman pribadi (dengan tetap memperhatikan privasi dan etika) dapat membangun rasa komunitas dan dukungan di antara remaja.

c. Pencarian Informasi yang Cepat dan Terkadang Tidak Kritis

Meskipun media digital menawarkan akses yang mudah ke berbagai informasi, kebiasaan remaja dalam mencari informasi daring terkadang ditandai dengan kecepatan dan kurangnya evaluasi kritis terhadap sumber informasi (Metzger, M. J., & Flanagin, 2015). Remaja mungkin lebih mengandalkan rekomendasi dari teman sebaya, *influencer*, atau hasil pencarian teratas tanpa memverifikasi keakuratan dan kredibilitas sumbernya.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam kampanye kesehatan reproduksi, di mana informasi yang salah atau menyesatkan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perilaku remaja.

Oleh karena itu, kampanye kesehatan reproduksi digital perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebiasaan pencarian informasi remaja. Informasi yang disajikan harus mudah ditemukan, ringkas, dan didukung oleh sumber yang kredibel dan terpercaya. Penggunaan *badge* verifikasi atau tautan ke sumber informasi yang terpercaya dapat membantu membangun kepercayaan. Selain itu, kampanye juga perlu mengedukasi remaja tentang pentingnya literasi digital dan keterampilan untuk mengevaluasi informasi kesehatan secara kritis. Kolaborasi dengan *influencer* atau tokoh masyarakat yang kredibel dan memiliki pemahaman yang baik tentang isu kesehatan reproduksi juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan yang akurat dan terpercaya kepada remaja.

d. Pengaruh Teman Sebaya dan Budaya Digital

Lingkungan sosial dan budaya digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi dan perilaku remaja di dunia maya. Mereka cenderung mengikuti tren yang populer di kalangan teman sebaya, berpartisipasi dalam tantangan daring, dan mengadopsi bahasa dan gaya komunikasi yang umum di platform yang mereka gunakan (Subrahmanyam, K., & Greenfield, 2008). Kampanye kesehatan reproduksi yang efektif perlu memahami dan memanfaatkan dinamika sosial dan budaya digital.

Mengintegrasikan elemen-elemen budaya populer, seperti musik, *meme*, atau tren terkini, ke dalam konten kampanye dapat meningkatkan daya tarik dan *relevansi* bagi remaja. Mendorong partisipasi dan interaksi sosial melalui fitur-fitur seperti tantangan (*challenges*) atau kolaborasi dengan teman sebaya dapat memperkuat pesan kampanye dan menciptakan efek *peer influence* yang positif. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan elemen budaya ini dilakukan dengan sensitif dan tidak merendahkan atau menyinggung kelompok tertentu.

e. Waktu dan Konteks Penggunaan Platform yang Berbeda

Remaja cenderung menggunakan platform digital yang berbeda untuk tujuan yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Misalnya, Instagram dan TikTok mungkin lebih banyak digunakan untuk hiburan dan ekspresi diri, sementara YouTube mungkin menjadi sumber informasi atau tutorial. Aplikasi pesan instan digunakan untuk komunikasi sehari-hari dengan teman, dan platform seperti Twitter mungkin digunakan untuk mengikuti berita atau berpartisipasi dalam diskusi public (O’Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, 2011).

Pemahaman tentang pola penggunaan platform yang berbeda ini penting untuk merancang strategi kampanye yang tepat sasaran. Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mungkin lebih efektif dilakukan melalui platform dengan jangkauan luas dan format visual yang menarik, seperti Instagram dan TikTok. Sementara itu, kampanye yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam atau menjawab pertanyaan mungkin lebih cocok dilakukan melalui platform seperti YouTube atau forum daring. Mempertimbangkan waktu-waktu puncak penggunaan platform oleh remaja juga dapat membantu mengoptimalkan visibilitas dan keterlibatan kampanye.

Preferensi dan kebiasaan remaja dalam menggunakan media digital sangat beragam dan dinamis. Dominasi platform visual, preferensi komunikasi yang cepat dan personal, kecenderungan mencari informasi dengan cepat, pengaruh teman sebaya dan budaya digital, serta pola penggunaan platform yang berbeda merupakan faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kampanye kesehatan reproduksi digital yang efektif. Dengan memahami lanskap digital remaja dan menyesuaikan strategi kampanye dengan preferensi dan kebiasaan mereka, para pengembang kampanye memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau, melibatkan, dan memberikan dampak positif pada pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi mereka.

3. Potensi Interaksi dan Keterlibatan Media Sosial

Salah satu keunggulan paling menonjol dari media digital khususnya platform media sosial dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi remaja adalah potensi interaksi dan keterlibatan yang ditawarkannya. Berbeda dengan model komunikasi satu arah pada media tradisional, media sosial memungkinkan adanya dialog, umpan balik, partisipasi aktif, dan pembentukan komunitas di antara pengguna (Kaplan, A. M., & Haenlein, 2010). Fitur-fitur interaktif yang melekat pada platform-platform ini membuka peluang yang signifikan bagi kampanye kesehatan reproduksi untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendorong remaja untuk terlibat secara aktif, berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan belajar dari satu sama lain.

a. Memanfaatkan Fitur Komentar dan Diskusi

Hampir semua platform media sosial menyediakan fitur komentar yang memungkinkan pengguna untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, atau berbagi pendapat terkait konten yang dipublikasikan. Dalam kampanye kesehatan reproduksi, fitur ini dapat dimanfaatkan untuk

memfasilitasi diskusi terbuka tentang topik-topik sensitif, menjawab pertanyaan remaja secara langsung oleh ahli kesehatan, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Moderasi yang efektif diperlukan untuk memastikan diskusi tetap konstruktif, bebas dari ujaran kebencian atau misinformasi, dan menciptakan ruang yang aman bagi remaja untuk berbagi (Naslund et al., 2016).

Sebagai contoh, sebuah postingan kampanye yang membahas tentang kontrasepsi dapat memicu diskusi di bagian komentar, di mana remaja dapat saling berbagi pengalaman, bertanya tentang metode yang berbeda, atau mengklarifikasi mitos yang mungkin mereka dengar. Kehadiran ahli kesehatan atau fasilitator yang terlatih dalam diskusi daring dapat memberikan jawaban yang akurat dan membimbing percakapan ke arah yang positif. Fitur komentar juga memungkinkan pengembang kampanye untuk mendapatkan umpan balik langsung dari audiens, mengidentifikasi area yang perlu klarifikasi lebih lanjut, dan menyesuaikan konten kampanye di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan minat remaja.

b. Mendorong Partisipasi Melalui Polling dan Kuis

Fitur *polling* dan kuis yang tersedia di banyak platform media sosial menawarkan cara yang menarik dan interaktif untuk melibatkan remaja dalam topik kesehatan reproduksi. *Polling* dapat digunakan untuk mengumpulkan opini atau mengukur tingkat pengetahuan remaja tentang isu tertentu dengan cara yang cepat dan mudah. Kuis dapat menyajikan informasi dengan cara yang menyenangkan dan menguji pemahaman remaja secara interaktif. Hasil *polling* dan kuis juga dapat dibagikan untuk memicu diskusi lebih lanjut atau untuk mengoreksi miskonsepsi yang umum (Pluye et al., 2018).

Misalnya, sebuah kampanye tentang pencegahan IMS dapat menggunakan *polling* untuk menanyakan pengetahuan remaja tentang cara penularan IMS atau menggunakan kuis interaktif untuk menguji pemahaman mereka tentang gejala dan konsekuensi IMS. Hasil *polling* dapat ditampilkan secara anonim untuk memicu refleksi dan diskusi di antara peserta, sementara hasil kuis dapat memberikan umpan balik langsung dan mengarahkan remaja ke sumber informasi yang lebih detail jika diperlukan. Format interaktif ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan tetapi juga membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih berkesan.

c. Memanfaatkan Fitur Berbagi dan Menyebarkan Informasi

Salah satu kekuatan media sosial adalah kemampuannya untuk memfasilitasi penyebaran informasi secara horizontal melalui fitur berbagi (*share*, *repost*, *retweet*). Ketika remaja menemukan konten kampanye kesehatan

reproduksi yang menarik, relevan, atau bermanfaat, mereka cenderung untuk membagikannya dengan teman-teman dan jaringan sosial mereka. Hal ini dapat memperluas jangkauan kampanye secara eksponensial dan menciptakan efek *word-of-mouth* digital yang kuat (Valente, 2012).

Kampanye yang mendorong remaja untuk berbagi konten dengan teman-teman mereka, misalnya melalui tantangan kreatif atau kontes yang berhadiah, dapat memanfaatkan kekuatan jaringan sosial mereka untuk menyebarkan pesan-pesan kesehatan reproduksi secara lebih luas. Namun, penting untuk memastikan bahwa konten yang dibagikan akurat, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan stigma atau rasa malu. Mendorong remaja untuk berbagi pengalaman positif atau cerita sukses (dengan tetap menjaga privasi) juga dapat menjadi cara yang efektif untuk membangun dukungan sosial dan menormalisasi diskusi tentang kesehatan reproduksi.

d. Membangun Komunitas Daring yang Mendukung

Media sosial juga memfasilitasi pembentukan komunitas daring berdasarkan minat atau identitas yang sama. Kampanye kesehatan reproduksi dapat memanfaatkan fitur grup atau forum yang tersedia di berbagai platform untuk menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi remaja untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan secara anonim (jika diperlukan), dan mendapatkan dukungan dari teman sebaya dan ahli (L'Engle et al., 2016).

Komunitas daring yang dimoderasi dengan baik dapat menjadi sumber dukungan emosional dan informasi yang berharga bagi remaja yang mungkin merasa malu atau tidak nyaman untuk membahas isu-isu kesehatan reproduksi dengan orang tua, guru, atau teman di kehidupan nyata. Kehadiran ahli kesehatan atau fasilitator yang terlatih dalam komunitas ini dapat memberikan bimbingan yang akurat dan mengatasi miskonsepsi. Selain itu, interaksi antar remaja dalam komunitas yang sama dapat membangun rasa solidaritas dan mengurangi perasaan terisolasi terkait isu-isu kesehatan reproduksi yang mungkin mereka hadapi.

e. Mengintegrasikan Fitur Live dan Sesi Tanya Jawab Langsung

Fitur *live streaming* yang tersedia di banyak platform media sosial menawarkan kesempatan untuk mengadakan sesi tanya jawab langsung (*live Q&A*) dengan ahli kesehatan reproduksi. Sesi ini memungkinkan remaja untuk mengajukan pertanyaan secara *real-time* dan mendapatkan jawaban langsung dari sumber yang terpercaya. Format interaktif ini dapat meningkatkan keterlibatan, membangun kepercayaan, dan mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin ada dalam interaksi tatap muka (Lupton, 2013).

Promosi sesi *live Q&A* yang efektif, dengan mengumumkan topik dan narasumber sebelumnya, dapat menarik partisipasi yang besar dari remaja. Sesi ini dapat direkam dan dibagikan kembali bagi mereka yang tidak dapat hadir secara langsung. Selain itu, fitur komentar selama sesi *live* memungkinkan interaksi yang lebih dinamis dan responsif terhadap pertanyaan dan umpan balik dari audiens.

f. Memanfaatkan Fitur Kolaborasi dan Konten Buatan Pengguna (*User-Generated Content*)

Media sosial juga memfasilitasi kolaborasi antara pengembang kampanye, *influencer*, organisasi lain, dan bahkan remaja itu sendiri. Kolaborasi dapat menghasilkan konten yang lebih kreatif, relevan, dan menarik bagi audiens remaja. Selain itu, mendorong remaja untuk membuat dan berbagi konten mereka sendiri (*user-generated content*) yang berkaitan dengan topik kesehatan reproduksi dapat meningkatkan keterlibatan, membangun rasa kepemilikan terhadap kampanye, dan menyebarkan pesan secara lebih baik (Jenkins et al., 2013).

Misalnya, kampanye dapat mengadakan kontes untuk remaja membuat video pendek, *meme*, atau cerita tentang kesehatan reproduksi, dengan hadiah menarik bagi pemenang. Konten buatan pengguna ini tidak hanya meningkatkan partisipasi tetapi juga mencerminkan perspektif dan pengalaman remaja sendiri, sehingga membuatnya lebih *relatable* dan berdampak bagi audiens sebaya mereka.

Potensi interaksi dan keterlibatan yang ditawarkan oleh fitur-fitur media sosial merupakan aset yang sangat berharga dalam kampanye kesehatan reproduksi remaja. Fitur komentar, *polling*, kuis, berbagi, grup daring, sesi *live*, dan kolaborasi membuka berbagai peluang untuk menciptakan komunikasi dua arah, mendorong partisipasi aktif, membangun komunitas yang mendukung, dan menyebarkan informasi secara lebih luas dan efektif. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini secara strategis dan kreatif, pengembang kampanye dapat membangun jembatan partisipasi dengan remaja, menjadikan mereka sebagai agen aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik kesehatan reproduksi mereka sendiri.

4. Anonimitas dan Ruang Aman

Salah satu aspek krusial yang menjadikan platform *online* sangat efektif dalam kampanye kesehatan reproduksi remaja adalah potensi anonimitas dan kemampuannya untuk menciptakan ruang aman. Topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seringkali dianggap sensitif, tabu, atau memicu

rasa malu dan canggung di kalangan remaja. Norma sosial budaya, ketakutan akan stigma dan diskriminasi, serta kurangnya kepercayaan pada orang dewasa atau lingkungan sekitar dapat menghalangi remaja untuk mencari informasi atau mendiskusikan masalah kesehatan reproduksi mereka secara terbuka. Dalam konteks ini, platform *online* dapat menawarkan alternatif yang lebih nyaman dan aman, di mana remaja dapat mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka atau takut dihakimi.

a. Mengurangi Hambatan Psikologis Melalui Anonimitas

Fitur anonimitas yang ditawarkan oleh banyak platform *online*, seperti forum diskusi, beberapa aplikasi pesan, atau bahkan opsi untuk menggunakan nama samaran di media sosial, dapat secara signifikan mengurangi hambatan psikologis yang seringkali menghalangi remaja untuk terlibat dalam diskusi tentang topik sensitif. Ketika remaja merasa tidak perlu mengungkapkan identitas asli mereka, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk mengajukan pertanyaan yang memalukan, berbagi pengalaman pribadi yang sulit, atau mencari informasi tentang isu-isu yang mungkin mereka sembunyikan dari orang lain.

Sebagai contoh, seorang remaja yang merasa khawatir tentang perubahan tubuhnya atau memiliki pertanyaan tentang aktivitas seksual mungkin merasa lebih nyaman untuk bertanya di forum daring anonim daripada bertanya kepada orang tua atau guru. Demikian pula, remaja yang mengalami diskriminasi atau perundungan terkait orientasi seksual atau identitas gender mereka mungkin menemukan dukungan dan informasi yang relevan dalam komunitas daring anonim. Anonimitas dapat menciptakan rasa aman psikologis yang memungkinkan remaja untuk mengatasi rasa malu, takut, atau cemas yang mungkin mereka rasakan dalam interaksi tatap muka.

b. Menciptakan Ruang yang Bebas dari Penghakiman dan Stigma

Platform online yang dimoderasi dengan baik dapat menjadi ruang yang relatif bebas dari penghakiman dan stigma, yang seringkali melekat pada diskusi tentang kesehatan reproduksi di dunia nyata. Moderator dapat menetapkan aturan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima, menghapus komentar yang merendahkan atau diskriminatif, dan mempromosikan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung. Ketika remaja merasa bahwa mereka berada dalam ruang yang aman dan tidak akan dihakimi atas pertanyaan atau pengalaman mereka, mereka akan lebih mungkin untuk berpartisipasi secara aktif dan mencari informasi yang mereka butuhkan.

Kampanye kesehatan reproduksi online dapat secara aktif membangun ruang aman dengan menekankan pesan-pesan inklusivitas, penerimaan, dan non-diskriminasi. Penggunaan bahasa yang sensitif, menghindari stereotip, dan menampilkan keberagaman dalam representasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi semua remaja, terlepas dari latar belakang, identitas, atau pengalaman mereka. Selain itu, menyediakan sumber daya dan informasi tentang layanan dukungan yang tersedia juga dapat memberdayakan remaja untuk mencari bantuan lebih lanjut jika mereka membutuhkannya.

c. Menjangkau Remaja yang Sulit Dijangkau Melalui Komunikasi Tradisional

Potensi anonimitas dan ruang aman online sangat penting dalam menjangkau remaja yang mungkin sulit dijangkau melalui komunikasi tradisional. Remaja yang berasal dari komunitas konservatif di mana diskusi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dianggap tabu, remaja yang mengalami kekerasan atau pelecehan, atau remaja yang merasa terisolasi karena identitas atau orientasi seksual mereka mungkin merasa lebih aman dan nyaman untuk mencari informasi dan dukungan secara daring (Subramaniam et al., 2019).

Platform online dapat menjadi jalur alternatif untuk menyampaikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada kelompok remaja ini tanpa harus melalui perantara yang mungkin tidak mereka percayai atau merasa nyaman dengannya. Kampanye yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sensitivitas kelompok-kelompok ini, serta memanfaatkan fitur anonimitas dan moderasi yang efektif, dapat memberikan akses yang sangat dibutuhkan terhadap informasi dan dukungan kesehatan reproduksi.

d. Membangun Kepercayaan dan Keterbukaan Melalui Interaksi yang Terkontrol

Meskipun anonimitas dapat menjadi daya tarik utama, penting juga untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan dalam interaksi online. Kampanye kesehatan reproduksi dapat mencapai hal ini dengan menyediakan informasi yang akurat dan berbasis bukti dari sumber yang kredibel, serta memastikan bahwa interaksi dengan ahli kesehatan atau fasilitator dilakukan dengan cara yang profesional, empatik, dan menghormati privasi remaja (Finn, J., & Barak, 2010).

Moderator atau administrator platform online dapat memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dengan bersikap responsif terhadap pertanyaan dan umpan balik, menegakkan aturan komunitas secara konsisten, dan memastikan bahwa informasi yang dibagikan akurat dan tidak menyesatkan. Ketika remaja merasa bahwa mereka berinteraksi dengan orang-

orang yang dapat dipercaya dan bahwa privasi mereka dilindungi, mereka akan lebih mungkin untuk terbuka dan terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam tentang topik-topik sensitif.

e. Mengintegrasikan Fitur Keamanan dan Privasi

Untuk memaksimalkan potensi anonimitas dan ruang aman online, kampanye kesehatan reproduksi perlu mengintegrasikan fitur keamanan dan privasi yang kuat. Ini termasuk penggunaan enkripsi untuk melindungi data pribadi, kebijakan privasi yang transparan dan mudah dipahami, serta opsi bagi pengguna untuk mengontrol informasi apa yang mereka bagikan dan dengan siapa mereka berbagi (Boyd, D. M., & Ellison, 2007).

Penting untuk mengedukasi remaja tentang pentingnya menjaga privasi mereka secara online dan memberikan panduan tentang cara menggunakan fitur keamanan yang tersedia di berbagai platform. Kampanye juga harus mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku terkait perlindungan data anak dan remaja di dunia maya. Dengan memprioritaskan keamanan dan privasi, kampanye dapat membangun kepercayaan dan mendorong remaja untuk merasa lebih nyaman dalam berinteraksi dan mencari informasi tentang kesehatan reproduksi secara daring.

Potensi anonimitas dan ruang aman yang ditawarkan oleh platform online merupakan keunggulan yang sangat signifikan dalam kampanye kesehatan reproduksi remaja. Fitur-fitur ini dapat mengurangi hambatan psikologis, menciptakan lingkungan yang bebas dari penghakiman dan stigma, menjangkau remaja yang sulit dijangkau melalui komunikasi tradisional, membangun kepercayaan dan keterbukaan melalui interaksi yang terkontrol, serta memastikan keamanan dan privasi pengguna. Dengan memanfaatkan potensi ini secara etis dan bertanggung jawab, kampanye kesehatan reproduksi online dapat menjadi alat yang ampuh untuk memberdayakan remaja dengan pengetahuan, dukungan, dan rasa aman dalam membahas topik-topik sensitif yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

5. Diseminasi Informasi Cepat dan Real-time

Salah satu keunggulan krusial yang menjadikan media digital sebagai alat yang sangat efektif untuk kampanye kesehatan reproduksi remaja adalah kemampuannya dalam diseminasi informasi yang cepat dan *real-time*. Berbeda dengan metode penyampaian informasi tradisional yang seringkali memerlukan waktu yang signifikan untuk produksi, distribusi, dan konsumsi, platform digital memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan simultan kepada khalayak yang luas (Van Deursen et al., 2015).

a. Mengatasi Batasan Waktu dan Ruang dalam Penyebaran Informasi

Metode tradisional seperti brosur, poster, atau seminar memerlukan waktu untuk produksi, distribusi fisik, dan penjadwalan acara. Proses ini seringkali memakan waktu dan memiliki keterbatasan geografis dalam menjangkau audiens. Media digital menghilangkan sebagian besar batasan ini. Informasi dalam bentuk teks, gambar, video, atau tautan dapat dibuat dan disebarkan secara instan melalui platform media sosial, situs web, aplikasi pesan, atau email kepada ribuan bahkan jutaan remaja dalam hitungan detik.

Sebagai contoh, jika terjadi wabah penyakit menular seksual (IMS) baru atau muncul informasi penting terkait kontrasepsi, kampanye kesehatan reproduksi digital dapat dengan cepat menyebarkan peringatan, panduan pencegahan, atau informasi terbaru kepada remaja melalui berbagai saluran *online*. Kecepatan diseminasi ini sangat penting dalam meminimalkan risiko dan memberikan respons yang tepat waktu terhadap isu-isu kesehatan yang berkembang. Kemampuan untuk menjangkau remaja secara *real-time*, di mana pun mereka berada dan kapan pun mereka membutuhkan informasi, merupakan keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan metode tradisional.

b. Memungkinkan Penyampaian Informasi yang Relevan dan Kontekstual

Media digital juga memungkinkan penyampaian informasi kesehatan reproduksi yang lebih relevan dan kontekstual bagi remaja. Kampanye dapat memanfaatkan data demografis, minat, dan perilaku *online* (dengan tetap memperhatikan privasi) untuk menargetkan pesan-pesan tertentu kepada kelompok remaja yang paling membutuhkan informasi tersebut. Selain itu, informasi dapat disajikan dalam konteks peristiwa terkini atau tren yang sedang populer di kalangan remaja, sehingga membuatnya lebih menarik dan *relatable*. Sebagai contoh, jika ada tren viral di media sosial yang berkaitan dengan kesehatan seksual (meskipun mungkin tidak akurat), kampanye kesehatan reproduksi dapat dengan cepat merespons dengan konten yang meluruskan informasi yang salah dan memberikan fakta yang benar dalam format yang serupa dan menarik. Kemampuan untuk merespons secara cepat terhadap isu-isu yang relevan dengan kehidupan remaja dan menyajikan informasi dalam konteks yang mereka pahami dapat meningkatkan efektivitas kampanye secara signifikan.

c. Memfasilitasi Pembaruan Informasi yang Cepat dan Mudah

Informasi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, terus berkembang seiring dengan adanya penelitian dan penemuan baru. Media digital memungkinkan kampanye untuk memperbarui informasi dengan cepat dan

mudah tanpa perlu mencetak ulang materi atau menjadwalkan ulang acara. Koreksi terhadap informasi yang salah, penambahan informasi terbaru, atau perubahan dalam rekomendasi dapat disebarkan secara instan kepada remaja (Haynes et al., 2006).

Kemudahan pembaruan ini sangat penting dalam memastikan bahwa remaja menerima informasi yang akurat dan terkini. Tautan ke sumber informasi yang lebih detail atau tepercaya juga dapat dengan mudah disertakan dalam konten digital, memungkinkan remaja untuk mengakses informasi lebih lanjut jika mereka membutuhkannya. Fleksibilitas media digital dalam memperbarui dan menyampaikan informasi terkini memastikan bahwa kampanye kesehatan reproduksi tetap relevan dan kredibel.

d. Mendukung Respons Cepat Terhadap Krisis atau Situasi Darurat

Dalam situasi krisis kesehatan reproduksi atau darurat, seperti wabah penyakit menular seksual yang meningkat pesat atau adanya informasi yang salah dan berbahaya yang menyebar secara *online*, media digital memungkinkan respons yang cepat dan terkoordinasi. Kampanye dapat dengan segera menyebarkan informasi tentang risiko, tindakan pencegahan, atau sumber bantuan yang tersedia kepada remaja melalui berbagai saluran *online* (Lyles et al., 2013).

Kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu selama krisis dapat membantu mengurangi kepanikan, mencegah penyebaran informasi yang salah, dan mengarahkan remaja ke layanan yang tepat. Media sosial juga dapat digunakan untuk memantau percakapan *online* dan mengidentifikasi area di mana informasi yang salah atau berbahaya sedang menyebar, sehingga memungkinkan respons yang lebih terarah dan efektif.

e. Memanfaatkan Fitur Notifikasi dan Pemberitahuan *Real-time*.

Banyak platform digital, terutama aplikasi seluler dan beberapa platform media sosial, menawarkan fitur notifikasi dan pemberitahuan *real-time*. Kampanye kesehatan reproduksi dapat memanfaatkan fitur ini untuk menyampaikan informasi penting atau pengingat kepada remaja secara langsung ke perangkat mereka. Pemberitahuan tentang acara *online* yang akan datang, informasi terbaru tentang topik tertentu, atau pengingat untuk mengakses sumber daya kesehatan reproduksi dapat disampaikan dengan cepat dan efisien (Free et al., 2013).

Namun, penting untuk menggunakan fitur notifikasi dengan bijak dan tidak berlebihan agar tidak dianggap sebagai *spam* atau mengganggu. Personalisasi pemberitahuan berdasarkan minat atau kebutuhan remaja dapat meningkatkan relevansi dan efektivitasnya.

C. Strategi Merancang Kampanye Kesehatan Reproduksi Digital yang Efektif

1. Penentuan Tujuan yang Spesifik dan Terukur

Langkah fundamental dalam merancang kampanye kesehatan reproduksi digital yang efektif adalah penentuan tujuan yang spesifik dan terukur. Tanpa tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terdefinisi dengan baik, upaya kampanye berisiko menjadi tidak fokus, sulit dievaluasi, dan kurang berdampak (McKenzie, J. F., & Neiger, 2013). Tujuan yang spesifik memberikan arah yang jelas bagi semua aspek kampanye, mulai dari pemilihan target audiens, pengembangan konten, pemilihan platform, hingga strategi evaluasi. Sementara itu, tujuan yang terukur memungkinkan para pengembang kampanye untuk memantau kemajuan, menilai efektivitas, dan membuat penyesuaian yang diperlukan sepanjang siklus kampanye.

Tujuan kampanye kesehatan reproduksi digital untuk remaja dapat bervariasi tergantung pada masalah kesehatan spesifik yang ingin diatasi, karakteristik target audiens, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa contoh tujuan kampanye digital yang umum, dikategorikan berdasarkan fokusnya:

a. Meningkatkan Kesadaran (*Awareness*)

Tujuan yang berfokus pada peningkatan kesadaran bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang isu-isu kesehatan reproduksi tertentu. Ini adalah langkah awal yang penting, terutama ketika menangani topik yang kurang dipahami atau diselubungi mitos dan misinformasi. Contoh Tujuan Spesifik: Meningkatkan kesadaran di kalangan remaja usia 15-19 tahun di wilayah Jakarta tentang risiko penularan HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom sebesar 20% dalam waktu 6 bulan setelah peluncuran kampanye. Contoh Tujuan Terukur: Meningkatkan jumlah remaja usia 15-19 tahun di Wilayah Pontianak yang dapat menyebutkan minimal tiga cara penularan HIV dari 40% menjadi 60% berdasarkan survei daring yang dilakukan sebelum dan setelah kampanye.

b. Mengubah Sikap (*Attitude Change*)

Tujuan yang berfokus pada perubahan sikap bertujuan untuk mempengaruhi keyakinan, nilai, dan perasaan remaja terhadap isu-isu kesehatan reproduksi. Perubahan sikap seringkali menjadi prasyarat untuk perubahan perilaku jangka panjang. Contoh Tujuan Spesifik: Mengurangi stigma negatif di kalangan remaja usia 16-18 tahun terhadap penggunaan kontrasepsi di media sosial sebesar 15% dalam waktu 4 bulan kampanye. Contoh Tujuan Terukur: Mengurangi persentase remaja usia 16-18 tahun yang

setuju dengan pernyataan negatif tentang pengguna kontrasepsi dari 50% menjadi 35% berdasarkan analisis sentiment komentar media sosial dan survei daring.

c. Mendorong Perilaku Positif (*Behavior Change*)

Tujuan yang berfokus pada perubahan perilaku bertujuan untuk mendorong remaja untuk mengadopsi atau meningkatkan perilaku yang sehat terkait kesehatan reproduksi. Tujuan ini seringkali merupakan hasil akhir yang diinginkan dari kampanye. Contoh Tujuan Spesifik: Meningkatkan jumlah remaja putri usia 15-19 tahun yang mengakses layanan konseling kesehatan reproduksi di klinik Z sebesar 30% dalam 6 bulan kampanye daring. Contoh Tujuan Terukur: Meningkatkan jumlah kunjungan remaja putri usia 15-19 tahun ke klinik Z untuk layanan konseling kesehatan reproduksi dari rata-rata 20 kunjungan per bulan menjadi 26 kunjungan per bulan setelah kampanye.

Setelah tujuan kampanye ditetapkan, langkah selanjutnya yang sama pentingnya adalah mengidentifikasi indikator keberhasilan yang jelas. Indikator keberhasilan adalah ukuran spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) yang digunakan untuk menilai apakah tujuan kampanye telah tercapai. Indikator yang jelas memungkinkan para pengembang kampanye untuk:

1) Memantau Kemajuan

Indikator yang terukur memungkinkan pelacakan kemajuan kampanye secara berkala. Data yang dikumpulkan berdasarkan indikator ini memberikan informasi tentang apakah kampanye berjalan sesuai rencana dan apakah ada area yang memerlukan perhatian atau penyesuaian.

2) Mengevaluasi Efektivitas

Di akhir kampanye, indikator keberhasilan menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Data yang dikumpulkan sebelum dan sesudah kampanye (*baseline* dan *follow-up* data) dibandingkan untuk mengukur perubahan yang terjadi sebagai hasil dari intervensi digital.

3) Mempertanggungjawabkan Hasil

Indikator yang jelas memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dampak kampanye dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dialokasikan. Laporan evaluasi yang didasarkan pada indikator yang terukur memberikan bukti tentang efektivitas kampanye.

4) Mengidentifikasi Pembelajaran

Analisis data indikator keberhasilan tidak hanya menunjukkan apakah tujuan tercapai, tetapi juga memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang kurang berhasil dalam strategi kampanye. Pembelajaran ini dapat digunakan untuk meningkatkan kampanye di masa depan.

5) Membandingkan dengan Kampanye Lain

Indikator yang standar dan terukur memungkinkan perbandingan efektivitas antara kampanye yang berbeda atau intervensi yang berbeda dalam kampanye yang sama. Ini membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan mengoptimalkan strategi di masa depan.

Penentuan tujuan yang spesifik dan terukur merupakan fondasi yang kokoh bagi keberhasilan kampanye kesehatan reproduksi digital untuk remaja. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus, sementara indikator keberhasilan yang terukur memungkinkan pemantauan kemajuan, evaluasi efektivitas, dan akuntabilitas hasil. Dengan menginvestasikan waktu dan upaya yang cukup dalam menetapkan tujuan dan indikator yang SMART, para pengembang kampanye dapat meningkatkan peluang untuk mencapai dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mendorong perilaku positif remaja terkait kesehatan reproduksi mereka. Langkah ini juga memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Identifikasi dan Segmentasi Target Audiens Digital

Setelah menetapkan tujuan kampanye yang spesifik dan terukur, langkah krusial berikutnya adalah identifikasi dan segmentasi target audiens digital. Remaja bukanlah kelompok yang homogen, mereka memiliki beragam usia, latar belakang sosial ekonomi, tingkat pendidikan, minat, nilai, perilaku, dan tentu saja, preferensi dalam penggunaan media digital. Kampanye kesehatan reproduksi yang efektif harus mengakui keragaman ini dan menyesuaikan pesan serta strategi penyampaiannya agar relevan dan menarik bagi segmen audiens yang berbeda (Kreuter, M. W., & McClure, S. M. (2004). Identifikasi yang cermat dan segmentasi yang tepat memungkinkan para pengembang kampanye untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan mencapai remaja yang paling membutuhkannya dan disampaikan dengan cara yang paling mungkin untuk diterima dan direspon.

a. Memahami demografi, psikografi, dan preferensi media sosial berbagai kelompok remaja

Ketika melakukan segmentasi audiens yang efektif, para pengembang kampanye perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan

tentang berbagai kelompok remaja. Informasi ini dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama: demografi, psikografi, dan preferensi media sosial.

1) Demografi

Demografi mencakup karakteristik sosio-ekonomi dan geografis populasi remaja. Informasi demografis penting untuk memahami konteks kehidupan remaja dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang mungkin memiliki kebutuhan kesehatan reproduksi yang berbeda atau menghadapi tantangan yang unik. Beberapa variabel demografi yang relevan untuk segmentasi audiens remaja meliputi:

a) Usia

Rentang usia remaja yang luas (misalnya, 10-19 tahun menurut WHO mencakup tahap perkembangan yang berbeda dengan kebutuhan informasi dan preferensi komunikasi yang berbeda pula. Kampanye untuk remaja awal (10-13 tahun) akan berbeda secara signifikan dengan kampanye untuk remaja akhir (17-19 tahun).

b) Jenis Kelamin dan Identitas Gender

Pengalaman dan kebutuhan kesehatan reproduksi dapat berbeda antara laki-laki, perempuan, dan individu dengan identitas gender yang beragam. Pesan kampanye harus inklusif dan sensitif terhadap perbedaan ini (Coleman et al., 2012).

c) Lokasi Geografis

Remaja yang tinggal di perkotaan mungkin memiliki akses yang berbeda terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Selain itu, norma sosial dan budaya yang berlaku di wilayah geografis tertentu dapat mempengaruhi penerimaan pesan kampanye.

d) Status Sosial Ekonomi

Tingkat pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat mempengaruhi akses remaja terhadap teknologi, informasi, dan layanan kesehatan. Kampanye perlu mempertimbangkan kesenjangan digital dan menyediakan alternatif jika diperlukan (Van Deursen, A. J. A. M., & Van Dijk, 2014).

e) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan remaja dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang informasi kesehatan yang kompleks dan kemampuan mereka untuk mencari dan mengevaluasi informasi secara kritis. Pesan kampanye perlu disesuaikan dengan tingkat literasi audiens.

2) Psikografi

Psikografi berkaitan dengan karakteristik psikologis dan gaya hidup remaja, termasuk nilai, sikap, minat, opini, kepribadian, dan perilaku mereka. Memahami psikografi membantu dalam menciptakan pesan kampanye yang lebih resonan dan relevan secara emosional dengan audiens. Beberapa variabel psikografi yang relevan meliputi:

a) Minat dan Hobi

Mengetahui minat remaja (misalnya, musik, olahraga, *gaming*, seni) dapat membantu dalam mengintegrasikan pesan kampanye ke dalam konteks yang mereka sukai dan perhatikan (Potter, 2003).

b) Nilai dan Keyakinan

Nilai-nilai budaya, agama, dan pribadi remaja dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap isu-isu kesehatan reproduksi. Pesan kampanye perlu disampaikan dengan sensitif terhadap nilai-nilai ini.

c) Sikap terhadap Kesehatan Reproduksi

Remaja mungkin memiliki sikap yang berbeda terhadap topik-topik seperti seksualitas, kontrasepsi, atau IMS berdasarkan pengalaman pribadi, pengaruh teman sebaya, atau informasi yang mereka terima sebelumnya. Kampanye perlu mengatasi sikap negatif atau miskonsepsi.

d) Gaya Hidup

Kebiasaan sehari-hari remaja, seperti pola penggunaan media, aktivitas sosial, dan keterlibatan dalam perilaku berisiko, dapat mempengaruhi cara terbaik untuk menjangkau mereka dan pesan yang paling relevan.

e) Kepribadian

Karakteristik kepribadian seperti tingkat keingintahuan, keterbukaan terhadap pengalaman baru, atau tingkat kepercayaan pada otoritas dapat mempengaruhi bagaimana remaja merespons pesan kampanye (McCrae, R. R., & Costa Jr, 2003).

3) Preferensi Media Sosial

Memahami preferensi remaja dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk memilih platform yang tepat dan menyesuaikan format serta gaya konten kampanye. Beberapa aspek preferensi media sosial yang perlu dipertimbangkan meliputi:

a) Platform yang Paling Sering Digunakan

Remaja dari kelompok usia yang berbeda atau dengan minat yang berbeda mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di platform yang berbeda (misalnya, TikTok untuk remaja awal dan menengah, Instagram

untuk remaja menengah dan akhir, YouTube untuk berbagai usia dengan minat spesifik) (Anderson, M., & Jiang, 2018).

b) Jenis Konten yang Disukai

Preferensi terhadap jenis konten (misalnya, video pendek, gambar, *meme*, *stories*, *live streams*) dapat bervariasi antar kelompok remaja. Kampanye perlu menghasilkan konten dalam format yang paling menarik bagi target audiens (Sundar, S. S., & Kalyanaraman, 2004).

c) Gaya Bahasa dan Komunikasi

Remaja sering menggunakan bahasa informal, singkatan, *slang*, dan *meme* dalam komunikasi *online*. Kampanye yang ingin terhubung dengan mereka perlu mengadopsi gaya bahasa yang *relatable* (Crystal, 2001).

d) Influencer dan Tokoh Panutan

Remaja seringkali dipengaruhi oleh *influencer* dan tokoh panutan di media sosial. Mengidentifikasi *influencer* yang relevan dan kredibel di kalangan target audiens dapat menjadi strategi yang efektif (Brown, J., & De Matviuk, 2020).

e) Pola Interaksi

Memahami bagaimana remaja berinteraksi di platform yang berbeda (misalnya, aktif berkomentar, hanya *lurking*, berpartisipasi dalam grup) dapat membantu dalam merancang strategi keterlibatan yang sesuai (Nonnecke, B., & Preece, 2000).

b. Personalisasi pesan untuk menjangkau segmen yang berbeda

Personalisasi berarti menyesuaikan konten, gaya bahasa, dan saluran penyampaian pesan agar lebih relevan dan menarik bagi setiap segmen audiens yang berbeda. Pesan yang dipersonalisasi cenderung lebih efektif karena terasa lebih langsung, relevan dengan pengalaman dan minat remaja, dan menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan unik mereka. Beberapa strategi untuk personalisasi pesan dalam kampanye kesehatan reproduksi digital meliputi:

1) Penggunaan Bahasa yang Sesuai Usia dan Kelompok

Menggunakan bahasa dan contoh yang relevan dengan pengalaman dan pemahaman kelompok usia yang berbeda. Misalnya, kampanye untuk remaja awal mungkin fokus pada perubahan pubertas dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, sementara kampanye untuk remaja akhir dapat membahas topik yang lebih kompleks seperti kontrasepsi dan hubungan seksual yang aman dengan bahasa yang lebih dewasa.

2) Menyajikan Konten dalam Format yang Disukai

Membuat konten dalam format yang paling populer dan menarik bagi setiap segmen audiens. Misalnya, menggunakan video pendek dan *meme* untuk menjangkau remaja pengguna TikTok, atau infografis dan *stories* interaktif untuk pengguna Instagram.

3) Memilih Platform yang Tepat untuk Setiap Segmen

Menyampaikan pesan melalui platform media sosial yang paling sering digunakan oleh target audiens. Misalnya, fokus pada Snapchat dan Instagram untuk menjangkau remaja yang lebih muda, dan YouTube atau Facebook untuk menjangkau remaja yang lebih tua dengan minat yang lebih spesifik.

4) Menggunakan Referensi Budaya dan Tren yang Relevan

Mengintegrasikan referensi musik, film, *meme*, atau tren *online* yang populer di kalangan segmen audiens tertentu untuk membuat pesan lebih *relatable* dan menarik.

5) Menampilkan Representasi yang Beragam dan Inklusif

Memastikan bahwa visual dan narasi dalam kampanye mencerminkan keragaman remaja dalam hal ras, etnis, gender, orientasi seksual, kemampuan fisik, dan latar belakang sosial ekonomi. Ini membantu semua remaja merasa dilihat dan diakui.

6) Menyesuaikan Pesan dengan Minat dan Nilai

Mengaitkan pesan kesehatan reproduksi dengan minat dan nilai-nilai yang penting bagi segmen audiens tertentu. Misalnya, menekankan pentingnya kesehatan reproduksi untuk mencapai tujuan pendidikan atau karir bagi remaja yang berorientasi pada prestasi.

7) Menggunakan *Influencer* yang Relevan dengan Setiap Segmen

Berkolaborasi dengan *influencer* media sosial yang memiliki kredibilitas dan daya tarik di kalangan segmen audiens tertentu untuk menyampaikan pesan kampanye.

8) Menyediakan Opsi untuk Interaksi yang Dipersonalisasi

Memungkinkan remaja untuk mengajukan pertanyaan secara anonim atau mendapatkan informasi yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan mereka melalui fitur *chatbot* atau *direct message*.

Memahami demografi, psikografi, dan preferensi media sosial berbagai kelompok remaja memungkinkan para pengembang kampanye untuk membagi audiens menjadi segmen-segmen yang lebih homogen dengan kebutuhan dan preferensi yang serupa. Selanjutnya, personalisasi pesan untuk menjangkau setiap segmen dengan konten, gaya bahasa, dan

saluran yang paling relevan dan menarik akan meningkatkan kemungkinan pesan tersebut untuk diperhatikan, dipahami, diingat, dan ditindaklanjuti.

3. Pemilihan Platform Media Digital yang Tepat

Langkah strategis berikutnya adalah pemilihan platform media digital yang tepat. Lanskap media digital sangat luas dan dinamis, dengan berbagai platform yang menawarkan karakteristik pengguna, format konten yang dominan, dan budaya interaksi yang berbeda-beda. Memilih platform yang paling sesuai dengan target audiens, tujuan kampanye, dan jenis pesan yang ingin disampaikan adalah kunci untuk memaksimalkan jangkauan, keterlibatan, dan dampak kampanye kesehatan reproduksi remaja (Boyd, 2014). Pemilihan platform yang tepat bukan hanya tentang mengikuti tren popularitas, tetapi juga tentang pemahaman mendalam tentang bagaimana remaja menggunakan platform yang berbeda dan jenis konten apa yang paling mungkin menarik perhatian mereka.

a. Analisis mendalam tentang karakteristik pengguna dan format konten yang sesuai untuk platform populer

Memahami karakteristik pengguna dan format konten yang dominan di platform media sosial populer sangat penting dalam pengambilan keputusan pemilihan platform. Berikut adalah analisis mendalam tentang beberapa platform yang umum digunakan oleh remaja:

1) TikTok

TikTok sangat populer di kalangan remaja dan dewasa muda, terutama mereka yang berusia 13-24 tahun. Pengguna TikTok cenderung mencari hiburan, kreativitas, dan tren yang sedang viral. Platform ini didominasi oleh video pendek (biasanya 15-60 detik, namun bisa lebih panjang), seringkali diiringi musik, tarian, tantangan (*challenges*), dan format *lip-sync* (Zarei et al., 2021).

Kampanye kesehatan reproduksi di TikTok dapat memanfaatkan video pendek yang kreatif, menarik secara visual, dan mengikuti tren yang relevan. Pesan-pesan kunci dapat disampaikan melalui tarian, drama singkat, animasi, atau penjelasan ringkas dengan grafis yang menarik. Tantangan yang berkaitan dengan pengetahuan kesehatan reproduksi atau promosi perilaku sehat juga dapat efektif dalam mendorong partisipasi. Penggunaan *soundtrack* yang populer dan *hashtag* yang relevan sangat penting untuk meningkatkan visibilitas.

Meskipun jangkauannya luas di kalangan remaja, konten di TikTok bersifat cepat dan seringkali berorientasi pada hiburan. Pesan kesehatan perlu disampaikan dengan cara yang menarik dan tidak terasa menggurui.

Potensi untuk konten yang tidak akurat atau menyesatkan juga perlu diwaspadai.

2) Instagram

Instagram populer di kalangan remaja dan dewasa muda, dengan fokus pada konten visual seperti foto dan video. *Stories* (konten sementara yang hilang setelah 24 jam) dan *Reels* (video pendek seperti TikTok) juga sangat populer. Pengguna Instagram sering mencari konten yang menarik secara estetika, *lifestyle*, dan terhubung dengan teman dan *influencer* (Sheldon, P., & Bryant, 2016).

Kampanye kesehatan reproduksi di Instagram dapat memanfaatkan infografis yang menarik secara visual, foto yang informatif, video pendek yang menjelaskan konsep kunci, dan *stories* interaktif dengan *polling*, kuis, dan pertanyaan. *Reels* dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih dinamis dan menghibur. Kolaborasi dengan *influencer* yang memiliki citra positif dan relevan dengan kesehatan reproduksi dapat sangat efektif.

Meskipun visual menarik, pesan kesehatan perlu disampaikan dengan jelas dan ringkas. Peran *influencer* perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan kredibilitas dan kesesuaian dengan pesan kampanye.

3) YouTube

YouTube memiliki jangkauan yang sangat luas di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Pengguna YouTube mencari berbagai jenis konten, mulai dari tutorial, ulasan, *vlog*, hingga konten hiburan dan pendidikan yang lebih panjang. YouTube memungkinkan penyajian informasi yang lebih mendalam dan detail (Boyd, 2014).

Kampanye kesehatan reproduksi di YouTube dapat memanfaatkan video penjelasan yang lebih panjang, wawancara dengan ahli, animasi edukatif, testimoni (dengan izin dan pertimbangan etis), dan sesi tanya jawab (*webinar*). Konten dapat dioptimalkan dengan kata kunci yang relevan agar mudah ditemukan melalui pencarian. Penggunaan *thumbnail* yang menarik dan deskripsi video yang jelas juga penting.

Meskipun memungkinkan penyampaian informasi yang lebih mendalam, perhatian remaja mungkin sulit dipertahankan untuk video yang terlalu panjang. Konten perlu disajikan dengan cara yang menarik dan terstruktur.

4) Twitter (X)

Twitter (sekarang X) lebih populer di kalangan dewasa muda dan orang dewasa, meskipun beberapa remaja juga menggunakannya untuk

mengikuti berita, selebritas, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Batasan karakter pesan mendorong komunikasi yang ringkas dan cepat (Java et al., 2007).

Kampanye kesehatan reproduksi di Twitter dapat memanfaatkan *tweet* singkat yang informatif, tautan ke sumber informasi yang lebih detail, infografis ringkas, dan partisipasi dalam percakapan yang relevan menggunakan *hashtag*. Twitter juga efektif untuk menyebarkan informasi *real-time* dan merespons misinformasi dengan cepat.

Batasan karakter memerlukan pesan yang sangat ringkas dan jelas. Visual seringkali diperlukan untuk menarik perhatian. Tingkat keterlibatan remaja mungkin lebih rendah dibandingkan platform lain yang lebih visual.

5) Facebook

Facebook cenderung lebih populer di kalangan kelompok usia yang lebih tua dibandingkan remaja, meskipun masih banyak remaja yang memiliki akun. Pengguna Facebook sering terhubung dengan teman dan keluarga, mengikuti grup berdasarkan minat, dan berbagi berita dan informasi (Ellison et al., 2007).

Kampanye kesehatan reproduksi di Facebook dapat memanfaatkan berbagai format, termasuk teks, gambar, video, dan tautan. Grup Facebook dapat digunakan untuk membangun komunitas dan memfasilitasi diskusi. Kampanye juga dapat menargetkan iklan berdasarkan demografi dan minat.

Tingkat keterlibatan organik remaja mungkin lebih rendah dibandingkan platform lain. Efektivitas iklan berbayar perlu dipertimbangkan.

b. Pertimbangan platform yang kurang umum namun relevan

Selain platform populer, ada beberapa platform yang kurang umum namun mungkin sangat relevan untuk menjangkau segmen audiens tertentu atau untuk tujuan kampanye spesifik:

1) Forum Online

Forum *online* seringkali menarik pengguna dengan minat atau identitas yang spesifik. Forum spesifik mungkin berfokus pada dukungan untuk penyintas kekerasan seksual, atau diskusi tentang kesehatan mental (Boyd, 2014). Forum *online* dapat menjadi ruang yang aman dan anonim bagi remaja untuk mencari informasi mendalam, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan dari teman sebaya yang memiliki minat atau pengalaman serupa. Kampanye kesehatan reproduksi dapat berpartisipasi dalam forum yang relevan dengan menyediakan informasi yang akurat,

menjawab pertanyaan, dan mengarahkan pengguna ke sumber daya yang terpercaya.

2) Aplikasi Pesan

Aplikasi pesan adalah saluran komunikasi utama bagi banyak remaja untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga secara pribadi atau dalam grup kecil. Beberapa aplikasi menawarkan fitur keamanan dan privasi yang lebih tinggi (O'Hara et al., 2014). Kampanye kesehatan reproduksi dapat memanfaatkan aplikasi pesan untuk mengirimkan informasi ringkas, pengingat, atau tautan ke sumber daya yang lebih detail kepada remaja yang telah secara sukarela bergabung atau berinteraksi dengan kampanye melalui saluran lain. Grup diskusi yang dimoderasi juga dapat dibentuk untuk memberikan dukungan sebaya dan informasi yang akurat.

3) Platform Audio

Popularitas *podcast* terus meningkat di berbagai kelompok usia, termasuk remaja yang mencari informasi atau hiburan yang dapat didengarkan saat bepergian atau melakukan aktivitas lain. *Podcast* dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan reproduksi yang lebih mendalam dalam format percakapan yang menarik. Narasumber yang kredibel dan *tone* yang *relatable* dapat membuat konten audio menarik bagi remaja.

Pemilihan platform media digital yang tepat adalah keputusan strategis yang krusial dalam merancang kampanye kesehatan reproduksi remaja yang efektif. Strategi yang terintegrasi, yang memanfaatkan kekuatan unik dari berbagai platform untuk tujuan yang berbeda dan segmen audiens yang berbeda, seringkali menjadi pendekatan yang paling komprehensif dan berdampak.

4. Pengembangan Konten Digital yang Menarik dan Informatif

Keberhasilan kampanye kesehatan reproduksi digital sangat bergantung pada kemampuan untuk menciptakan konten yang tidak hanya informatif dan akurat tetapi juga menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh audiens remaja. Di tengah banjir informasi digital, konten yang efektif harus mampu menarik perhatian, mempertahankan minat, dan menyampaikan pesan kunci dengan cara yang resonan dengan dunia dan preferensi remaja.

a. Prinsip-prinsip desain visual dan komunikasi yang efektif untuk remaja

Agar dapat menjangkau dan melibatkan remaja, desain visual dan gaya komunikasi konten digital harus mempertimbangkan karakteristik

perkembangan, preferensi budaya, dan kebiasaan penggunaan media mereka (Lenhart et al., 2015). Beberapa prinsip penting meliputi:

1) Visual yang Menarik dan *Eye-Catching*

Remaja sangat responsif terhadap visual yang menarik, termasuk warna-warna cerah, ilustrasi yang dinamis, fotografi yang relevan, dan penggunaan ruang putih yang efektif. Desain yang bersih dan tidak berantakan membantu fokus pada pesan utama.

2) Bahasa yang Mudah Dipahami dan *Relatable*

Hindari jargon medis atau bahasa yang terlalu formal. Gunakan bahasa sehari-hari yang akrab bagi remaja, termasuk bahasa gaul yang relevan dan *tone* yang santai namun tetap informatif dan menghormati.

3) Singkat dan Padat

Perhatian remaja di dunia digital seringkali singkat. Sampaikan pesan-pesan kunci secara ringkas dan langsung ke poin. Gunakan kalimat pendek dan paragraf yang tidak terlalu Panjang.

4) *Mobile-First Design*

Mengingat mayoritas remaja mengakses internet melalui perangkat seluler, desain konten harus dioptimalkan untuk tampilan dan interaksi di layar kecil. Ini termasuk penggunaan *layout* responsif, ukuran *font* yang sesuai, dan navigasi yang mudah.

5) Interaktif dan Partisipatif

Konten yang memungkinkan interaksi aktif, seperti kuis, *polling*, atau elemen *tap-to-reveal*, dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi informasi.

6) Autentik dan Jujur

Remaja cenderung skeptis terhadap konten yang terasa dibuat-buat atau tidak jujur. Tampilkan keaslian dalam gaya komunikasi dan hindari klaim yang berlebihan atau tidak berdasar.

7) Inklusif dan Representatif

Pastikan visual dan bahasa yang digunakan dalam konten mencerminkan keberagaman remaja dalam hal etnis, gender, orientasi seksual, dan latar belakang sosial ekonomi. Inklusivitas membangun rasa memiliki dan relevansi.

8) Memanfaatkan Humor dengan Bijak

Humor yang tepat dan relevan dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian dan membuat topik yang sensitif lebih mudah didekati. Namun, pastikan humor tidak merendahkan atau menyinggung.

9) Konsisten dengan Identitas Kampanye

Meskipun fleksibel dalam format, konten harus tetap mempertahankan identitas visual dan *tone* suara kampanye secara keseluruhan untuk membangun pengenalan dan kepercayaan.

b. Format konten yang terbukti efektif

Beberapa format konten digital telah terbukti sangat efektif dalam menjangkau dan melibatkan remaja dalam topik kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi:

1) Infografis Interaktif dan Mudah Dipahami

Infografis menggabungkan teks dan visual untuk menyajikan informasi yang kompleks secara ringkas dan menarik. Elemen interaktif, seperti *hover-over* untuk detail tambahan atau animasi, dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman (Smiciklas, 2012). Infografis tentang siklus menstruasi, metode kontrasepsi, atau langkah-langkah pencegahan IMS dapat sangat efektif jika dirancang dengan visual yang menarik dan bahasa yang sederhana.

2) Video Pendek yang Menarik dan Menghibur (Animasi, *Live-Action*)

Video adalah format yang sangat populer di kalangan remaja. Video pendek yang menarik, baik berupa animasi yang kreatif maupun *live-action* dengan narasi yang kuat dan *relatable*, dapat menyampaikan informasi penting dengan cara yang menghibur dan mudah diingat (Schneider et al., 2016). Video testimoni dari remaja sebaya, penjelasan singkat tentang topik kesehatan reproduksi dengan animasi yang menarik, atau drama pendek yang menggambarkan situasi terkait kesehatan seksual dapat sangat efektif.

3) Ilustrasi dan *Meme* yang Relevan

Ilustrasi yang menarik dan *meme* yang relevan dengan budaya *online* remaja dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kunci dengan cara yang ringan dan mudah dibagikan. *Meme* yang informatif tentang mitos kesehatan reproduksi atau ilustrasi yang menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang sederhana dapat memiliki daya tarik yang besar.

4) Konten Berbasis Cerita (*Storytelling*)

Narasi yang kuat dan *relatable* dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan membuat informasi lebih berkesan. Berbagi cerita anonim tentang pengalaman remaja terkait kesehatan reproduksi (dengan menjaga privasi dan etika), atau menggunakan karakter fiksi yang menghadapi tantangan serupa, dapat membantu remaja merasa tidak sendirian dan lebih terbuka terhadap informasi.

5) Sesi Tanya Jawab Langsung (*Live Q&A*)

Sesi *live* dengan ahli kesehatan reproduksi di platform seperti Instagram Live, YouTube Live, atau TikTok Live memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendapatkan jawaban yang akurat dari sumber yang terpercaya. Format ini menciptakan interaksi *real-time* dan rasa komunitas (Sundar, S. S., & Sreevatsan, 2016).

6) Kuis dan *Polling* Interaktif

Kuis dan *polling* adalah cara yang menyenangkan dan menarik untuk menguji pengetahuan remaja dan mendorong partisipasi aktif. Kuis singkat tentang mitos dan fakta kesehatan reproduksi atau *polling* tentang pandangan mereka terhadap isu-isu tertentu dapat meningkatkan keterlibatan dan memicu rasa ingin tahu untuk mempelajari lebih lanjut.

7) Konten yang Dibuat oleh Pengguna (*User-Generated Content*)

Mendorong remaja untuk berbagi pengalaman, pertanyaan, atau karya kreatif mereka (misalnya, video pendek, ilustrasi, puisi) terkait kesehatan reproduksi dapat meningkatkan autentisitas dan membangun komunitas. Kampanye dapat mengadakan kontes atau *challenge* untuk mendorong partisipasi.

c. Pentingnya kredibilitas sumber informasi.

Dalam menyampaikan informasi kesehatan reproduksi, kredibilitas sumber adalah hal yang sangat penting, terutama di tengah banyaknya informasi yang tidak akurat atau menyesatkan di dunia digital. Kampanye harus secara jelas mencantumkan sumber informasi yang digunakan, memastikan bahwa sumber tersebut terpercaya (misalnya, organisasi kesehatan terkemuka, profesional medis, penelitian ilmiah), dan mengkomunikasikan kredibilitas ini kepada audiens remaja. Beberapa cara untuk membangun dan menyoroti kredibilitas meliputi:

- 1) Mencantumkan Logo dan Afiliasi: Menampilkan logo organisasi kesehatan yang kredibel atau afiliasi dengan institusi terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan.
- 2) Menyebutkan Sumber dengan Jelas: Secara eksplisit menyebutkan sumber penelitian atau panduan dari organisasi kesehatan yang digunakan sebagai dasar informasi.
- 3) Menampilkan Profil Ahli: Jika konten melibatkan ahli (misalnya, dalam video atau sesi tanya jawab), tampilkan kredensial dan afiliasi mereka.
- 4) Memberikan Tautan ke Sumber Asli: Menyertakan tautan ke situs web atau publikasi sumber informasi memungkinkan remaja untuk memverifikasi informasi lebih lanjut.

- 5) Menggunakan Bahasa yang Bertanggung Jawab: Hindari klaim sensasional atau tidak berdasar. Gunakan bahasa yang hati-hati dan akurat dalam menyampaikan informasi risiko atau manfaat.
- 6) Transparansi dalam Tujuan: Jelaskan tujuan kampanye dan organisasi di baliknya secara transparan.
- 7) Konsistensi Informasi: Pastikan informasi yang disampaikan konsisten di seluruh platform dan format konten.
- 8) Mendorong Pertanyaan dan Klarifikasi: Mengundang remaja untuk bertanya dan memberikan klarifikasi menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan diri terhadap informasi yang disampaikan.

5. Strategi Diseminasi dan Promosi Konten

Strategi diseminasi dan promosi konten memainkan peran sentral dalam memaksimalkan visibilitas, keterlibatan, dan dampak kampanye. Tanpa strategi yang tepat, konten yang berkualitas tinggi sekalipun mungkin tidak dapat mencapai remaja yang membutuhkannya.

a. Penggunaan hashtag yang relevan dan sedang tren

Hashtag (#) adalah kata atau frasa yang diawali dengan simbol pagar dan digunakan di platform media sosial untuk mengategorikan konten dan membuatnya lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari informasi tentang topik tertentu (Bruns, A., & Burgess, 2012). Penggunaan *hashtag* yang relevan dan sedang tren dapat secara signifikan meningkatkan visibilitas konten kampanye kesehatan reproduksi remaja di kalangan audiens yang tertarik pada topik tersebut atau sedang mencari informasi terkait.

Gunakan kombinasi *hashtag* yang memiliki jangkauan luas (misalnya, #kesehatanremaja, #reproduksisehat) dan *hashtag* yang lebih spesifik terkait dengan topik konten (misalnya, #kontrasepsi, #ims, #pendidikanseks). *Hashtag* spesifik membantu menjangkau audiens yang lebih tersegmentasi dan memiliki minat yang lebih kuat pada topik tersebut. Integrasikan *hashtag* secara alami dalam teks *posting*, *caption* video, atau deskripsi gambar. Hindari penggunaan *hashtag* yang berlebihan yang dapat membuat konten terlihat seperti *spam*.

b. Pemanfaatan fitur iklan berbayar di platform media sosial

Hampir semua platform media sosial menawarkan fitur iklan berbayar yang memungkinkan para pengembang kampanye untuk menargetkan audiens tertentu berdasarkan demografi, minat, perilaku *online*, dan lokasi geografis (Trusov et al., 2012). Pemanfaatan iklan berbayar dapat secara signifikan memperluas jangkauan kampanye di luar pengikut organik dan

menjangkau segmen remaja yang spesifik yang mungkin paling membutuhkan informasi kesehatan reproduksi.

- c. Kolaborasi dengan *influencer* dan KOL (*Key Opinion Leaders*) yang kredibel di kalangan remaja

Influencer dan KOL adalah individu yang memiliki pengikut signifikan dan pengaruh di media sosial atau komunitas *online* tertentu. Berkolaborasi dengan *influencer* dan KOL yang kredibel di kalangan remaja dan memiliki minat atau keahlian yang relevan dengan kesehatan reproduksi dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk menjangkau dan melibatkan target audiens. *Influencer* seringkali memiliki hubungan yang kuat dengan pengikut mereka dan dapat menyampaikan pesan kampanye dengan cara yang lebih autentik dan *relatable* (Brown, J., & De Matviuk, 2020).

- d. Strategi *cross-promotion* antar platform

Cross-promotion adalah strategi mempromosikan konten kampanye di satu platform media digital melalui platform lain yang juga digunakan oleh target audiens (Jansen et al., 2009). Memanfaatkan berbagai platform secara sinergis dapat memperluas jangkauan kampanye, mengarahkan lalu lintas antar platform, dan memperkuat pesan kampanye di berbagai titik kontak. Secara berkala membagikan konten yang relevan dari platform lain ke platform yang berbeda (misalnya, *re-tweet tweet* informatif di Facebook atau membagikan *post* Instagram di Twitter).

- e. Optimalisasi waktu posting dan frekuensi

Waktu dan frekuensi *posting* konten dapat secara signifikan mempengaruhi visibilitas dan keterlibatan audiens. Memahami kapan target audiens remaja paling aktif *online* dan berapa sering mereka cenderung berinteraksi dengan konten adalah kunci untuk mengoptimalkan strategi *posting* (Tuten, T. L., & Solomon, 2017).

D. Memanfaatkan Fitur Interaktif Media Digital untuk Keterlibatan Remaja

1. Mendorong Partisipasi Aktif

Salah satu kekuatan unik media digital terutama platform media sosial adalah kemampuannya untuk memfasilitasi partisipasi aktif dari pengguna (Jenkins et al., 2013). Berbeda dengan model komunikasi satu arah pada media tradisional, media digital memungkinkan adanya interaksi dua arah, umpan balik langsung, dan keterlibatan aktif dari audiens. Dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi remaja, mendorong partisipasi aktif tidak hanya meningkatkan *awareness* dan pemahaman, tetapi juga dapat membangun rasa kepemilikan, dukungan sebaya, dan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

- a. Menggunakan fitur komentar, polling, dan kuis untuk mengumpulkan opini dan meningkatkan keterlibatan

Hampir semua platform media sosial menyediakan fitur-fitur interaktif seperti komentar, *polling* (jajak pendapat), dan kuis yang dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mengumpulkan opini remaja, mengukur tingkat pengetahuan mereka, memicu diskusi, dan secara keseluruhan meningkatkan keterlibatan mereka dengan konten kampanye kesehatan reproduksi.

1) Fitur Komentar

Bagian komentar di bawah setiap *posting* dapat menjadi ruang yang berharga untuk mendorong remaja berbagi pendapat, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Kampanye dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang memicu pemikiran atau meminta umpan balik tentang topik tertentu. Moderasi yang aktif dan responsif dari tim kampanye sangat penting untuk memastikan diskusi tetap konstruktif, aman, dan bebas dari misinformasi atau ujaran kebencian (Naslund et al., 2016).

Memantau komentar dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pemahaman, sikap, dan kebutuhan informasi target audiens. Pertanyaan atau komentar yang sering muncul dapat mengidentifikasi area di mana kampanye perlu memberikan klarifikasi lebih lanjut atau mengembangkan konten tambahan. Mendorong interaksi positif di bagian komentar dapat membantu membangun rasa komunitas di antara remaja yang tertarik pada topik kesehatan reproduksi. Tim kampanye dapat memfasilitasi interaksi dengan mengajukan pertanyaan lanjutan, menghubungkan komentar yang relevan, dan memberikan apresiasi atas partisipasi. Contoh: Mem-*posting* pertanyaan terbuka seperti, "Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam mencari informasi tentang kesehatan reproduksi?" dan mendorong remaja untuk berbagi di kolom komentar.

2) Fitur *Polling*

Fitur *polling* memungkinkan kampanye untuk mengajukan pertanyaan dengan pilihan jawaban terbatas dan melihat hasilnya secara *real-time*. Ini adalah cara yang efektif untuk mengumpulkan opini atau preferensi audiens dengan cepat dan dalam skala besar (Pluye et al., 2018). *Polling* sederhana dengan jawaban benar atau salah dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal remaja tentang topik tertentu sebelum menyajikan informasi yang lebih detail.

Polling dengan pertanyaan yang ringan atau terkait dengan preferensi dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan membuat remaja merasa suaranya didengar. Hasil *polling* yang ditampilkan secara *real-time* dapat memicu rasa ingin tahu dan mendorong remaja untuk mempelajari lebih lanjut

tentang topik tersebut. Contoh: "Kondom efektif mencegah kehamilan dan IMS?" dengan pilihan "Benar" atau "Salah".

3) Fitur Kuis

Kuis interaktif menawarkan cara yang menyenangkan untuk menguji pengetahuan remaja tentang topik kesehatan reproduksi dan memberikan umpan balik langsung. Format kuis dapat bervariasi dari pilihan ganda hingga benar/salah atau bahkan teka-teki visual. Setelah menjawab pertanyaan, kuis dapat memberikan penjelasan singkat tentang jawaban yang benar, sehingga berfungsi sebagai alat pembelajaran yang interaktif.

Beberapa platform memungkinkan skor kuis dibagikan, yang dapat memicu kompetisi yang sehat di antara teman sebaya dan mendorong mereka untuk belajar lebih banyak. Hasil kuis secara keseluruhan dapat memberikan data berharga tentang area mana yang paling dipahami dan area mana yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dalam kampanye. Contoh: Membuat kuis mitos vs. fakta tentang kesehatan reproduksi dengan memberikan penjelasan yang benar setelah setiap jawaban.

b. Mengadakan kontes atau tantangan yang relevan dengan topik kesehatan reproduksi

Menyelenggarakan kontes atau tantangan yang kreatif dan relevan dengan topik kesehatan reproduksi dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mendorong partisipasi aktif remaja, menghasilkan konten buatan pengguna dan meningkatkan *awareness* kampanye (Jenkins et al., 2013). Kontes dan tantangan yang dirancang dengan baik dapat memanfaatkan kreativitas remaja, mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang isu-isu kesehatan reproduksi, dan berbagi perspektif mereka dengan cara yang menarik.

Pilih tema kontes atau tantangan yang relevan dengan tujuan kampanye dan menarik bagi minat remaja. Tema harus cukup spesifik untuk memberikan fokus tetapi juga cukup luas untuk memungkinkan kreativitas. Pertimbangkan berbagai format kontes atau tantangan, seperti: kontes video pendek, kontes *meme* atau ilustrasi, kontes menulis atau *storytelling* pendek, kontes seni digital, dan lain-lain. Tawarkan hadiah yang menarik bagi pemenang atau peserta terpilih. Promosikan kontes atau tantangan secara gencar di semua platform media sosial yang digunakan oleh kampanye. Gunakan *hashtag* kampanye yang unik dan *hashtag* yang relevan dengan topik dan format kontes.

Mendorong partisipasi aktif remaja melalui fitur-fitur interaktif media digital seperti komentar, *polling*, dan kuis, serta melalui penyelenggaraan kontes atau tantangan yang relevan, adalah strategi yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas kampanye kesehatan reproduksi. Dengan merancang interaksi yang menarik, relevan, dan memberikan nilai bagi remaja, kampanye dapat mengubah audiens pasif menjadi

peserta aktif, yang tidak hanya menerima informasi tetapi juga berkontribusi dalam menyebarkannya dan membangun kesadaran di antara teman sebaya mereka.

2. **Membangun Komunitas Online yang Aman dan Mendukung**

Salah satu potensi terbesar media digital dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi remaja adalah kemampuannya untuk memfasilitasi pembentukan komunitas *online* yang aman dan mendukung. Ruang digital yang terkelola dengan baik dapat menjadi tempat di mana remaja merasa nyaman untuk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan sensitif, mendapatkan dukungan sebaya, dan belajar tentang kesehatan reproduksi tanpa takut dihakimi atau mengalami stigma yang mungkin mereka hadapi di dunia nyata (Finn, J., & Barak, 2010). Membangun komunitas *online* yang aman dan mendukung memerlukan perencanaan yang cermat, implementasi strategi moderasi yang efektif, dan penyediaan mekanisme untuk anonimitas.

- a. Memoderasi diskusi dan komentar untuk mencegah perundungan dan penyebaran informasi yang salah

Moderasi yang efektif adalah kunci untuk menciptakan dan memelihara komunitas *online* yang aman dan mendukung. Tanpa moderasi yang tepat, ruang komentar dan forum diskusi dapat dengan cepat menjadi tempat perundungan (*cyberbullying*), penyebaran informasi yang salah atau berbahaya (misinformasi dan disinformasi), ujaran kebencian, dan konten yang tidak relevan atau mengganggu (Moor et al., 2017). Moderasi yang proaktif dan responsif membantu memastikan bahwa interaksi dalam komunitas tetap positif, konstruktif, dan selaras dengan tujuan kampanye kesehatan reproduksi. Adapun strategi moderasi yang efektif yaitu:

- 1) Pengembangan Pedoman Komunitas yang Jelas

Langkah pertama adalah mengembangkan pedoman komunitas yang jelas dan mudah dipahami yang menetapkan aturan perilaku yang diharapkan, termasuk apa yang dianggap sebagai perundungan, ujaran kebencian, penyebaran informasi yang salah, dan konten yang tidak pantas. Pedoman ini harus dipublikasikan secara jelas di semua ruang interaktif kampanye.

- 2) Implementasi Sistem Moderasi yang Berlapis

Pertimbangkan untuk menggunakan kombinasi moderasi otomatis dan manual. Moderasi otomatis dapat menggunakan filter kata kunci untuk mendeteksi dan menghapus komentar yang mengandung kata-kata kasar atau tidak pantas. Moderasi manual melibatkan tim moderator manusia yang secara aktif memantau diskusi, menanggapi laporan pengguna, dan menegakkan pedoman komunitas.

- 3) Pelatihan Tim Moderator

Jika menggunakan moderator manusia, pastikan mereka terlatih dengan baik dalam pedoman komunitas, teknik komunikasi yang efektif, dan cara menangani situasi yang sulit atau sensitif dengan empati dan profesionalisme.

4) Respons yang Cepat dan Konsisten

Tanggapi laporan perundungan, misinformasi, atau pelanggaran pedoman komunitas lainnya dengan cepat dan konsisten. Tindakan yang diambil harus proporsional dengan pelanggaran dan dikomunikasikan secara jelas kepada pihak yang terlibat (dengan tetap menjaga privasi).

5) Pemberdayaan Pengguna untuk Melaporkan

Sediakan mekanisme yang mudah bagi pengguna untuk melaporkan konten atau perilaku yang melanggar pedoman komunitas. Dorong pengguna untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan komunitas.

6) Penggunaan Fitur Blokir dan *Banning*

Jika seorang pengguna secara berulang kali melanggar pedoman komunitas, pertimbangkan untuk menggunakan fitur blokir atau *banning* untuk mencegah mereka berpartisipasi lebih lanjut.

7) Promosi Perilaku Positif

Selain menindak perilaku negatif, moderator juga harus secara aktif mempromosikan perilaku positif, seperti saling menghormati, memberikan dukungan, dan berbagi informasi yang akurat. Ini dapat dilakukan dengan memberikan *highlight* pada komentar yang konstruktif atau memicu diskusi positif.

8) Transparansi dalam Moderasi

Bersikap transparan tentang kebijakan dan tindakan moderasi. Jelaskan mengapa komentar dihapus atau pengguna ditindak. Transparansi membantu membangun kepercayaan dan pemahaman dalam komunitas.

9) Moderasi Proaktif

Jangan hanya menunggu laporan pengguna. Tim moderator harus secara proaktif memantau diskusi dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka meningkat.

10) Adaptasi Pedoman

Pedoman komunitas mungkin perlu ditinjau dan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan umpan balik dari komunitas.

b. Menciptakan ruang bagi remaja untuk berbagi pengalaman dan bertanya secara anonim.

Memberikan ruang bagi remaja untuk berbagi pengalaman pribadi dan mengajukan pertanyaan sensitif secara anonim dapat menjadi aspek yang sangat berharga dalam membangun komunitas *online* yang mendukung. Anonimitas dapat mengurangi rasa malu, takut dihakimi, atau khawatir tentang konsekuensi sosial yang

mungkin menghalangi remaja untuk terbuka tentang isu-isu kesehatan reproduksi mereka. Berikut merupakan strategi menciptakan ruang anonim:

1) Forum Diskusi Anonim

Membuat forum diskusi terpisah di mana pengguna dapat berpartisipasi tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka (misalnya, menggunakan nama samaran atau *username* yang tidak terhubung dengan informasi pribadi).

2) Fitur Tanya Jawab Anonim

Menyediakan fitur di mana remaja dapat mengirimkan pertanyaan secara anonim kepada tim kampanye atau ahli kesehatan yang berpartisipasi, dan jawaban dapat dipublikasikan secara umum (tanpa mengungkapkan identitas penanya) atau dikirimkan secara pribadi.

3) Aplikasi Pesan Terenkripsi dengan Opsi Anonim

Memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara anonim dalam grup dukungan yang dimoderasi.

4) Kotak Saran Anonim

Menyediakan kotak saran digital anonim di mana remaja dapat berbagi pengalaman, memberikan umpan balik, atau mengajukan pertanyaan tanpa meninggalkan informasi pribadi.

5) Sesi *Live Q&A* dengan Opsi Pertanyaan Anonim

Selama sesi tanya jawab langsung, pastikan ada opsi bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan secara anonim melalui fitur *chat*.

6) Moderasi yang Sensitif terhadap Anonimitas

Moderator dalam ruang anonim harus sangat berhati-hati untuk tidak secara tidak sengaja mengungkapkan informasi pribadi pengguna dan untuk menjaga kerahasiaan.

3. **Memanfaatkan Fitur Live untuk Edukasi dan Diskusi Langsung**

Fitur *live* (siaran langsung) yang tersedia di berbagai platform media digital menawarkan peluang unik untuk berinteraksi dengan audiens remaja secara *real-time*, menciptakan pengalaman yang lebih personal, otentik, dan menarik. Dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi, sesi *live* dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi secara langsung dari para ahli, memfasilitasi diskusi interaktif, menjawab pertanyaan secara spontan, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens. Sifat *real-time* dari fitur *live* dapat meningkatkan rasa keterlibatan, mendorong partisipasi aktif, dan membuat informasi terasa lebih relevan dan mudah diakses oleh remaja (Loman, S., & Muhonen, 2021).

a. Mengundang ahli kesehatan reproduksi untuk sesi tanya jawab

Mengundang ahli kesehatan reproduksi yang kredibel dan *relatable* bagi remaja untuk sesi tanya jawab langsung (*Live Q&A*) adalah cara yang ampuh untuk menyediakan informasi yang akurat, menjawab pertanyaan-pertanyaan sensitif, dan membangun kepercayaan audiens. Sesi *live Q&A* memberikan kesempatan bagi remaja untuk berinteraksi langsung dengan para ahli, mengajukan pertanyaan secara anonim, dan mendapatkan jawaban yang terpercaya dalam waktu nyata. Manfaat sesi *live Q&A* dengan ahli yaitu:

- 1) Informasi yang Akurat dan Terpercaya: Menyediakan akses langsung ke ahli kesehatan reproduksi memastikan bahwa remaja menerima informasi yang akurat dan berbasis bukti.
 - 2) Menjawab Pertanyaan Sensitif: Sesi *live* dapat menjadi ruang yang aman untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tabu atau sulit dibicarakan di tempat lain.
 - 3) Membangun Kepercayaan: Berinteraksi langsung dengan ahli dapat membantu membangun kepercayaan audiens terhadap kampanye dan sumber informasi yang disajikan.
 - 4) Meningkatkan Keterlibatan: Sifat *real-time* dan interaktif dari sesi *live* dapat meningkatkan keterlibatan audiens secara signifikan.
 - 5) Mencapai Audiens yang Lebih Luas: Dengan promosi yang tepat, sesi *live* dapat menjangkau audiens remaja yang lebih luas daripada konten statis.
 - 6) Mendobrak Batasan Geografis: Fitur *live* memungkinkan ahli dan audiens untuk berinteraksi tanpa batasan geografis.
- b. Mengadakan webinar atau diskusi interaktif

Webinar (seminar *web*) dan diskusi interaktif melalui fitur *live* menawarkan format yang lebih terstruktur untuk menyampaikan informasi yang lebih mendalam dan memfasilitasi diskusi yang lebih terfokus tentang topik-topik kesehatan reproduksi. Format ini memungkinkan penggunaan presentasi visual, berbagi layar, dan interaksi yang lebih terorganisir dengan audiens. Manfaat *webinar* atau diskusi interaktif yaitu:

- 1) Penyampaian Informasi yang Mendalam: Format ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik kesehatan reproduksi.
- 2) Interaksi yang Terstruktur dan Terfokus: Diskusi dapat dipandu dan difokuskan pada aspek-aspek tertentu dari topik.
- 3) Peluang untuk Pembelajaran Kolaboratif: Diskusi interaktif memungkinkan remaja untuk belajar dari perspektif dan pengalaman teman sebaya mereka.
- 4) Membangun Komunitas yang Lebih Erat: Partisipasi dalam sesi yang lebih panjang dan terstruktur dapat membantu membangun hubungan yang lebih erat di antara anggota komunitas.

- 5) Meningkatkan Pemahaman dan Retensi: Kombinasi presentasi visual dan interaksi langsung dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.

Memanfaatkan fitur *live* media digital untuk edukasi dan diskusi langsung, baik melalui sesi tanya jawab dengan ahli maupun melalui *webinar* atau diskusi interaktif, adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan remaja dalam kampanye kesehatan reproduksi. Sesi *real-time* ini menawarkan kesempatan untuk menyampaikan informasi yang akurat, menjawab pertanyaan sensitif, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi interaksi yang bermakna. Dengan perencanaan yang cermat, pemilihan narasumber yang tepat, penggunaan format yang menarik, dan moderasi yang efektif, fitur *live* dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau, mendidik, dan memberdayakan remaja dalam hal kesehatan reproduksi mereka.

4. Penggunaan Chatbots dan Asisten Virtual

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang baru untuk interaksi yang lebih personal dan responsif dalam media digital. *Chatbots* dan asisten virtual, yang didukung oleh AI, dapat diprogram untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan berbasis teks atau suara, memberikan jawaban instan atas pertanyaan, memandu pengguna melalui informasi, dan mengarahkan mereka ke sumber daya yang relevan. *Chatbots* dan asisten virtual memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan dengan menyediakan akses cepat, anonim, dan mudah ke informasi dan dukungan yang remaja butuhkan (Grassini et al., 2024).

Salah satu keunggulan utama *chatbots* dan asisten virtual adalah kemampuan mereka untuk memberikan jawaban instan atas pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Dalam topik kesehatan reproduksi, di mana remaja mungkin memiliki banyak pertanyaan mendasar atau merasa malu untuk bertanya kepada orang lain, akses cepat ke jawaban yang akurat dan terpercaya dapat sangat berharga (Bickmore et al., 2016). *Chatbots* dapat diprogram dengan basis pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi remaja, memungkinkan mereka untuk merespons pertanyaan umum secara efektif dan efisien. Selain menjawab pertanyaan umum, *chatbots* dan asisten virtual juga dapat berfungsi sebagai pemandu yang efektif untuk mengarahkan remaja ke sumber informasi yang lebih mendalam dan terpercaya tentang kesehatan reproduksi. Ini sangat penting mengingat banyaknya informasi yang tidak akurat atau menyesatkan yang beredar *online*.

Chatbots dapat diprogram untuk mengenali pertanyaan yang memerlukan informasi lebih lanjut atau dukungan dari sumber yang kredibel dan memberikan tautan atau arahan yang sesuai. Sumber-sumber ini dapat mencakup situs web organisasi kesehatan (seperti WHO, Kementerian Kesehatan), platform edukasi kesehatan yang terpercaya, layanan konseling *online*, atau informasi kontak untuk

klินิก atau pusat kesehatan remaja. Meskipun *chatbots* menawarkan banyak manfaat, penting untuk mempertimbangkan implikasi etis dan privasi dalam penggunaannya, terutama dalam konteks kesehatan reproduksi remaja yang sensitif.

E. Pertimbangan Etis dan Keamanan dalam Kampanye Digital untuk Remaja

1. Privasi dan Perlindungan Data Remaja

Dalam merancang dan melaksanakan kampanye digital yang menargetkan remaja, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi, privasi dan perlindungan data remaja harus menjadi prioritas utama. Remaja, sebagai kelompok usia yang rentan, memiliki hak khusus atas privasi dan perlindungan informasi pribadi mereka. Pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data remaja tidak hanya dapat merusak kepercayaan mereka terhadap kampanye, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan bahkan hukum yang serius (Livingstone et al., 2011).

Setiap kampanye digital yang menargetkan remaja harus mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku di wilayah hukum tempat kampanye beroperasi dan di mana target audiens berada. Peraturan ini dirancang untuk melindungi hak individu atas privasi dan mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Sebagai contoh yaitu Peraturan Perlindungan Data Pribadi (PDPL) Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: Menetapkan prinsip-prinsip dan aturan mengenai perlindungan data pribadi individu di Indonesia, termasuk hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran (UU RI, 2022).

Kampanye harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menentukan usia pengguna. Jika menargetkan anak-anak di bawah usia yang ditentukan oleh peraturan, kampanye harus mendapatkan izin orang tua atau wali yang dapat diverifikasi sebelum mengumpulkan informasi pribadi apa pun. Proses perolehan izin harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan informasi yang cukup tentang praktik pengumpulan dan penggunaan data. Kampanye hanya boleh mengumpulkan data pribadi remaja yang benar-benar diperlukan untuk tujuan kampanye yang sah dan telah diinformasikan kepada pengguna (atau orang tua/wali). Hindari pengumpulan data yang berlebihan atau tidak relevan.

Transparansi adalah prinsip etis dan hukum yang mendasar dalam perlindungan data. Kampanye digital untuk remaja harus bersikap terbuka dan jujur tentang bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data pribadi remaja. Transparansi membangun kepercayaan dan memungkinkan remaja (dan

orang tua/ wali) untuk membuat keputusan yang informatif tentang partisipasi mereka dalam kampanye.

Transparansi bukan hanya tentang memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dengan audiens remaja. Ketika remaja merasa bahwa kampanye bersikap jujur dan terbuka tentang praktik data mereka, mereka lebih mungkin untuk merasa aman dan nyaman berinteraksi dengan kampanye. Kepercayaan ini sangat penting untuk keterlibatan yang berkelanjutan dan efektivitas pesan-pesan kesehatan reproduksi.

Privasi dan perlindungan data remaja adalah fondasi etis dan hukum yang tidak dapat dikompromikan dalam kampanye kesehatan reproduksi digital. Kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data yang berlaku dan komitmen terhadap transparansi dalam pengumpulan serta penggunaan data adalah kunci untuk membangun kepercayaan, menghormati hak-hak remaja, dan memastikan keamanan informasi pribadi mereka. Kampanye yang memprioritaskan privasi dan transparansi tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan audiens remaja mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari upaya kampanye.

2. Persetujuan dan Informed Consent

Dalam konteks kampanye digital yang menargetkan remaja, terutama yang melibatkan representasi visual atau naratif dari remaja itu sendiri, informed consent menjadi pertimbangan etis yang sangat krusial. Menampilkan remaja dalam materi kampanye (misalnya, foto, video, studi kasus, kutipan) tanpa persetujuan yang tepat atau tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana representasi mereka akan digunakan dapat melanggar hak privasi, martabat, dan kesejahteraan mereka (Livingstone, S., & Blum-Ross, 2018).

Menampilkan remaja dalam materi kampanye kesehatan reproduksi digital dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat pesan lebih relatable, autentik, dan menarik bagi audiens sebaya mereka. Tindakan ini juga membawa tanggung jawab etis yang signifikan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan remaja yang ditampilkan dilindungi.

Remaja, meskipun masih dalam tahap perkembangan, memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri, terutama yang berkaitan dengan tubuh dan privasi mereka. Menampilkan mereka dalam kampanye tanpa persetujuan yang sukarela dan berdasarkan informasi yang cukup melanggar otonomi mereka (Beauchamp, T. L., & Childress, 2013). Tindakan menampilkan remaja dalam kampanye harus bertujuan untuk memberikan manfaat, baik bagi remaja yang ditampilkan

(misalnya, memberdayakan mereka untuk berbagi pengalaman positif) maupun bagi audiens yang lebih luas (misalnya, memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami). Dengan mengikuti proses persetujuan yang etis, transparan, dan sesuai usia, kampanye dapat memastikan bahwa mereka melibatkan remaja dengan cara yang bertanggung jawab, menghormati hak-hak mereka, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka.

3. Mencegah Penyebaran Misinformasi dan Hoax

Di era digital yang dipenuhi dengan banjir informasi, membedakan antara fakta dan fiksi menjadi semakin menantang, terutama bagi remaja yang mungkin memiliki tingkat literasi digital dan kesehatan yang bervariasi (Chou et al., 2018). Penyebaran misinformasi dan hoax tentang kesehatan reproduksi dapat memiliki konsekuensi yang berbahaya bagi pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja (Vraga, E. K., & Bode, 2017). Kampanye digital yang bertanggung jawab harus secara aktif berupaya mencegah penyebaran informasi yang salah dan membangun kepercayaan terhadap sumber informasi yang kredibel.

Mengingat cepatnya penyebaran informasi di media sosial dan platform digital lainnya, kampanye kesehatan reproduksi remaja perlu memiliki strategi yang jelas dan efektif untuk memverifikasi informasi yang mereka sebar dan untuk menangani konten yang salah atau menyesatkan yang mungkin beredar di kalangan audiens mereka. Berikut merupakan strategi verifikasi informasi:

a. Mengandalkan Sumber yang Kredibel

Semua informasi yang disajikan dalam materi kampanye harus berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya, seperti organisasi kesehatan nasional dan internasional (misalnya, WHO, UNICEF, Kementerian Kesehatan), badan penelitian terkemuka, publikasi ilmiah yang ditinjau oleh sejawat (*peer-reviewed*), dan ahli kesehatan reproduksi yang diakui. Selalu cantumkan sumber informasi dengan jelas.

b. *Cross-Check* Informasi

Sebelum menyebarkan informasi, terutama jika berasal dari sumber yang kurang dikenal, lakukan *cross-check* dengan membandingkannya dengan informasi dari beberapa sumber kredibel lainnya untuk memastikan konsistensi dan akurasi.

c. Evaluasi Bukti

Perhatikan jenis bukti yang mendukung klaim kesehatan. Informasi yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang kuat (misalnya, studi terkontrol secara acak, meta-analisis) umumnya lebih dapat dipercaya daripada opini pribadi atau anekdot.

d. Perhatikan Bias

Evaluasi potensi bias dalam sumber informasi apakah sumber tersebut memiliki agenda tertentu yang dapat mempengaruhi informasi yang disajikan. Sumber yang independen dan transparan umumnya lebih disukai.

e. Periksa Tanggal Publikasi

Informasi kesehatan dapat berubah seiring dengan adanya penelitian baru. Pastikan informasi yang digunakan masih terkini dan relevan. Periksa tanggal publikasi atau pembaruan terakhir dari sumber.

f. Gunakan Alat Verifikasi Fakta

Biasakan diri dengan alat dan situs web verifikasi fakta (*fact-checking*) yang kredibel. Jika ada keraguan tentang keakuratan suatu informasi, periksa melalui sumber-sumber ini.

g. Libatkan Ahli

Jika memungkinkan, libatkan ahli kesehatan reproduksi untuk meninjau dan memvalidasi informasi yang akan disebar oleh kampanye.

Selain mencegah penyebaran misinformasi, kampanye juga harus secara aktif berupaya membangun dan memelihara kepercayaan audiens remaja terhadap sumber informasi yang kredibel, termasuk kampanye itu sendiri dan organisasi atau ahli yang mereka rujuk. Kepercayaan adalah fondasi bagi keterlibatan yang efektif dan penerimaan pesan-pesan kesehatan. Membangun kepercayaan terhadap sumber informasi yang kredibel juga melibatkan upaya untuk meningkatkan literasi media dan kesehatan di kalangan remaja. Kampanye dapat menyediakan sumber daya dan edukasi untuk membantu remaja mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi kesehatan *online*.

4. Mengatasi Konten Negatif dan Ujaran Kebencian

Meskipun media digital menawarkan banyak manfaat untuk menjangkau dan melibatkan remaja dalam kampanye kesehatan reproduksi, platform *online* juga rentan terhadap konten negatif, termasuk perundungan siber (*cyberbullying*), komentar yang merendahkan, disinformasi yang berbahaya, dan ujaran kebencian yang menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka (Hinduja, S., & Patchin, 2015). Konten negatif semacam itu dapat menciptakan lingkungan *online* yang tidak aman, tidak mendukung, dan bahkan merusak bagi remaja, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas kampanye dan kesejahteraan audiens. Oleh karena itu, kampanye digital yang bertanggung jawab harus memiliki strategi yang komprehensif untuk mengatasi konten negatif dan ujaran kebencian, memoderasi diskusi secara efektif,

melaporkan konten yang berbahaya, dan secara aktif mempromosikan lingkungan *online* yang positif dan inklusif. Moderasi konten yang efektif adalah kunci untuk menjaga ruang *online* kampanye tetap aman dan mendukung bagi remaja. Strategi moderasi yang baik harus proaktif dalam mencegah konten berbahaya muncul dan reaktif dalam menanggapi konten yang dilaporkan (Roberts, 2019).

Mengatasi konten negatif tidak hanya tentang moderasi dan pelaporan saja, penting juga untuk secara aktif mempromosikan lingkungan *online* yang positif, inklusif, dan mendukung bagi semua remaja. Hal ini menciptakan budaya komunitas yang menghargai perbedaan, mendorong interaksi yang hormat, dan merayakan keberagaman. Sediakan tautan dan informasi tentang sumber daya dukungan bagi remaja yang mungkin mengalami konten negatif atau ujaran kebencian, seperti layanan konseling *online*, nomor telepon bantuan, atau organisasi anti-perundungan.

5. Dampak Psikologis Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan remaja, menawarkan peluang untuk koneksi sosial, pembelajaran, dan hiburan (Rideout, V. J., & Fox, 2018). Namun, di balik manfaatnya, terdapat pula potensi dampak psikologis negatif yang perlu dipertimbangkan secara serius, terutama dalam konteks kampanye kesehatan reproduksi digital yang menargetkan kelompok usia yang rentan ini (Twenge, 2019). Kampanye yang bertanggung jawab harus memiliki kesadaran yang mendalam tentang potensi dampak negatif penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja, seperti kecemasan dan perbandingan sosial, serta secara aktif mempromosikan penggunaan media sosial yang sehat dan seimbang.

Penggunaan media sosial yang berlebihan atau tidak sehat telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan mental pada remaja, termasuk peningkatan kecemasan dan kecenderungan untuk terlibat dalam perbandingan sosial yang merugikan (Primack et al, 2017). Kampanye kesehatan reproduksi digital, yang seringkali membahas topik-topik sensitif terkait tubuh, hubungan, dan identitas, perlu menyadari bagaimana interaksi di media sosial dapat memperburuk kerentanan ini.

a. Paparan Berlebihan pada Informasi Negatif

Media sosial dapat menjadi saluran penyebaran berita negatif, drama antarpribadi, dan konten yang memicu kecemasan. Remaja yang terus-menerus terpapar pada hal-hal ini dapat mengalami peningkatan tingkat stres dan kecemasan (Ohlschlager, G., & Torok, 2020). Dalam konteks kesehatan

reproduksi, paparan informasi yang menakutkan atau tidak akurat tentang IMS atau konsekuensi perilaku seksual dapat memicu kecemasan yang tidak perlu.

b. Ketakutan Ketinggalan (*Fear of Missing Out* - FOMO)

Media sosial seringkali menampilkan kehidupan orang lain yang tampak ideal dan menyenangkan, yang dapat memicu FOMO pada remaja. Perasaan ketinggalan ini dapat menyebabkan kecemasan, ketidakpuasan, dan kebutuhan konstan untuk memeriksa *update* media sosial (Przybylski et al., 2013). Dalam konteks kesehatan reproduksi, remaja mungkin merasa cemas jika mereka merasa tidak memiliki informasi atau pengalaman yang sama dengan teman sebaya yang mereka lihat di media sosial.

c. Tekanan untuk Tampil Sempurna

Media sosial seringkali menjadi tempat di mana individu menampilkan versi diri mereka yang paling terkurasi dan ideal. Tekanan untuk mempertahankan citra *online* yang sempurna dapat menyebabkan kecemasan, terutama terkait dengan penampilan fisik, hubungan, atau pencapaian (Fardouly et al., 2018). (Fardouly et al., 2018). Dalam kampanye kesehatan reproduksi, menampilkan citra tubuh atau hubungan yang tidak realistis dapat memperburuk kecemasan remaja terkait dengan norma-norma yang tidak sehat.

d. Perundungan Siber dan Pelecehan *Online*

Media sosial dapat menjadi platform untuk perundungan siber dan pelecehan *online*, yang dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam pada korban, termasuk kecemasan, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri (Patchin, J. W., & Hinduja, 2011). Kampanye harus secara aktif memerangi perilaku ini di ruang *online* mereka.

e. Gangguan Tidur

Penggunaan media sosial di malam hari telah dikaitkan dengan gangguan tidur pada remaja, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan (Hale, L., & Guan, 2015). Kampanye perlu mempertimbangkan waktu *posting* dan mendorong kebiasaan penggunaan media sosial yang sehat.

Kampanye harus menyadari bahwa konten dan interaksi mereka di media sosial dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada kecemasan dan perbandingan sosial di kalangan remaja jika tidak dikelola dengan hati-hati. Misalnya, menampilkan citra tubuh yang sangat ideal atau hubungan yang sempurna dapat memicu perasaan tidak aman. Diskusi yang tidak dimoderasi

dapat dengan cepat mengarah pada perbandingan yang merugikan atau komentar yang merendahkan.

Mengingat peran sentral media sosial dalam kehidupan remaja, kampanye tidak harus menghindari platform ini sepenuhnya. Sebaliknya, fokus harus diberikan pada promosi penggunaan media sosial yang sehat dan seimbang, yang meminimalkan risiko psikologis negatif dan memaksimalkan potensi positifnya. Kampanye dapat menyediakan konten edukatif yang meningkatkan kesadaran remaja tentang potensi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental, termasuk kecemasan dan perbandingan sosial. Ini dapat membantu remaja menjadi lebih sadar diri tentang kebiasaan *online* mereka. Kampanye juga dapat bekerja sama dengan orang tua dan pengasuh untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak psikologis media sosial pada remaja dan untuk memberikan panduan tentang cara mendukung penggunaan yang sehat di rumah.

F. Studi Kasus Kampanye Kesehatan Reproduksi Digital (“Aku Bertanya”)

Studi kasus ini bertujuan untuk mengeksplorasi contoh-contoh kampanye kesehatan reproduksi digital yang telah mencapai keberhasilan signifikan, baik dalam konteks Indonesia maupun internasional. Melalui analisis mendalam terhadap strategi, taktik, dan hasil yang dicapai, kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi untuk kampanye serupa di masa depan.

"Aku Bertanya" adalah kampanye digital yang diinisiasi oleh Rutgers Indonesia, bekerja sama dengan berbagai mitra, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja Indonesia tentang kesehatan seksual dan reproduksi (KSR). Kampanye ini menyadari adanya kesenjangan informasi yang seringkali diisi oleh mitos dan informasi yang salah di kalangan remaja Indonesia (Rutgers Indonesia, n.d.).

Kampanye ini memanfaatkan berbagai platform digital yang populer di kalangan remaja Indonesia, termasuk Instagram, Twitter (X), YouTube, TikTok, dan situs web interaktif (akubertanya.id). Pemilihan platform didasarkan pada preferensi dan kebiasaan penggunaan media sosial target audiens (Gemilang Sehat, n.d.). Target audiens adalah remaja dan kaum muda di Indonesia, dengan fokus pada usia 15-24 tahun. Kampanye ini secara khusus berusaha menjangkau mereka yang mungkin memiliki akses terbatas ke informasi KSR yang akurat melalui jalur tradisional (UNFPA Indonesia, 2019).

"Aku Bertanya" secara strategis hadir di berbagai platform digital yang populer di kalangan remaja Indonesia. Ini memastikan jangkauan yang lebih luas dan

memungkinkan kampanye untuk berinteraksi dengan audiens di mana mereka sudah aktif. Kampanye ini menciptakan konten yang relevan dengan minat dan kebutuhan remaja Indonesia, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, visual yang menarik, dan format yang beragam (misalnya, video pendek, infografis, kuis interaktif). Penggunaan influencer dan kolaborasi dengan tokoh muda populer juga menjadi taktik untuk meningkatkan daya Tarik (Sudarma, M., & Yuwono, 2020).

Nama "Aku Bertanya" mencerminkan strategi untuk mendorong remaja mengajukan pertanyaan tentang KSR tanpa rasa takut atau malu. Fitur tanya jawab anonim dan interaksi aktif di media sosial menciptakan ruang yang aman untuk diskusi. Kolaborasi dengan berbagai organisasi dan influencer memperluas jangkauan kampanye dan meningkatkan kredibilitas pesan (Valente, 2012).

Konten kampanye seringkali menggunakan bahasa gaul dan merujuk pada tren populer di kalangan remaja Indonesia, membuat pesan lebih relatable dan mudah diterima (Wardoyo, R., & Sujatmiko, 2018). Penggunaan warna-warna cerah, ilustrasi menarik, dan video berkualitas tinggi membantu menarik perhatian remaja di tengah feed media sosial yang padat. Sesi live dengan ahli kesehatan reproduksi di Instagram atau YouTube memberikan kesempatan bagi remaja untuk bertanya langsung dan mendapatkan jawaban yang akurat (Nasir, S. S., & Nazir, 2019). Penggunaan hashtag seperti #AkuBertanya membantu menciptakan identitas kampanye dan memudahkan audiens untuk mencari dan berbagi konten terkait.

Kampanye ini dilaporkan berhasil meningkatkan kesadaran remaja tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi remaja, seperti kesehatan menstruasi, kontrasepsi, IMS, dan hak-hak reproduksi (Rutgers Indonesia, n.d.). Tingkat keterlibatan (likes, komentar, share, pertanyaan) pada konten "Aku Bertanya" secara konsisten tinggi, menunjukkan bahwa pesan kampanye resonan dengan audiens (analisis media sosial kampanye). Kampanye berhasil menciptakan ruang online di mana remaja merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berdiskusi tentang topik-topik sensitif terkait kesehatan reproduksi remaja. "Aku Bertanya" berhasil membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai organisasi dan influencer, memperluas jangkauan dan dampak kampanye dari waktu ke waktu. Meskipun sulit diukur secara langsung, peningkatan pengetahuan dan sikap yang lebih positif diharapkan berkontribusi pada perubahan perilaku kesehatan reproduksi yang lebih baik di kalangan remaja dalam jangka Panjang (Fishbein, M., & Ajzen, 2010).

G. Penutup

Pada bab-bab sebelumnya telah menggarisbawahi peran transformatif media digital dalam menjangkau, mendidik, dan memberdayakan remaja terkait kesehatan

reproduksi mereka. Dari potensi jangkauan yang tak terbatas hingga kemampuan untuk menciptakan keterlibatan yang personal dan interaktif, media digital menawarkan alat yang ampuh untuk mengatasi tantangan tradisional dalam penyampaian informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada generasi muda.

Pertimbangan etis yang mendasar, tantangan keamanan online, dan kompleksitas dalam mengukur dampak yang sesungguhnya menuntut pendekatan yang cermat, bertanggung jawab, dan berbasis bukti. Keberhasilan kampanye kesehatan reproduksi digital untuk remaja tidak hanya terletak pada pemanfaatan teknologi itu sendiri, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, perilaku, dan konteks kehidupan remaja di era digital.

Melihat ke depan, evolusi teknologi dan perubahan perilaku remaja akan terus membentuk lanskap kampanye kesehatan digital. Inovasi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan integrasi dengan perangkat wearable menjanjikan cara-cara baru yang menarik dan efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan reproduksi. Keterlibatan aktif remaja dalam proses desain kampanye dan fokus yang lebih besar pada literasi media dan kesehatan mental akan menjadi semakin penting.

Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap remaja memiliki akses ke informasi kesehatan reproduksi yang akurat, komprehensif, dan tanpa stigma. Media digital, jika dimanfaatkan dengan bijak dan etis, memiliki potensi yang luar biasa untuk mewujudkan hal ini. Dengan terus belajar, beradaptasi, berkolaborasi, dan yang terpenting, dengan selalu mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak remaja, kita dapat mengukir masa depan di mana generasi muda Indonesia dan di seluruh dunia memiliki pengetahuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan reproduktif. Mari terus berinovasi dan bekerja sama untuk memanfaatkan kekuatan digital demi kesehatan dan kesejahteraan remaja saat ini dan generasi yang akan datang.

Referensi

- Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center.
- APJII. (2023). Survei Internet Indonesia 2022-2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of biomedical ethics (7th ed.). In Oxford University Press.
- Bickmore, T. W., Schulman, D., & Sidner, C. L. (2016). Modeling the relational behavior of embodied conversational agents. *AI Magazine*, 37(3), 29–40.
- Borzekowski, D. L. G., & Rickert, V. I. (2001). Adolescents, the Internet, and health- Issues of access and content. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 22(1), 49–59. [https://doi.org/10.1016/S0193-3973\(00\)00065-4](https://doi.org/10.1016/S0193-3973(00)00065-4)
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230.
- Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. In Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300166439>
- Brown, J., & De Matviuk, N. (2020). The role of social media influencers in health promotion: A scoping review. *Health Education Research*, 35(3), 247–265.
- Bruns, A., & Burgess, J. (2012). Researching news discussion on Twitter: The case of #qldfloods. *Journalism Studies*, 13(5–6), 801–814.
- Checkland, K., & Macrae, R. (2010). Involving service users in the design and evaluation of health care: A systematic review. *Health Policy*, 95(2–3), 218–227.
- Chou, W. Y. S., Oh, A., & Klein, W. M. P. (2018). Addressing health-related misinformation online: Challenges and future directions. *Health Communication*, 33(10), 1021–1031.
- Coleman, L., Bockting, W. O., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P. T., DeCuypere, G., Feldman, J. M., ... & Zucker, K. N. (2012). Standards of care for the health of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 7. *International Journal of Transgenderism*, 13(4), 165–232.
- Crystal, D. (2001). Language and the internet. Cambridge University Press.
- Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" Social capital and college students' use of online social network sites. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12(4), 1143–1168.
- Fardouly, J., Diedrichs, P. C., & Vartanian, L. R. (2018). The relationship between body image concerns and social media use: A systematic review and meta-analysis. *Body Image*, 27, 1–11.
- Finn, J., & Barak, A. (2010). The promise of anonymity in online support groups for

- adolescents. *New Directions for Youth Development*, 126, 47–60.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Psychology Press.
- Free, C., Phillips, G., Watson, L., Felix, L., Galli, L., Patel, V., Edwards, P., & Haines, A. (2013). The effectiveness of mobile-health technologies to improve health care service delivery processes: a systematic review and meta-analysis. *PloS Medicine*, 10(1).
- Gemilang Sehat. (n.d.). No Title. <https://gemilangsehat.org>
- Grassini, E., Buzzi, M., Leporini, B., & Vozna, A. (2024). A systematic review of chatbots in inclusive healthcare: insights from the last 5 years. *Universal Access in the Information Society*, 24(1), 195–203. <https://doi.org/10.1007/s10209-024-01118-x>
- Hale, L., & Guan, S. (2015). The association between electronic media use and sleep outcomes in adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*, 21, 50–58.
- Haynes, R. B., McKibbon, K. A., Wilczynski, N. L., Walter, S. D., & Sinclair, J. C. (2006). Systematic reviews of the literature for clinical decision. *Annals of Internal Medicine*, 145(11), 868–873.
- Highfield, Tim & Leaver, T. (2016). Instagrammatics and digital methods: Studying visual social media, from selfies and GIFs to memes and emoji. *Communication Research and Practice*, 2(1), 47–62. <https://doi.org/10.1080/22041451.2016.1155332>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2015). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying* (2nd ed.). Corwin Press.
- Jansen, B. J., Zhang, M., Sobel, K., & Chowdury, A. (2009). Twitter power: Tweets as electronic word of mouth. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(11), 2169–2188.
- Java, A., Song, X., Finin, T., & Tseng, B. L. (2007). Why we twitter: Understanding microblogging usage and communities. *Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD Workshop on Web Mining and Social Network Analysis*, 56–65.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture*. NYU Press.
- Jia, X., Pang, Y., & Liu, L. S. (2021). Online Health Information Seeking Behavior: A Systematic Review. *Healthcare (Basel)*, 9(12), 1740. <https://doi.org/10.3390/healthcare9121740>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Kreuter, M. W., & McClure, S. M. (2004). Theory-based message evaluation: Assessing

- the fit between health behavior theories and health messages. *Health Education Research*, 19(6), 661-671. (2004). Theory-based message evaluation: Assessing the fit between health behavior theories and health messages. *Health Education Research*, 19(6), 661-671.
- L'Engle, K., Mangone, E., Parcesepe, A. M., & Agarwal, S. (2016). Mobile Phone Interventions for Adolescent Sexual and Reproductive Health: A Systematic Review. *Pediatrics*, 138(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2016-0884>
- Lenhart, A., Duggan, M., Perrin, A., Stepler, R., Rainie, L., Anderson, M., & Parker, K. (2015). Teens, social media & technology overview 2015. Pew Research Center.
- Ling, R & Baron, N. (2007). Text Messaging and IM Linguistic Comparison of American College Data. *Journal of Language and Social Psychology*, 26(3), 291-298.
- Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2018). Parenting for a digital future: How hopes and fears about technology shape children's lives. Oxford University Press.
- Livingstone, S., Haddon, L., Gorzig, A., & Olafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children: Full findings and policy implications from the EU Kids Online survey. LSE.
- Livingstone, S., Van Der Nagel, E., & Helsper, E. J. (2017). Online risk, harm and opportunity: Comparing findings from the UK and EU Kids Online surveys. *Journal of Communication*, 32(1), 79-96.
- Loman, S., & Muhonen, T. (2021). Interactive live streaming for health education: A scoping review. *Education and Information Technologies*, 26(6), 7403-7423.
- Lupton, D. (2013). The quantified self. Polity Press.
- Lyles, C. R., Garcia, J., Anderson, M. L., Lehrman, W. G., & Sarkar, U. (2013). The role of social media in health crisis communication: applications, barriers, and recommendations. *American Journal of Preventive Medicine*, 45(3), 361-368.
- McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (2003). Personality in adulthood: A five-factor theory perspective. Guilford Press.
- McKenzie, J. F., & Neiger, B. L. (2013). Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: A primer. Jones & Bartlett Learning.
- Metzger, M. J., & Flanagin, A. J. (2015). Credibility and trust of information in online environments: The use of cognitive heuristics. *Journal of Pragmatics*, 59, 210-220.
- Moor, P. J., van den Hoven, E. A. W. C., van Wezel, M. C., & Benamara, F. (2017). The dark side of social media: A systematic review of negative effects of social media usage on adolescents. *Computers in Human Behavior*, 69, 341-349.
- Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. *Journal of Medical Internet*

- Research. <https://doi.org/10.2196/jmir.1933>
- Nasir, S. S., & Nazir, M. (2019). The role of social media in health awareness and promotion: A systematic literature review. *International Journal of Healthcare Management*, 12(4), 301–308.
- Naslund, J. A., Bond, T., Torous, J., Aschbrenner, K. A., Schultze, L. W., & Goff, D. C. (2016). Social media and mental health: current evidence and future directions for research. *World Psychiatry*, 15(2), 141–150.
- Nonnecke, B., & Preece, J. (2000). Lurkers vs. posters: Difference in participation and motivation between online communities. *Behaviour & Information Technology*, 19(1), 3–16.
- O'Hara, K., Massimi, M., Harper, R., & Smith, I. (2014). Everyday dwelling with WhatsApp. *Proceedings of the 2014 Conference on Designing Interactive Systems*, 115–124.
- O'Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. *Pediatrics*, 124(4), 800–804. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054>
- Ohlschlager, G., & Torok, A. (2020). Social media and anxiety: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 277, 118–129.
- Pabian, S., Vanwesenbeeck, I., Folkvord, F., Schouten, A., Ouvrein, G., van der Waal, N., Croes, E., Janssen, L., & Nanne, A. J. (2025). Social media influencers for Social media influencers for health promotion. In G.-J. de Bruijn, & H. Vandebosch (Eds.). *Health, Media, and Communication*, 49–67.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2011). Traditional and cyberbullying among adolescents: What have we learned and where do we go from here? *New Directions for Youth Development*, 2011(133), 69–81.
- Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A., Afifi, R., Allen, N. B., Arora, M., Azzopardi, P., Baldwin, W., Bonnel, C., Kakuma, R., Kennedy, E., Mahon, J., McGovern, T., Mokdad, A. H., Patel, V., Petroni, S., Reavley, N., Taiwo, K., Waldf, R. M. (2016). Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *The Lancet*, 387(10036), 2423–2478. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00579-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00579-1)
- Pluye, F., Granikov, V., & Johnson-Lafleur, J. (2018). Pluye, F., Granikov, V., & Johnson-Lafleur, J. (2018). Theories for guiding the implementation and evaluation of eHealth interventions in primary care: a systematic review. *Implementation Science*, 13(11–18).
- Potter, W. J. (2003). *The 11 myths of media violence*. Sage Publications.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants Part 1. *On the Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Primack, B. A., Shensa, A., Escobar-Viera, C. G., Barrett, E. L., Sidani, J. E., Colditz, J. B., &

- James, A. E. (2017). Association between social media use and perceived social isolation in young adults. *American Journal of Preventive Medicine*, 53(1), 1–8.
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, J. B., & Gladwell, M. (2013). Motivational, emotional, and behavioral consequences of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848.
- Rideout, V. J., & Fox, S. (2018). *Generation Z: Technology use and social capital*. Pew Research Center.
- Rideout, V. J., & Robb, M. B. (2019). Digital media use in childhood: What we know now and implications for research and policy. *Applied Developmental Science*, 23(1), 1–18. (2019). Digital media use in childhood: What we know now and implications for research and policy. *Applied Developmental Science*, 23(1), 1–18.
- Roberts, S. T. (2019). *Behind the screen: Content moderation in the shadows of social media*. Yale University Press.
- Rutgers Indonesia. (n.d.). No Title. <https://rutgers.international>
- Schneider, L. A., Dumont, A., Feltes, C. M., & Steuerwald, L. (2016). Engaging adolescents with video: Recommendations for health care providers. *Journal of Pediatric Health Care*, 30(6), 575–580. (2016). Engaging adolescents with video: Recommendations for health care providers. *Journal of Pediatric Health Care*, 30(6), 575–580.
- Sewak, A., Yousef, M., Deshpande, S., Seydel, T., & Hashemi, N. (2023). The effectiveness of digital sexual health interventions for young adults: a systematic literature review (2010-2020). *Health Promotion International*, 38(1). <https://doi.org/10.1093/heapro/daac104>
- Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram use, depressive symptoms, body image dissatisfaction, and fear of missing out. *International Journal of Mobile Human Computer Interaction (IJMHCI)*, 8(2), 51–63.
- Smiciklas, M. (2012). *The power of infographics: Using visuals to communicate and connect with your audience*. Que Publishing.
- Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. (2008). Online communication and adolescent relationships. *The Future of Children*, 18(1), 119–146.
- Subramaniam, M., Tang, F., Rodriguez, R. J., & Sena, A. (2019). “It’s easier to talk to someone you don’t know”: Adolescents’ perspectives on using online platforms for sexual health information and support. *Journal of Adolescent Health*, 64(6), 736–742.
- Sudarma, M., & Yuwono, T. (2020). The influence of social media influencers on youth behavior: A literature review. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 155–168.
- Sundar, S. S., & Kalyanaraman, S. (2004). Arousal, memory for Web advertising, and the

- mediating role of attentional focus. *Journal of Advertising*, 33(1), 37–50.
- Sundar, S. S., & Sreevatsan, A. (2016). Why do people “like”? Probing the motivations for liking on Facebook. *Computers in Human Behavior*, 59, 129–136.
- Theiventhiran, D., Bartfay, W.J., Haddad, C.B., & Wu, T. (2020). The Digital Divide: Examining the Use and Access to E-Health Based Technologies by Millennials and Older Adults. *South Asian Research Journal of Nursing and Healthcare*, 2(1), 31–37.
- Trusov, M., Bucklin, R. E., & Pauwels, K. (2012). Effects of online social media on brand building: Evidence from a field experiment. *International Journal of Research in Marketing*, 29(4), 315–327.
- Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). *Social media marketing*. Sage Publications.
- Twenge, J. M. (2019). Generation Me: Why today’s young Americans are more confident, assertive, entitled--and more miserable than ever before. In Simon and Schuster.
- UNFPA. (2020). Adolescent sexual and reproductive health: A global review of progress in the implementation of the ICPD Programme of Action.
- UNFPA Indonesia. (2019). *Laporan Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*.
- UU RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Valente, T. W. (2012). Network interventions. *Science*, 337(6090), 49–53.
- Van Deursen, A. J. A. M., & Van Dijk, J. A. G. M. (2014). Digital divide research, achievements and shortcomings. *Poetics*, 42(6), 526–546.
- Van Deursen, A. J. A. M., Bolle, C. L., Hegner, S., & K. (2015). Modeling habitual and addictive smartphone behavior. The role of smartphone usage types, emotional intelligence, social stress, self-regulation, age, and gender. *Computers in Human Behavior*, 45, 411–420.
- Vraga, E. K., & Bode, L. (2017). Networked resistance to correction: The role of identity and motivated reasoning in the correction of political misinformation. *Political Communication*, 34(4), 600–617.
- Wardoyo, R., & Sujatmiko, B. (2018). Penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi media sosial di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 22(1), 45–58.
- Zarei, J., Pham, T. A., & Ghapanchi, Z. (2021). The rise of TikTok: A systematic review of the literature. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100101.

Glosarium

A

Administrator: Seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara suatu sistem, jaringan, situs web, atau organisasi.

Afiliasi: Keterkaitan atau hubungan antara dua pihak atau lebih.

Aksesibilitas: Kemudahan bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik, untuk menggunakan, memahami, dan berinteraksi dengan suatu produk, layanan, lingkungan, atau informasi.

Algoritma: Serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Anekdot: Cerita singkat yang menarik atau lucu tentang suatu kejadian atau seseorang.

Anonim: Tanpa nama atau identitas yang diketahui atau diungkapkan.

Anonimitas: Keadaan atau kondisi menjadi anonim atau tidak dikenal.

Asisten Virtual: Program komputer atau aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu melalui perintah suara atau teks.

Audiens: Sekelompok orang yang hadir untuk mendengarkan atau menonton suatu presentasi, pertunjukan, atau acara lainnya.

Awareness: Kesadaran atau pengetahuan tentang sesuatu.

B

Banning: Tindakan melarang seseorang atau sesuatu untuk mengakses atau menggunakan suatu layanan, platform, atau sistem.

Baseline data: Data awal atau titik referensi yang digunakan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur perubahan, kemajuan, atau kinerja di masa mendatang.

Bias: Kecenderungan atau prasangka yang mempengaruhi penilaian atau keputusan secara tidak adil.

Blokir: Tindakan memutuskan atau menghalangi akses ke sesuatu.

C

Caption: Teks singkat yang menyertai gambar, video, atau ilustrasi, memberikan informasi tambahan, konteks, atau penjelasan.

Chatbot: Program komputer atau agen virtual yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia melalui teks atau suara.

Cross-check: Proses memverifikasi informasi dengan membandingkannya dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan kebenarannya.

Cross-promotion: Strategi pemasaran di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mempromosikan produk atau layanan masing-masing kepada audiens mereka.

Cyberbullying: Bentuk perundungan atau intimidasi yang terjadi melalui media digital, seperti media sosial, pesan instan, atau email.

D

Digital natives: Generasi yang tumbuh besar di era digital dan akrab dengan teknologi sejak usia muda.

Direct Message (DM): Pesan pribadi yang dikirim langsung dari satu pengguna ke pengguna lain dalam platform media sosial atau aplikasi perpesanan.

Diseminasi: Proses penyebaran informasi, pengetahuan, atau ide secara luas kepada khalayak.

Disinformasi: Informasi yang salah atau tidak akurat yang sengaja disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang lain.

E

Eksponensial: Berkembang atau meningkat dengan sangat cepat, di mana tingkat pertumbuhannya proporsional dengan nilai saat ini.

Eye-Catching: Menarik perhatian secara visual, mudah dilihat dan diingat.

F

Fact-checking: Proses memverifikasi kebenaran informasi atau klaim dengan memeriksa bukti dan sumber yang relevan.

Fasilitator: Seseorang yang memimpin atau memandu suatu kelompok dalam diskusi, pelatihan, atau acara lainnya.

Feed: Aliran konten yang terus diperbarui dan ditampilkan kepada pengguna di platform media sosial atau aplikasi berita.

Follow-up data: Data lanjutan atau data yang dikumpulkan setelah pengumpulan data awal atau intervensi tertentu.

FOMO (Fear of Missing Out): Kecemasan atau ketakutan yang timbul karena merasa ketinggalan informasi atau pengalaman yang sedang dialami oleh orang lain, terutama yang terlihat di media sosial.

H

Hashtag: Kata atau frasa yang diawali dengan simbol "#" (hash) dan digunakan di platform media sosial untuk mengategorikan konten dan membuatnya lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain yang tertarik pada topik yang sama.

Hoax: Informasi palsu atau berita bohong yang sengaja disebar untuk menipu atau mengelabui orang lain.

Hover-over: Fitur antarmuka pengguna di mana informasi tambahan atau interaksi muncul ketika kursor mouse diarahkan (*hover*) ke atas elemen tertentu di layar komputer atau perangkat lainnya.

I

IMS (Infeksi Menular Seksual): Infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual.

Influencer: Individu yang memiliki pengikut signifikan di media sosial atau platform online lainnya dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini atau perilaku pengikutnya melalui konten yang mereka bagikan.

Informed consent: Persetujuan sukarela yang diberikan oleh seseorang setelah menerima informasi yang cukup dan memahami risiko serta manfaat yang terlibat dalam suatu tindakan, seperti prosedur medis atau partisipasi dalam penelitian.

Inklusivitas: Praktik atau kebijakan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang perbedaan (seperti ras, agama, jenis kelamin, disabilitas), merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

J

Jargon: Kosakata khusus atau istilah teknis yang digunakan oleh kelompok tertentu.

K

Kecerdasan buatan (AI): Bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan program komputer yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, memecahkan masalah,

KOL (Key Opinion Leaders): Individu yang memiliki keahlian atau otoritas di bidang tertentu dan memiliki pengaruh signifikan terhadap opini dan perilaku pengikut atau audiens mereka.

Konten: Informasi atau materi yang disajikan melalui berbagai media, seperti teks, gambar, video, audio, atau kombinasi dari semuanya.

Kredensial: Bukti atau dokumen yang menunjukkan identitas, kualifikasi, atau otoritas seseorang.

L

Lanskap: Gambaran umum atau situasi suatu bidang, industri, atau isu tertentu.

Lifestyle: Gaya hidup atau cara seseorang menjalani kehidupannya, termasuk kebiasaan, minat, nilai-nilai, dan pilihan-pilihan yang mereka buat.

Lip-sync: Teknik menyinkronkan gerakan bibir dengan audio yang sudah direkam sebelumnya, seperti lagu atau dialog.

Literasi digital: Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan internet secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Live streaming: Penyiaran video atau audio secara langsung melalui internet, yang memungkinkan audiens untuk menonton atau mendengarkan secara *real-time*.

Live-Action: Film atau acara televisi yang menggunakan aktor manusia sebagai lawan dari animasi.

Lurking: Aktivitas mengamati atau membaca konten online tanpa berpartisipasi aktif, seperti tidak berkomentar atau berinteraksi.

M

Meme: Ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam suatu budaya. Di internet, *meme* seringkali berupa gambar, video, atau teks yang dimodifikasi secara lucu dan dibagikan secara luas.

Misinformasi: Informasi yang salah atau tidak akurat, tetapi tidak memiliki niat jahat untuk menipu. Perbedaannya dengan disinformasi terletak pada ketiadaan niat untuk menyesatkan.

Mobile-First Design: Pendekatan dalam desain web atau aplikasi yang memprioritaskan tampilan dan fungsionalitas pada perangkat seluler terlebih dahulu, baru kemudian diadaptasi untuk tampilan yang lebih besar seperti desktop.

Moderasi: Proses pengawasan, penyaringan, dan pengelolaan konten atau interaksi dalam suatu komunitas online atau platform digital untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menciptakan lingkungan yang aman dan positif.

Moderator: Orang yang bertugas untuk melakukan moderasi.

O

Orientasi seksual: Ketertarikan emosional, romantis, dan/atau seksual seseorang kepada orang lain berdasarkan jenis kelamin mereka.

P

Peer influence: Pengaruh yang diberikan oleh teman sebaya atau kelompok sosial yang memiliki usia, status, atau minat yang serupa terhadap pemikiran, perasaan, atau perilaku seseorang.

Peer-reviewed: Proses evaluasi kritis terhadap karya ilmiah, seperti artikel jurnal atau makalah konferensi, oleh para ahli di bidang yang sama sebelum dipublikasikan.

Pesan terenkripsi: Pesan yang diubah menjadi kode rahasia (enkripsi) sehingga hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai.

Platform digital: Lingkungan atau infrastruktur online yang memungkinkan interaksi, berbagi informasi, dan berbagai aktivitas lainnya melalui internet atau jaringan digital.

Podcast: Siaran audio digital yang tersedia di internet dan dapat diunduh atau didengarkan kapan saja.

Polling: Proses pengumpulan opini atau suara dari sejumlah orang tentang suatu isu atau pertanyaan tertentu.

Preferensi: Kecenderungan untuk menyukai atau memilih sesuatu daripada yang lain.

R

Realitas virtual: Teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi interaktif yang dapat dialami oleh pengguna melalui perangkat khusus seperti headset dan sensor.

Real-time: Terjadi atau diproses secara langsung tanpa penundaan yang signifikan.

Reels: Fitur pada platform media sosial (seperti Instagram dan Facebook) yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi video pendek berdurasi tertentu yang seringkali diiringi musik atau audio lainnya.

Relatable: Mudah dipahami, dihubungkan, atau dirasakan relevan oleh banyak orang karena mengandung pengalaman atau emosi yang umum.

Retensi: Seberapa lama audiens tetap terlibat dengan konten.

S

Share: Tindakan membagikan konten (seperti postingan, artikel, atau video) kepada orang lain melalui platform digital.

Spam: Pesan elektronik yang tidak diinginkan dan dikirim secara massal, biasanya berisi iklan, penipuan, atau malware.

SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*): Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu

Stereotip: Keyakinan atau gagasan umum yang disederhanakan dan seringkali negatif tentang sekelompok orang tertentu, yang tidak mempertimbangkan perbedaan individu di dalamnya.

Stigma: Sikap negatif, diskriminatif, atau merendahkan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti kondisi kesehatan mental, penyakit menular, atau afiliasi sosial.

Stories: Fitur pada platform media sosial yang memungkinkan pengguna membagikan foto atau video pendek yang bersifat sementara dan biasanya hilang setelah 24 jam.

Storytelling: Seni atau praktik menceritakan kisah untuk menyampaikan pesan, menghibur, atau menginspirasi audiens.

T

Tabu: Sesuatu yang dianggap suci, dilarang, atau tidak boleh dibicarakan atau dilakukan dalam suatu masyarakat atau budaya karena alasan moral, agama, atau sosial.

Tap-to-reveal: Fitur interaktif dalam konten digital di mana pengguna perlu mengetuk atau mengklik area tertentu untuk mengungkapkan informasi tersembunyi.

Thumbnail: Gambar kecil yang mewakili konten yang lebih besar, seperti video atau artikel.

Tweet: Pesan singkat yang dipublikasikan di platform media sosial Twitter (sekarang X).

U

UNFPA (*United Nations Population Fund*): Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak perempuan dan remaja.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*): Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk membela hak-hak anak, memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada anak-anak di seluruh dunia.

User-Generated Content: Konten yang dibuat dan dibagikan oleh pengguna suatu platform online, bukan oleh pemilik atau pengelola platform tersebut.

V

Vlog (Video Blog): Bentuk blog yang menggunakan video sebagai media utama untuk menyampaikan informasi, opini, atau pengalaman.

W

Wearable: Perangkat elektronik kecil yang dapat dikenakan di tubuh, seperti jam tangan pintar, gelang kebugaran, atau kaca mata pintar.

WHO (*World Health Organization*): Organisasi Kesehatan Dunia, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional.

Word-of-mouth: Proses penyebaran informasi atau rekomendasi dari satu orang ke orang lain melalui percakapan lisan.

BAB VII

PROGRAM SEKOLAH

DALAM MENDUKUNG EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pendahuluan

Remaja memiliki peran penting dalam pembangunan Negara yakni sebagai generasi penerus bangsa. Negara memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja, sedangkan remaja juga memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab remaja terhadap diri, maka seorang remaja sepatutnya dapat menjaga kesehatan reproduksinya agar terhindar dari permasalahan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh tidak semata terbebas dari suatu penyakit ataupun kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi dan prosesnya (World Health Organization). Kesehatan reproduksi menjadi salah satu permasalahan remaja yang membutuhkan perhatian dari semua pihak.

Masalah reproduksi menyebabkan berbagai dampak negatif seperti masalah fisik dan psikologis. Remaja yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi rentan mengalami masalah reproduksi. Remaja memerlukan pemahaman tentang kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman yakni melalui edukasi Kesehatan reproduksi remaja. Edukasi Kesehatan reproduksi remaja merupakan kegiatan pemberian informasi, pemahaman, dan keterampilan tentang Kesehatan reproduksi, seksualitas, perkembangan fisik serta emosional remaja.

Edukasi Kesehatan reproduksi salah satunya dapat dilakukan di Sekolah. Program sekolah dalam mendukung edukasi kesehatan reproduksi sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada para siswa mengenai tubuh manusia, hubungan antar individu, serta dampak sosial dan emosional dari kesehatan reproduksi. Edukasi ini bertujuan untuk mencegah risiko gangguan kesehatan reproduksi, mengurangi angka pernikahan usia dini, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban individu dalam konteks reproduksi.

B. Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi pada masa remaja merupakan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan organ reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja mulai perlu diberikan perhatian lebih ketika remaja perempuan mengalami haid pertama dan

remaja laki-laki mengalami mimpi basah. Perubahan secara fisik akan terjadi sangat cepat pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa.

Definisi remaja memiliki berbagai variasi menurut negara, budaya dan kelompok. Definisi remaja di tingkat nasional dan internasional juga memiliki beragam variasi. Berdasarkan rentang usia remaja akan berpotongan dengan definisi anak menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak, dimana anak didefinisikan semua individu dari sejak lahir sampai berusia 18 tahun. Sedangkan batas usia remaja menurut *World Health Organization (WHO)* yakni 12 – 24 tahun. Adapun Batasan usia remaja menurut Kemenkes RI adalah 10 – 18 tahun (Pratomo, 2022)

Pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang cepat, termasuk pertumbuhan organ-organ reproduksi (organ seksual) untuk mencapai kematangan, sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksi. Perubahan ini ditandai dengan munculnya 1) Tanda-tanda seks primer, yaitu yang berhubungan langsung dengan organ seks seperti terjadinya haid pada remaja perempuan (menarche) dan terjadinya mimpi basah pada remaja laki – laki. Adapun tanda-tanda seks sekunder pada remaja laki-laki meliputi: perubahan suara, tumbuhnya jakun, penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, dada lebih besar, badan berotot, tumbuhnya kumis, cambang, rambut disekitar kemaluan dan ketiak. Sedangkan tanda-tanda seks sekunder pada remaja perempuan meliputi: pinggul melebar, pertumbuhan rahim dan vagina, payudara membesar, tumbuhnya rambut dikietak dan sekitar kemaluan (pubis).

Remaja dikatakan sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah (*ejakulasi awal/pertama*) bagi laki-laki. Pada remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah yang disebut peristiwa ejakulasi, yaitu pengeluaran cairan kental yang disebut air mani pada saat tidur, terjadi pada usia 10-15 tahun. Sedangkan bagi perempuan dikatakan sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami menstruasi pertama (*Menarche*). Menstruasi merupakan peristiwa meluruhnya lapisan dalam dinding rahim yang keluar Bersama dengan darah dari vagina dan berlangsung antara 3 – 7 hari. (Jeepi, 2019)

Selain perubahan fisik pada masa remaja juga terjadi perubahan psikologis. Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi Perubahan emosi, hal ini menyebabkan remaja menjadi lebih sensitive (mudah menagis, cemas, frustasi, dll) serta agresif dan mudah bereaksi terhadap stimulus dari luar, hal ini dapat dicontohkan seperti mudah marah, terjadi tawuran, dll. Perubahan psikologis remaja selanjutnya adalah Perkembangan intelegensia, hal ini menyebabkan remaja menjadi mampu untuk berfikir abstrak (mengembangkan ide baru, memberikan kritik) dan meningkatkan rasa ingin tahu pada hal-hal baru sehingga timbul perilaku

ingin mencoba-coba.

Selain kondisi psikologi yang berubah kondisi fisik juga mengalami perubahan. Perubahan fisik yang cepat namun tidak dibarengi dengan perubahan psikologis yang matang, serta timbulnya dorongan rasa ingin mencoba hal – hal baru, ditambah dengan adanya stimulus dari luar menyebabkan remaja dapat bersikap dan berperilaku menyimpang. Kontrol diri dan control social sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan ini seperti Perilaku seks diluar nikah, Tawuran, Kecanduan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya termasuk alcohol dan rokok), serta gangguan Kesehatan terkait organ reproduksi yang dikarenakan kurangnya menjaga kebersihan diri (*Personal Hygien*). Dengan demikian diperlukan kemampuan pengelolaan diri yang baik agar terhindar dari masalah – masalah Kesehatan reproduksi tersebut diatas. (Iriyanto, 2015)

C. Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja

Masalah kesehatan reproduksi remaja merupakan isu yang sangat penting, mengingat periode remaja adalah masa transisi yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Pada fase ini, remaja mulai belajar dan mengembangkan pemahaman tentang tubuh mereka, serta hubungan interpersonal. Namun, banyak remaja yang kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, yang bisa berujung pada berbagai masalah kesehatan. Berikut adalah beberapa masalah kesehatan reproduksi yang sering dialami oleh remaja:

1. Pernikahan Dini dan Kehamilan Usia Muda

Pernikahan Dini: Remaja yang menikah di usia sangat muda sering kali tidak siap secara fisik, emosional, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini berisiko pada kesehatan reproduksi mereka, seperti peningkatan angka kehamilan berisiko tinggi, kelahiran prematur, dan kematian ibu.

Kehamilan Usia Muda: Kehamilan pada usia remaja sangat berisiko, baik bagi ibu maupun janin. Remaja yang hamil cenderung menghadapi komplikasi kesehatan, seperti hipertensi, anemia, dan kesulitan dalam menjalani kehamilan. Bayi yang lahir dari ibu remaja juga lebih rentan terhadap kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah.

2. Penyakit Menular Seksual (PMS)

Remaja yang aktif secara seksual dan tidak menggunakan perlindungan yang tepat berisiko tinggi terinfeksi penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, gonore, klamidia, sifilis, dan herpes. Kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan kondom atau kontrasepsi membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi tersebut. Kurangnya pengetahuan remaja salah satu penyebabnya adalah

Kurangnya Edukasi: Banyak remaja yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai cara melindungi diri mereka dari PMS, baik dalam hal penggunaan alat kontrasepsi atau pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

3. Aborsi yang Tidak Aman

Remaja yang hamil di luar nikah atau tidak siap secara mental untuk menjalani kehamilan sering memilih untuk melakukan aborsi. Aborsi yang dilakukan secara tidak aman atau ilegal dapat berakibat fatal, menyebabkan infeksi, perdarahan, bahkan kematian. Kurangnya Akses ke Layanan Kesehatan: Banyak remaja yang tidak memiliki akses atau informasi mengenai layanan kesehatan yang aman dan sah untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan. Gangguan Menstruasi dan Masalah Kesehatan Ginekologi: Remaja sering mengalami gangguan menstruasi, seperti siklus yang tidak teratur, menstruasi yang sangat banyak atau sedikit, atau nyeri menstruasi yang parah. Masalah ini dapat mengganggu kualitas hidup mereka dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis. Selain itu remaja juga dapat mengalami Endometriosis dan PCOS (Polycystic Ovary Syndrome): Beberapa remaja mungkin mengalami kondisi medis seperti endometriosis atau PCOS, yang dapat menyebabkan masalah kesuburan di masa depan jika tidak diobati dengan baik.

4. Penyalahgunaan Kontrasepsi

Penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat atau penyalahgunaan kontrasepsi dapat menjadi masalah serius bagi remaja. Penggunaan pil KB atau alat kontrasepsi lainnya tanpa pengetahuan yang cukup tentang cara penggunaannya dapat menyebabkan efek samping kesehatan, seperti gangguan hormon atau infeksi saluran reproduksi. Kurangnya Konsultasi Medis: Beberapa remaja tidak memahami pentingnya konsultasi medis sebelum memilih metode kontrasepsi yang tepat untuk mereka.

5. Kurangnya Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi

Banyak remaja yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang kesehatan reproduksi di sekolah atau rumah. Ini menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai anatomi tubuh mereka, siklus menstruasi, kehamilan, kontrasepsi, atau tanda-tanda infeksi menular seksual. Tabu dan Stigma: Masih banyak stigma dan tabu seputar pembicaraan mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi, yang membuat remaja enggan untuk mencari informasi atau berkonsultasi dengan tenaga medis.

6. Perubahan Emosional dan Psikologis

Perubahan hormonal selama masa remaja sering kali menyebabkan perubahan emosional yang intens. Remaja mungkin merasa cemas, bingung, atau tertekan tentang tubuh mereka atau hubungan seksual, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental mereka. Kekerasan Seksual dan Pelecehan: Beberapa remaja juga menghadapi masalah kekerasan seksual atau pelecehan, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik mereka tetapi juga pada kesehatan mental dan emosional.

7. Obesitas dan Pola Makan Tidak Sehat

Masalah obesitas di kalangan remaja dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Obesitas dapat menyebabkan gangguan menstruasi, ketidaksuburan, serta peningkatan risiko diabetes dan hipertensi yang berdampak pada kesuburan di masa depan. Pola Makan yang Buruk: Diet yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi.

8. Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan dalam Hubungan

Banyak remaja, terutama perempuan, yang berada dalam hubungan yang tidak sehat, di mana mereka mengalami tekanan untuk melakukan aktivitas seksual atau kekerasan fisik dan emosional. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan reproduksi mereka dan kesejahteraan mental. Penyalahgunaan dan Pemaksaan Seksual: Kekerasan seksual dalam hubungan, termasuk pemaksaan untuk berhubungan seks tanpa persetujuan, merupakan masalah besar yang harus ditangani di kalangan remaja.

Berdasarkan permasalahan yang dapat timbul pada kondisi kesehatan reproduksi remaja maka dapat di berikan solusi untuk mengatasi dan mencegah masalah kesehatan reproduksi remaja melalui:

- a. Edukasi yang Komprehensif: Program pendidikan kesehatan reproduksi yang menyeluruh di sekolah dan komunitas, yang mencakup topik-topik seperti kontrasepsi, PMS, pernikahan dini, dan hubungan yang sehat.
- b. Akses ke Layanan Kesehatan: Menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan konseling.
- c. Pemberdayaan Remaja: Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada remaja agar mereka dapat membuat keputusan yang sehat terkait kesehatan

reproduksi dan seksual mereka.

- d. Pencegahan Kekerasan Seksual: Menyediakan dukungan psikologis dan layanan perlindungan bagi remaja yang menghadapi kekerasan seksual atau kekerasan dalam hubungan.

Upaya mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja diperlukan kerjasama berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan lembaga kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja yang sehat secara fisik dan mental. Pendekatan yang paling mudah & efektif dalam upaya pencegahan masalah Kesehatan reproduksi yakni melalui sekolah, dikarenakan remaja yang masih berusia sekolah lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah.

D. Program Edukasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah

Program edukasi Kesehatan reproduksi remaja dapat dilakun dalam berbagai cara, salah satunya melalui sekolah. Peran sekolah dalam mendukung edukasi kesehatan reproduksi sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada siswa mengenai tubuh manusia, hubungan antar individu, serta dampak sosial dan emosional dari kesehatan reproduksi. Edukasi ini bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan, mengurangi angka pernikahan usia dini, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban individu dalam konteks reproduksi. Pelaksanaan program edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dapat dilakukan dengan strategi seperti berikut:

1. Intrakurikuler

- a. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Kurikulum

Pendidikana Kesehatan reproduksi dapat di Integrasi dalam Mata Pelajaran: Pendidikan kesehatan reproduksi dapat dimasukkan dalam mata pelajaran Biologi, Pendidikan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJOK). Materi yang dapat Disampaikan berupa anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, hormon, pubertas, kesehatan menstruasi, kehamilan, kontrasepsi, penyakit menular seksual (PMS), serta isu-isu terkait dengan kekerasan seksual dan hubungan sehat.

- b. Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik

Guru dan tenaga pendidik perlu dibekali pengetahuan yang tepat tentang pendidikan kesehatan reproduksi melalui kegiatan workshop dan pelatihan, dimana guru akan belajar tentang cara menyampaikan materi dengan sensitif dan tidak menimbulkan rasa malu, serta cara menjawab pertanyaan dari siswa. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi harus disampaikan dengan cara

yang sensitif terhadap budaya dan nilai-nilai yang berlaku, namun tetap berdasarkan pada fakta ilmiah.

c. Sumber Daya dan Materi Ajar

Materi pembelajaran dapat diambil dari Buku dan Modul Edukasi: Menyediakan buku atau modul edukasi yang memberikan informasi akurat tentang kesehatan reproduksi, yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Selain itu metode pembelajaran dapat memanfaatkan Video dan Multimedia: Penggunaan video, animasi, atau infografis yang menyenangkan dan informatif bisa menjadi cara yang efektif dalam menarik perhatian siswa. Pemanfaatan teknologi sebagai sumber informasi belajar bisa menggunakan Media berbasis Android: penggunaan media belajar pendidikan kesehatan reproduksi memiliki pengaruh dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Pada penelitian yang dilakukan Oktaria & Martha (2023) didapatkan hasil bahwa terdapat perubahan tingkat pengetahuan siswa sebesar 100% setelah diberikan edukasi menggunakan aplikasi. Dengan adanya media aplikasi, siswa lebih termotivasi untuk belajar kesehatan reproduksi, dimana saja dan kapan saja.

2. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler dapat digunakan sebagai edukasi Kesehatan reproduksi bagi remaja melalui Forum Diskusi: Menyelenggarakan diskusi atau seminar dengan narasumber yang ahli di bidang kesehatan reproduksi seperti dokter, psikolog, atau konselor. Ini memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan mendapatkan informasi lebih mendalam. Selain itu Kegiatan Ekstrakurikuler berupa Klub atau kelompok diskusi tentang kesehatan reproduksi bisa dibentuk untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam topik ini secara aktif.

3. Kokurikuler

Selain kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler edukasi tentang kesehatan reproduksi dapat diberikan melalui kegiatan kokurikuler. Adapun bentuk kegiatan kokurikuler yang dapat diberikan meliputi:

a. Pemberian Konseling dan Dukungan Psikologis

Pemberian dukungan psikologis dapat dilakukan melalui Layanan Konseling: Sediakan layanan konseling atau bimbingan untuk siswa yang mungkin merasa cemas atau bingung mengenai masalah kesehatan reproduksi atau hubungan interpersonal. Konselor dapat memberikan bimbingan yang bersifat pribadi dan rahasia. Selain itu pembentukan Pusat Informasi dapat juga menjadi salah satu upaya dukungan bagi remaja.

Membuat ruang khusus di sekolah untuk menyediakan literatur dan materi tentang kesehatan reproduksi yang bisa diakses oleh siswa kapan saja.

b. Kampanye Sosialisasi di Sekolah

Pemberian informasi dapat dilakukan dalam bentuk kampanye dan sosialisasi di sekolah. Kegiatan dapat berupa Kampanye Edukasi: Mengadakan kampanye melalui poster, brosur, atau kegiatan di luar ruangan yang mengedukasi siswa mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menggunakan kontrasepsi dengan benar, serta cara menghindari penyakit menular seksual. Selain itu dapat juga membuat Hari Kesehatan Reproduksi: Mengadakan hari khusus yang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti tes pengetahuan, presentasi, dan pameran.

c. Kerjasama Lintas Sektor

Suksesnya suatu program dapat diraih dengan adanya Kolaborasi dengan Instansi Kesehatan: Sekolah bisa bekerja sama dengan instansi kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, atau dinas terkait untuk menyelenggarakan seminar, penyuluhan atau pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R). Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R): merupakan sebuah wadah kegiatan remaja melalui program Generasi Berencana (GENRE) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, bertujuan memberikan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, dan kegiatan penunjang lainnya

Kegiatan Penyuluhan di Komunitas dapat dilakukan dengan Mengadakan kegiatan penyuluhan bagi orangtua dan komunitas sekolah untuk membahas pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan bagaimana mendukung anak-anak mereka dalam memahami topik ini.

d. Penerapan Kebijakan di Sekolah

Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual: Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dalam menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan edukasi kepada siswa mengenai hak-hak mereka untuk melindungi diri. Selain itu Mendukung Penggunaan Kontrasepsi dan Pencegahan Penyakit Menular Seksual dapat memberikan informasi yang tepat tentang penggunaan kontrasepsi, serta upaya pencegahan terhadap penyakit menular seksual (PMS).

Dengan berbagai pendekatan ini, diharapkan siswa bisa memperoleh pengetahuan yang cukup dan benar tentang kesehatan reproduksi, yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang sehat serta bertanggung jawab di masa depan.

E. Penutup

Kesehatan reproduksi remaja menjadi bagian penting pada masa tumbuh kembang remaja. Dimana masa ini sebagai titik tolak seseorang untuk dapat menjalani kehidupan masa dewasa yang baik. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang termasuk dalam upaya perawatan Kesehatan reproduksi. Pemahaman yang komprehensif tentang Kesehatan reproduksi dapat membantu remaja bersikap dan mengambil keputusan agar tidak terjerumus dalam perilaku berisiko. Upaya edukasi menjadi strategi pencegahan yang krusial dari berbagai masalah kesehatan reproduksi yang dapat muncul. Edukasi Kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan di sekolah ,melalui kegiatan Intrakurikuler, Ekstrakurikuler, dan Kokurikuler. Kegiatan ini melibatkan berbagai sektor dengan sasaran siswa dan juga orang tua yang diharapkan dapat menjadi pengawas, pengarah, dan pelindung bagi remaja agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang.

Referensi

- Pratomo, Hadi., Dkk. (2022). Kesehatan Reproduksi Remaja: Teori & Program Pelayanan di Indonesia. Rajawali Press.
- Rosyida, Desta Ayu Cahya. (2023). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Pustaka Baru.
- Jeepi, Norma. (2019). Buku Ajar Pengantar Asuhan Kebidanan. Trans Info Media
- Irianto, Koes. (2015). Kesehatan Reproduksi: Reproductive Health Teori & Praktikum. CV. Alfabeta.
- IDAI. (2013). Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Aspek Sosial. <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/kesehatan-reproduksi-remaja-dalam-aspek-sosial>
- Ferdian, Dani., Dkk. (2023). Edukasi Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja. PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 7 No 3
- Kamila, A., Handayani, Fatiah., Nurhayati. (2021). Analisis Penerapan Kurikulum Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berbasis Program. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Vol.10 No.4. <http://journals.stikim.ac.id/index.php/jikm>
- Uberty, Adhetya. (2022). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah. Jurmas Sains dan Teknologi Vol.3 No.3 Doi: <https://doi.org/10.47841/saintek.v3i3.222>
- Oktaria, Risma., Martha, Evi. (2023). Analisis Penggunaan Media Belajar Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berbasis Aplikasi Android dan Website: Systematic Review. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia Vo.6 No.12 DOI: <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i12.4140>
- Fatkhiyah, Natiqotu., Masturoh. (2020). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Abdimas Mahakam Journal Vol.4 No.01 DOI:<http://dx.doi.org/10.24903/jam.v4i1.776>

Profil Penulis



Dr. Hilmi Yumni, S.Kep.Ns. M.Kep.Sp.Mat.

Lahir di Gresik, 23 Agustus 1968. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, dilanjutkan ke Spesialis Keperawatan Maternitas pada Program Studi Keperawatan Maternitas Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Jakarta lulus tahun 2007. Selanjutnya melanjutkan S3 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1997. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya Jurusan Keperawatan, mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Manajemen Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan dan Etika Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop dan reviewer Jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hilmi@poltekkesdepkes-sby.ac.id

Motto: "The key to success is continuous learning"



Febrina Dwi Nurcahyanti, SST.,MPH

Lahir di Kediri, 16 Februari 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Universitas Sebelas Maret tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 prodi Kesehatan Masyarakat pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 di STIKes Bhakti Mulia Kediri sampai saat ini, mengampu mata kuliah Komunikasi, Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, Askeb Persalinan dan Nifas, ISBD, Konsep Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Manajemen dan Dasar Entrepreneur. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: febrina.d.nurcahyanti@gmail.com



Dr. Dona Martilova SST.M.Kes

Lahir di Pekanbaru, 8 Juni 1985, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis Lulus Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Rumbai Pekanbaru Tahun 1997, Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 006 Rumbai Pekanbaru Tahun 2000, Lulus SMA Negeri 003 Rumbai Pekanbaru Tahun 2003, Lulus Program Pendidikan Akademi Kebidanan Flora Medan Tahun 2006, Lulus D IV Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara Tahun 2009, Lulus S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2015 Dan Lulus S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Tahun 2025. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program studi sarjana kebidanan dan profesi bidan INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU (IKES PN) sejak tahun 2011. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu pada bidang Pendidikan mengajar pada Beberapa mata kuliah kebidanan dan kesehatan masyarakat. Pada bidang penelitian dan publikasi juga aktif dalam penelitian dan publikasi artikel, pengelola jurnal, narasumber seminar dan penulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dhonalova@gmail.com



Siti Aminah, SST., S.Pd., Bd., M.Kes,

Lahir di Bangkalan, 5 April 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Griya Husada lulus tahun 2004, Diploma IV di Program Studi Kebidanan Universitas Kadiri lulus tahun 2006, S2 di Program Studi Ilmu Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga lulus tahun 2012. Saat ini penulis sedang menempuh S3 di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Bekerja sebagai dosen di Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri sejak tahun 2006. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu pada bidang Pendidikan, penelitian dan publikasi artikel serta pengabdian masyarakat, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sitiaminah@unik-kediri.ac.id



Diyah Sri Yuhandini, S.SiT, SKM, MPd.

Lahir pada 10 September 1980 di Cirebon, Jawa Barat. Riwayat pendidikan: D III Akademi Kebidanan Depkes RI, Cirebon (2001), D IV Bidan Pendidik STIKes Ngudi Waluyo (2004), S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Cirebon (2005), S2 Magister Pendidikan UNPAK Bogor (2008). Riwayat Pekerjaan: Bidan RS. Pelabuhan Kota Cirebon (2001). Dosen di STIKes Cirebon (2001-2005), Dosen PNS di Poltekkes Jakarta I (2006 - 2009), Dosen PNS di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya (2009 - sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: diyahsriyuhandini80@gmail.com

Motto: "Menjalani hidup dengan 3B (berusaha, berdoa dan berserah)"



Asmaurika Pramuwidya, S.S.T., M.Kes.

Lahir di Mempawah, 07 Agustus 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi DIII Kebidanan 'Aisyiyah Pontianak (2008–2011), jenjang D4 pada Program Studi DIV Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM), peminatan Bidan Pendidik (2012–2013). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada S2 Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Reproduksi (2013–2015) di perguruan tinggi yang sama. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011–2012 sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan Ayniyah Mempawah, kemudian menjadi dosen di Akademi Kebidanan Singkawang (2015–2017), dan Poltekkes Kemenkes Pontianak (2017–2024). Sejak tahun 2024 sampai sekarang penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asmaurika.p@medical.untan.ac.id

Motto: "Apply yourself with diligence, innovate with wisdom, remain authentic, and continuously refine."



Bdn. Norma Jeepi Margiyanti, S.Si.T., M.Kes.

Lahir di Rembang, 27 April 1986. Penulis berlatar belakang pendidikan bidan dan melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat dengan kajian Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS Tahun 2010. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas padang. Penulis memulai karir sebagai dosen sejak tahun 2008 dan saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Institut Kesehatan Mitra Bunda dengan jabatan sebagai Ketua Program Studi Diploma Tiga Kebidanan selain itu penulis juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kesehatan Mitra Bunda (LPKMB). Disamping itu penulis juga aktif dalam berbagai organisasi yakni Ikatan Bidan Indonesia sebagai Pengurus Daerah IBI Prov. Kepulauan Riau, selain itu penulis juga terpilih sebagai Wkyl Ketua Korwil AIPKIND prov. Kepulauan Riau dan masih banyak organisasi lainnya yang penulis ikuti.

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul **“Peran Bidan dalam Kesehatan Reproduksi Remaja”** merupakan referensi komprehensif yang mengangkat peran strategis bidan dalam mendampingi dan meningkatkan kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja adalah fase kritis dalam perkembangan individu, di mana berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial terjadi secara bersamaan. Sayangnya, banyak remaja belum mendapatkan edukasi yang memadai terkait kesehatan reproduksi, yang berdampak pada munculnya berbagai risiko, seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, hingga masalah psikologis.

Melalui pendekatan yang edukatif dan berbasis komunitas, buku ini membekali bidan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang ramah remaja. Buku ini juga membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan, mulai dari konseling yang sensitif, pemanfaatan media digital, pelibatan keluarga, hingga program edukatif di sekolah sebagai bentuk intervensi holistik.

Setiap bab dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian literatur terkini dan pengalaman praktis di lapangan, menjadikannya sumber yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi panduan penting bagi bidan, mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta pemangku kebijakan yang berkomitmen pada kesehatan remaja.

Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga memberi solusi nyata dan terukur untuk membangun generasi muda yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab atas kesehatan reproduksinya.

Buku Referensi yang berjudul “Peran Bidan dalam Kesehatan Reproduksi Remaja” merupakan referensi komprehensif yang mengangkat peran strategis bidan dalam mendampingi dan meningkatkan kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja adalah fase kritis dalam perkembangan individu, di mana berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial terjadi secara bersamaan. Sayangnya, banyak remaja belum mendapatkan edukasi yang memadai terkait kesehatan reproduksi, yang berdampak pada munculnya berbagai risiko, seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, hingga masalah psikologis.

Melalui pendekatan yang edukatif dan berbasis komunitas, buku ini membekali bidan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang ramah remaja. Buku ini juga membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan, mulai dari konseling yang sensitif, pemanfaatan media digital, pelibatan keluarga, hingga program edukatif di sekolah sebagai bentuk intervensi holistik.

Setiap bab dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian literatur terkini dan pengalaman praktis di lapangan, menjadikannya sumber yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi panduan penting bagi bidan, mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta pemangku kebijakan yang berkomitmen pada kesehatan remaja.

Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga memberi solusi nyata dan terukur untuk membangun generasi muda yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab atas kesehatan reproduksinya.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96029-8-3



9

786349

602983